UNIMED CHAPECÓ

MANUAL DE GESTÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES INTERNOS OU EXTERNOS

2ª Edição

Chapecó, SC

2022

Este documento quando impresso só é válido com carimbo e assinatura

Controle de revisões		
Data Elaboração	**Data Revisão**	**Motivo**
Fev/2019	06/03/2020	4
	07/03/2022	4

Motivos:
1 - Atendimento à legislação
2 - Incorporação de nova atividade
3 - Alteração de metodologia
4 - Melhoria do processo

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 6
2 OBJETIVOS 7
3 ÁREA DE APLICAÇÃO 8
3.1 Ajuda Mútua 8
3.1.1 Plano de Auxílio Mútuo - PAM 8
3.2 Divulgação do manual e documentos complementares 8
3.2.1 Divulgação interna 8
3.2.2 Divulgação externa 9
4 RESPONSABILIDADES 9
4.1 Conselho gestor 9
4.1.1 Governança - Diretoria executiva e Conselho de administração 9
4.1.2 Liderança – Coordenadores ou seus representantes 9
4.1.3 Saúde ocupacional 9
4.1.4 Núcleo de qualidade em saúde – NQS 10
4.2 Comitê de gerenciamento de crise 10
4.2.1 Líder do Comitê de gerenciamento de crise 10
4.2.2 Presidente Unimed Chapecó 11
4.2.3 Diretor técnico / Diretor hospitalar 11
4.2.4 Diretor clínico 11
4.2.5 Diretor de marketing 11
4.2.6 Coordenador de enfermagem - Pronto atendimento* 12
4.2.7 Coordenadores de enfermagem – Centro Cirúrgico e UTI's 12
4.2.8 Coordenadores de enfermagem - Unidades de internação 12
4.2.9 Coordenador de atendimento – Atendimento hospitalar 12
4.2.10 Coordenador Corpo técnico profissional – COTEP 13
4.2.11 Coordenador de Gestão de suprimentos 13
4.2.12 Coordenador de Tecnologia da informação 13
4.2.13 Coordenador de Saúde ocupacional 13
4.2.14 Coordenador Manutenção e Engenharia clínica 14
4.3 Grupo de operação 14
4.3.1 Coordenadores médicos - Pronto atendimento Adulto e Pediátrico (Médicos chefes da Equipe de resposta à emergência)* 14
4.3.2 Enfermeiro supervisor - Pronto atendimento* 15
4.3.3 Auxiliar de atendimento - Pronto atendimento 15
4.3.4 Técnico de manutenção de plantão - Manutenção e Engenharia clínica 15
4.4 Equipe de resposta à emergência (equipe médica e da enfermagem) 16
4.4.1 Médico plantonista P1 – Pronto atendimento 16
4.5 Equipes de apoio 16
4.5.1 Telefonia 16
4.5.2 Manutenção e Engenharia clínica 17
4.5.3 Pronto atendimento - Auxiliar de atendimento guichê 01 17
4.5.4 Brigada de incêndio 17
4.5.5 Coordenador Financeiro 19
4.5.6 Coordenador Unimagem (administrativo e médico) 19
4.5.7 Coordenador Laboratório 19
4.5.8 Coordenador Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças 20
4.5.9 Coordenadores médicos – setores críticos 20
4.5.10 Atendimento hospitalar 20
4.5.11 Central de materiais e esterilização - CME 20
4.5.12 Centro cirúrgico 20
4.5.13 Corpo técnico multiprofissional – COTEP 20
4.5.14 Gestão de pessoas 21
4.5.15 Farmácia 21
4.5.16 Gestão de suprimentos 21
4.5.17 Lavanderia/Higienização 21
4.5.18 Marketing 22
4.5.19 Saúde ocupacional 22
4.5.20 Serviço de transporte 22
4.5.21 Serviço de nutrição e dietética 23
4.5.22 Segurança patrimonial terceirizada 23
4.5.23 Serviço de controle de infecções relacionadas à assistência à saúde - SCIRAS 24
4.5.24 Unimed Personal 24
4.6 Equipes de retaguarda 24
4.6.1 Equipe de remoção de pacientes 24
4.6.2 Equipe de evacuação 25
4.7 Apoiadores em geral 25
4.7.1 Comissão interna de prevenção de acidentes - CIPA 25
4.7.2 Colaboradores 25
4.8 Organograma de responsabilidades na gestão e preparação para emergências e desastres 27

5 SISTEMA DE GESTÃO DE EMERGÊNCIAS E DESASTRES 28
5.1Acionamento do comitê de gerenciamento de crise 28
5.1.1Situação de crise sanitária 28
5.1.2Admissão de múltiplas vítimas pelo Pronto atendimento 29
5.1.3Ocorrência interna 29
5.2Resposta a emergências e desastres 30
5.2.1Notificação de emergência ou desastre 30
5.2.2Níveis de resposta (criticidade) 31
5.2.3Mapeamento dos riscos 33
5.3Posto de comando da crise 34
5.3.1Estrutura de comando no posto 35
5.3.2Preparação do local para atendimento às vítimas - Pronto atendimento 35
5.3.3Organização da área física 36
5.4Plano de comunicação para emergências e desastres 37
5.5Restabelecimento estrutural 37
5.5.1Medidas de recuperação 37
5.6Serviços de apoio aos colaboradores 41
5.6.1Resumo de Informações 41
5.6.2Apoio psicológico 41
5.6.3Funcionamento dos serviços de apoio 42
6 APÊNDICE I 45
6.1Plano de atendimento a situações emergenciais internas 45
6.1.1Apresentação 45
6.1.2Objetivo 45
6.1.3Implantação e manutenção do plano 45
6.1.4Prevenção a situações emergenciais 46
6.1.5Grupo de ação 46
6.1.6Grupo de apoio 46
6.1.7Medidas de prevenção de incêndio e emergências 47
6.1.8Medidas de sinalização e sistemas de alarme de incêndio 48
6.1.9Medidas de detecção de incêndio 48
6.1.10Medidas de supressão de incêndio 48
49
6.2Plano de emergência e abandono 51
6.2.1Medidas de evacuação de áreas 51
6.2.2Exercícios simulados de evacuação de áreas 51
6.3Plano de resposta a catástrofes e atendimento a múltiplas vítimas 52
6.3.1Objetivo 52
6.3.2Objetivos específicos 52
6.3.3Definições 52
6.3.4Desenvolvimento 53
6.3.5Ativação do plano 54
6.3.6Fases de atuação do plano 54
6.3.7Acionamento e incentivo a colaboradores 55
6.3.8Recursos humanos para o plano 55
6.3.9Identificação das vítimas 56
6.3.10Contingenciamento de áreas 56
6.3.11Abertura do hospital de base 57
6.3.12Desativação do plano 57
6.3.13 Preparação para atendimento a vítimas de acordo com o nível de resposta 58
Médico Chefe Equipe de Resposta: bloqueia troca de turno da equipe médica e dos colaboradores do Pronto atendimento. 58
6.3.14Avaliação das vítimas - protocolo Manchester 59
6.3.15Encaminhamento de óbitos 60
6.3.16 Atendimento a múltiplas vítimas no Pronto atendimento – nível de resposta 2 e 3 61
6.3.17Reestruturação para atendimento a múltiplas vítimas 62
6.3.18Encaminhamento de pacientes com classificação azul e/ou verde do Pronto atendimento para a Unimed Personal 64
6.3.19Resposta a desastres internos 65
7 RESPOSTA A DESASTRES EXTERNOS 65
7.1.1Relatório pós a desativação do plano de resposta a catástrofes e atendimento a múltiplas vítimas 65
7.1.2Avaliação do plano de resposta a catástrofes e atendimento a múltiplas vítimas 65
8 APÊNDICE III 66
8.1Plano de contingência para situações emergenciais internas 66
8.1.1Principais tipos de emergências internas 66
8.1.2Identificação e avaliação da emergência 66
8.1.3Acionamento dos grupos 66
8.1.4Incêndio – Brigada de incêndio 67
8.1.5Vazamento de GLP – setor de manutenção 67
8.1.6Vazamento de oxigênio líquido – setor de Manutenção e Engenharia clínica 68
8.1.7Falta de medicamentos – Farmácia 69
8.1.8Falta de materiais – Laboratório 69
8.1.9Falta de materiais –Gestão de suprimentos 70

8.1.10Falta de rouparia – Lavanderia 71
8.1.11Falta de alimentação – Serviço de nutrição e dietética 71
8.1.12Falta de água – Manutenção e Engenharia clínica 71
8.1.13Falta de energia elétrica 24h – Manutenção e Engenharia clínica 72
8.2Plano para remoção de pacientes 72
8.2.1Objetivo 72
8.2.2Responsabilidades 72
8.2.3Evacuação das instalações 74
8.2.4Remoção de pacientes 74
8.2.5Forma de locomoção 76
8.2.6No ponto de encontro 77
9 ANEXOS 78
9.1Anexo 1 – Método Start 78
9.2Anexo 2 - Formulário do plano de resposta a catástrofes e atendimento a múltiplas vítimas 79
9.3Anexo 3 – Instrumento de registro individual em casos de catástrofe - protocolo de Manchester 80
9.4Anexo 4 – Instrumento de registro médico e de enfermagem em catástrofes - protocolo Manchester 81
9.5Anexo 5 – Comunicado à imprensa 82
9.6Anexo 6 – Boletim de atendimento para emergência/desastre 83
9.7Anexo 9 - Listagem de fornecedores por área de insumos e serviços 84
9.8Anexo 10 - Procedimentos de aviso em caso de incêndio – setor de Telefonia 89
9.9Anexo 11 – Procedimentos de segurança no abandono de edificação – População 90
REFERÊNCIAS 91
TERMO DE APROVAÇÃO DO MANUAL DE GESTÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES 92

1 APRESENTAÇÃO

A preparação para situações de emergências e desastres compreende diversas ações desenvolvidas para minimizar os efeitos através da difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, da formação e capacitação de recursos humanos e da articulação de órgãos e instituições com empresas e comunidades.

A fase de preparação compreende, também, elaboração de planos prevendo diversas hipóteses de desastres, e a atuação nas fases de resposta e reconstrução.

O Manual de Gestão e Preparação para Emergências e Desastres define procedimentos e orientações, com direcionamento das ações que devem ser rápidas e eficientes em situações de emergências, podendo ser internas (envolvendo colaboradores, pacientes e visitantes do Hospital Unimed Chapecó) e em situações de desastres externos envolvendo a população de Chapecó e Região, visando promover ações eficazes na minimização de danos e de possíveis vítimas.

Este Manual aborda a fase de atendimento intra hospitalar no Hospital Unimed Chapecó e faz interface com parceiros externos se necessário, como Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, PAM (Plano de Auxílio Mútuo), Defesa Civil, Aeroporto Serafim E. Bertaso, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Colégio Exponencial, Hospital Regional de Chapecó, dentre outros.

A sistematização das ações, definição das responsabilidades e atribuições, disponibilização adequada de meios de combate a incêndio e sinalização, disseminação das diretrizes de exercícios simulados de abandono de áreas junto à governança, liderança e colaboradores, contribuirão conjuntamente para a eficácia deste Manual, cabendo a todos os envolvidos o aperfeiçoamento das condutas e a divulgação permanente das informações pertinentes.

2 OBJETIVOS

O Manual de Gestão e Preparação para Emergências e Desastres tem por objetivo:

- Estabelecer diretrizes para a prevenção, detecção precoce, supressão, combate e saída segura dos colaboradores, pacientes e visitantes das instalações;
- Garantir maior segurança aos ocupantes em caso de necessidade de abandono da edificação;
- Nortear as equipes multiprofissionais do Hospital Unimed Chapecó no desenvolvimento de uma resposta rápida a emergências e desastres de maneira eficaz e organizada;
- Descrever ações e procedimentos a serem implementados e mantidos pelos responsáveis em casos de emergências e desastres;
- Prestar o melhor atendimento para o maior número possível de vítimas, objetivando sua melhora;
- Garantir suporte e apoio a familiares, interação com autoridades públicas, moradores da região e à imprensa;

Para tanto, é estabelecido um conjunto de diretrizes, visando à adoção de procedimentos lógicos, técnicos e administrativos, estruturados de modo a propiciar a esperada resposta em situações emergenciais, fundamentais para a sobrevida dos pacientes acidentados.

As ações aqui traçadas são de conhecimento geral e a instituição deve zelar pela continuidade deste Manual, a fim de mantê-lo atualizado e de acordo com as ações nele planejadas.

3 ÁREA DE APLICAÇÃO

Este Manual aplica-se ao Pronto atendimento do Hospital Unimed Chapecó, bem como seus leitos de retaguarda, além de diversos setores envolvidos: Telefonia, Manutenção e Engenharia clínica, Marketing, Financeiro, Unimagem, Laboratório, Medicina preventiva, Atendimento hospitalar, Gestão de pessoas, Farmácia, , Gestão de suprimentos Lavanderia/ Higienização, Serviço de nutrição e dietética, Serviço de transporte, SCIRAS, CME, SESMT, Equipe multiprofissional, Unimed Personal, além da Brigada de incêndio e Patrimonial segurança, na preparação para o caso de emergências e desastres. Possui ainda interface com o Hospital Regional do Oeste e com o Hemocentro de Chapecó.

3.1 Ajuda Mútua

O Hospital Unimed Chapecó mantem acordo formal através de registro em documento oficial com entidades parceiras. As principais entidades são: Aeroporto Serafim Enoss Bertaso, Colégio Exponencial, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Guarda Municipal, Hospital Regional do Oeste, PAM, Patrimonial Segurança, Polícia Militar, SAMU e Secretária de Municipal de Saúde. O objetivo de fazer interface com estes parceiros é desenvolver planos, políticas e procedimentos que integrem as respostas a emergências e desastres, participar, em conjunto, no planejamento e na realização de exercícios para o caso de emergências e desastres, prestar apoio e atendimento à comunidade, facilitar ação imediata e consistente na resposta e fortalecer o apoio entre entidades.

3.1.1 Plano de Auxílio Mútuo - PAM

Trata-se de um contrato cooperativo de ajuda mútua entre entidades públicas e privadas instaladas na região oeste de Santa Catarina, prevendo a disponibilização de recursos materiais e humanos para o combate e atendimento a emergências de grande porte dentro do município e região, quando estes não puderem ser totalmente controlados pelos recursos da empresa, do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e Defesa Civil.
Algumas ações do PAM:

- Auxiliar entidades públicas e empresas participantes do Plano em situações de emergência;
- Promover eventos simulados de situações de emergência;
- Promover treinamentos diversos para comunidade;
- Eventos que visam incentivar a preservação da saúde, da segurança e do meio ambiente.

3.2 Divulgação do manual e documentos complementares

3.2.1 Divulgação interna

- Publicação na página da intranet Unimed Chapecó;

- Reuniões de divulgação com a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração, com os coordenadores médicos, coordenadores de setor, enfermeiros e colaboradores dos diversos setores do Complexo Unimed Chapecó;

- Disponibilização no software de documentos públicos do Sistema MV;
- Disponibilização em meio impresso em *displays* distribuídos em locais estratégicos (corredor da lavanderia, do atendimento hospitalar, do administrativo, do centro cirúrgico e vestiários).

3.2.2 Divulgação externa

- Publicação em meios de comunicação locais (mídias sociais, imprensa) sobre a realização de exercícios simulados para emergências e desastres;
- Divulgação formal através de reunião de apresentação do Manual com as entidades parceiras da cidade (Corpo de Bombeiros, SAMU, PAM, Defesa Civil, Aeroporto Serafim E. Bertaso, Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Militar, Guarda Municipal, Hospital Regional de Chapecó, Patrimonial Segurança e Colégio Exponencial).

4 RESPONSABILIDADES

4.1 Conselho gestor

4.1.1 Governança - Diretoria executiva e Conselho de administração

- Garantir recursos e apoio financeiro para a execução dos processos deste Manual;
- Garantir recursos para a execução de atividades e treinamentos de preparação para o caso de emergências e desastres;
- Garantir recursos para formação e atuação da Brigada de Incêndio e da Equipe de Remoção.

4.1.2 Liderança – Coordenadores ou seus representantes

- Garantir a divulgação deste Manual a todos os colaboradores;
- Garantir a execução de atividades e treinamentos de preparação para o caso de emergências e desastres;
- Garantir a participação dos colaboradores nos treinamentos de formação dos brigadistas e equipe de remoção;
- Garantir a participação dos colaboradores em exercícios e simulações de preparação para o caso de emergências e desastres;
- Garantir que as políticas e procedimentos organizacionais para a preparação para o caso de desastres e emergências sigam as leis e regulamentações aplicáveis.

4.1.3 Saúde ocupacional

- Elaborar e atualizar este Manual;
- Coordenar a execução deste Manual;
- Coordenar e manter as equipes envolvidas;
- Divulgar este Manual a todos os colaboradores do Complexo Unimed Chapecó;
- Realizar treinamentos com todos os envolvidos;

- Apoiar o Comitê de Gerenciamento de Crise;
- Elaborar, acompanhar e apoiar, juntamente com os envolvidos, o Plano de Resposta a Catástrofes e Atendimento a Múltiplas Vítimas (APÊNDICE II);
- Acompanhar, supervisionar e apoiar as atividades da Brigada de Incêndio, oferecendo suporte técnico;
- Realizar, juntamente com a Brigada de Incêndio e os colaboradores, exercícios e simulações de preparação para o caso de emergências e desastres;
- Oferecer informações básicas sobre prevenção e combate a princípios de incêndio para os colaboradores;
- Fiscalizar a prestação de serviços, manutenção e teste dos meios de combate a incêndio tais como: recarga de extintores, testes hidrostáticos de extintores e mangueiras e testes de pressão de hidrantes;
- Realizar inspeções periódicas nos sistemas de combate a incêndios (extintores, hidrantes, mangueiras, centrais de alarme, luminárias de emergência...).

4.1.4 Núcleo de qualidade em saúde – NQS

- Garantir a execução e atualização deste Manual;
- Auxiliar no gerenciamento deste Manual;
- Participar da organização do Comitê de gerenciamento de crise;
- Auxiliar na coordenação das atividades desenvolvidas pelo Comitê de gerenciamento de crise.

4.2 Comitê de gerenciamento de crise

- Aprovar este Manual;
- Realizar interface com a Equipe de resposta à emergência;
- Coordenar atividades e promover treinamentos de preparação para o caso de emergências e desastres, juntamente com a Saúde ocupacional, para a Equipe de resposta à emergência, (treinamentos e exercícios simulados);
- Promover a integração da instituição com as entidades parceiras da cidade;
- Supervisionar a execução do Plano de Resposta a Atendimento a Múltiplas Vítimas (APÊNDICE II);
- Apoiar a divulgação deste Manual;
- Realizar reuniões periódicas, juntamente com o setor de Saúde ocupacional;
- Supervisionar e coordenar os canais de comunicação da cooperativa.

4.2.1 Líder do Comitê de gerenciamento de crise

- Liderar o Comitê;
- Realizar interface com o Conselho gestor;
- Decidir, juntamente com o Diretor técnico/Diretor hospitalar e o Médico chefe da Equipe de resposta à emergência, o acionamento e desativação do Plano de Resposta a Catástrofes e Atendimento a Múltiplas Vítimas.

4.2.2 Presidente Unimed Chapecó

- Apoiar a execução deste Manual;
- Realizar interface com o Conselho Gestor e o Comitê;
- Garantir recursos para ações de preparação e resposta frente a emergências ou desastres.

4.2.3 Diretor técnico / Diretor hospitalar

- Acionar contingente interno (equipe médica, de enfermagem e da administração) para apoio no Pronto atendimento e, se necessário, acionar contingente externo;
- Solicitar reforços da equipe médica, da enfermagem e do administrativo das áreas assistenciais;
- Solicitar vagas no Centro cirúrgico e UTI's;
- Solicitar transferências de vítimas para outros hospitais se for o caso;
- Garantir que o Centro de material esterilizado (CME) seja devidamente orientado quanto ao perfil das vítimas e aos materiais que deverão ser priorizados;
- Solicitar ao setor de Manutenção e Engenharia clínica equipamentos extra, quando necessário;
- Repassar as informações a Assessoria de Comunicação;
- Decidir, juntamente com o Líder do Comitê de gerenciamento de crise e o Médico chefe da Equipe de resposta à emergência, o acionamento e desativação do Plano de Resposta a Catástrofes e Atendimento a Múltiplas Vítimas.

4.2.4 Diretor clínico

- Acionar as equipes médicas de sobreaviso;
- Acionar o serviço de anestesiologia, se necessário;
- Manter interface com a coordenação do gerenciamento de leitos;
- Coordenar equipes médicas nas ações de remoção de pacientes, conforme Plano de Remoção de Pacientes (APÊNDICE IV).

4.2.5 Diretor de marketing

- Realizar interface com órgãos públicos, diretores de outros hospitais;
- Manter contato com os órgãos de comunicação;
- Aprovar boletim médico a ser liberado para assessoria de imprensa;
- Realizar interface com órgãos de imprensa: área a ser preparada no auditório 1 ou na impossibilidade deste, na recepção adulta do Pronto atendimento;
- Realizar alinhamento com a Telefonia;
- Realizar interface com a equipe de segurança patrimonial terceirizada;
- Fazer cumprir a política institucional de Comunicação em Casos de Emergências e Desastres (PLI.COM.0003).

4.2.6 Coordenador de enfermagem - Pronto atendimento*

- Realizar bloqueio de troca de turno dos colaboradores do Pronto atendimento;
- Registrar as vítimas com numeração distinta;
- Identificar as vítimas em modelo específico de boletim de atendimento diferenciando dos demais atendimentos;
- Fazer boletim de atendimento entregando ao profissional de enfermagem responsável por este;
- Fazer e manter atualizada, a cada hora, a lista de vítimas atendidas nas salas de emergência com os destinos específicos destas;
- Informar o conteúdo da lista apenas para as pessoas autorizadas: Comitê de Gerenciamento de Crise / Conselho Gestor;
- Decidir, juntamente com Coordenadores médicos do Pronto atendimento ou Médico plantonista P1, Coordenador ou Chefe da Brigada e Coordenador de Manutenção e Engenharia clínica ou Técnico de manutenção, quanto à ordem de abandono ou não da edificação.

***Na sua ausência, o Enfermeiro supervisor assumirá suas responsabilidades.**

4.2.7 Coordenadores de enfermagem – Centro Cirúrgico e UTI's

- Comunicar Coordenador médico e serviço de anestesiologia sobre ocorrência de emergência ou desastre, logo após receber informação da Telefonia;
- Realizar interface com os setores envolvidos na resposta à emergência;
- Realizar interface com a equipe médica, de anestesiologistas e de enfermagem.

4.2.8 Coordenadores de enfermagem - Unidades de internação

- Definir número de profissionais da enfermagem que poderão atender no Pronto atendimento sem prejuízo para assistência nas unidades de internação;
- Acionar a equipe de enfermagem, definindo responsabilidades;
- Coordenar equipes de enfermagem nas ações de remoção de pacientes, conforme Plano de Remoção de Pacientes (APÊNDICE IV);
- Controlar o fluxo dos pacientes ao Centro Cirúrgico e UTI's.

4.2.9 Coordenador de atendimento – Atendimento hospitalar

- Gerenciar os leitos disponíveis no hospital;
- Entrar em contato com a equipe médica para informar que o Plano de Resposta a Catástrofes e Atendimento a Múltiplas Vítimas foi acionado e que será necessário priorizar as altas para acomodação das vítimas;
- Realizar o bloqueio de cirurgias eletivas com liberação de salas cirúrgicas junto com a coordenação do Centro Cirúrgico;

- Controlar, juntamente com o supervisor responsável pelo setor, o fluxo das transferências internas e externas de vítimas;
- Realizar busca ativa das altas nas unidades de internação e manter interação constante com a equipe médica, enfermagem e higienização para otimizar as liberações dos leitos para as vítimas;
- Realizar contato com hospitais da rede credenciada para informar que o Plano de Resposta a Catástrofes e Atendimento a Múltiplas Vítimas foi acionado e verificar possíveis transferências de vítimas;
- Realizar o bloqueio de internações eletivas;
- Realizar interface com o Coordenador, Médico e/ou Enfermeiro da Equipe de Resposta à Emergência, quanto à previsão de óbitos.

4.2.10 Coordenador Corpo técnico profissional – COTEP

- Realizar interface com a equipe de enfermagem, setor de Atendimento hospitalar, segurança patrimonial terceirizada e Comitê de Gerenciamento de Crise.
- Remanejar fisioterapeutas de plantão presencial e, se necessário, o sobreaviso, para atender as vítimas, caso indicado;
- Coordenar e direcionar a quantidade de psicólogas e assistentes sociais para o Pronto atendimento, Atendimento hospitalar e locais externos, se necessário.
- Solicitar auxílio à coordenação da Fisioterapia externa para suporte, quando necessário.

4.2.11 Coordenador de Gestão de suprimentos

- Disponibilizar profissionais em número suficiente para permanecer no Pronto Atendimento para imediato suprimento sem necessidade de deslocamento da equipe assistencial;
- Entrar em contato com fornecedores a fim de garantir o fornecimento de materiais e medicamentos por 96 horas;
- Realizar interface com os hospitais da região para reposição imediata de estoques se necessário.

4.2.12 Coordenador de Tecnologia da informação

- Garantir a segurança das informações do prontuário do paciente;
- Garantir a funcionalidade dos sistemas de informática em todas as etapas da emergência ou desastre, e na impossibilidade deste, prever recursos opcionais básicos para suprir a necessidade.

4.2.13 Coordenador de Saúde ocupacional

- Realizar interface e prestar apoio ao SESMT, Médico do trabalho e Psicóloga clínica da Saúde ocupacional;
- Apoiar as áreas sob sua responsabilidade na resposta a emergências e desastres;
- Apoiar as ações do Complexo Unimed Chapecó na preparação a emergências e desastres.

4.2.14 Coordenador Manutenção e Engenharia clínica

- Instalar o sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico;
- Realizar a manutenção preventiva e corretiva do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico;
- Renovar periodicamente o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
- Solicitar análise e orientação ao setor de Saúde ocupacional quanto aos riscos e recomendações pertinentes à realização de cada obra, construção ou reforma, promovendo previamente as ações necessárias à realização segura das atividades;
- Garantir abastecimento de combustível para os geradores de energia elétrica;
- Entrar em contato com os fornecedores mapeados, conforme Anexo 9 "Listagem de fornecedores por área de insumos e serviços" para aquisição emergencial ou locação de equipamento;
- Decidir, juntamente com Coordenadores médicos do Pronto atendimento ou Médico plantonista P1, Coordenador de enfermagem do Pronto atendimento ou Enfermeiro supervisor e Coordenador ou Chefe da Brigada, quanto à ordem de abandono ou não da edificação.

4.3 Grupo de operação

- Realizar interface e prestar apoio às áreas assistenciais e administrativas que estiverem de plantão.

4.3.1 Coordenadores médicos - Pronto atendimento Adulto e Pediátrico (Médicos chefes da Equipe de resposta à emergência)*

- Formar e coordenar a Equipe de resposta à emergência (profissionais de plantão no Pronto atendimento);
- Realizar interface com as equipes médica e de enfermagem nas ações imediatas de atendimento a emergências;
- Bloquear troca de turno da equipe médica, coordenar as atividades médicas e definir prioridades;
- Delegar atribuições médico responsável do plantão;
- Gerenciar a triagem das vítimas;
- Gerenciar a comunicação com os serviços de transporte interno e externo e as respectivas transferências de vítimas;
- Acionar os setores de apoio críticos: Centro cirúrgico, UTI's, Laboratório (agência transfusional), Unimagem (serviços de imagem);
- Acionar o setor de Atendimento hospitalar e promover a transferência de vítimas, no caso de exceder a capacidade de atendimento do Hospital Unimed Chapecó;
- Informar Instituto Médico Legal quando houver óbito;
- Decidir, juntamente com Diretor técnico/Diretor hospitalar e o Líder do Comitê de gerenciamento de crise, o acionamento e desativação do Plano de Resposta a Catástrofes e Atendimento a Múltiplas Vítimas (APÊNDICE II);

- Decidir, juntamente com o Coordenador de enfermagem do Pronto atendimento ou Enfermeiro supervisor, Coordenador ou Chefe da Brigada e Coordenador da Manutenção e Engenharia clínica ou Técnico de manutenção, quanto à ordem de abandono ou não da edificação.
- Desativar o Plano de Resposta a Catástrofes e Atendimento a Múltiplas Vítimas.

***Na sua ausência, o Médico plantonista P1 assumirá suas responsabilidades.**

4.3.2 Enfermeiro supervisor - Pronto atendimento*

- Coordenar a resposta à emergência, conforme Plano de Resposta a Catástrofes e Atendimento a Múltiplas Vítimas (APÊNDICE II);
- Coordenar equipe de enfermagem (contingência) momento do atendimento;
- Solicitar ao Almoxarifado e Farmácia o abastecimento de materiais, medicamentos e equipamentos para receber as vítimas;
- Preparar os materiais e equipamentos necessários para o atendimento, juntamente com o setor de Manutenção e Engenharia clínica (os materiais e equipamentos são os de uso rotineiro, de acordo com cada tipo de emergência; setor de Manutenção e Engenharia clínica apoia no transporte, ou na providencia de réguas e extensões);
- Organizar, juntamente com o setor de Atendimento hospitalar – Gerenciamento de leitos - a ocupação dos leitos disponíveis para receber as vítimas após o atendimento inicial;
- Prestar apoio na remoção de vítimas, em caso de desastre interno;
- Gerenciar as vítimas em atendimento;
- Encaminhar óbitos para o necrotério e contingenciar uma câmara fria para aguardo do IML (realizar contato com empresas frigoríficas);
- Decidir, na ausência do Coordenador de enfermagem do Pronto atendimento, quanto à ordem de abandono ou não da edificação, juntamente com Coordenadores médicos do Pronto atendimento ou Médico plantonista P1, Coordenador ou Chefe da Brigada e Coordenador de Manutenção e Engenharia clínica ou Técnico de manutenção.

***Na sua ausência, o enfermeiro de plantão assume suas responsabilidades.**

4.3.3 Auxiliar de atendimento - Pronto atendimento

- Prestar apoio administrativo;
- Realizar a identificação manual de vítimas.

4.3.4 Técnico de manutenção de plantão - Manutenção e Engenharia clínica

- Providenciar filtros de linha para auxiliar na extensão da rede elétrica;
- Realizar, quando solicitado, o transporte de materiais, equipamentos e macas;
- Realizar pequenos reparos que se fizerem necessários;
- Solicitar ajuda dos demais colegas da equipe apoio, caso necessário;

- Decidir, na ausência do Coordenador de Manutenção e Engenharia clínica, quanto à ordem de abandono ou não da edificação, juntamente com Coordenadores médicos do Pronto atendimento ou Médico plantonista P1, Coordenador de enfermagem do Pronto atendimento ou Enfermeiro supervisor e Coordenador ou Chefe da Brigada.

4.4 Equipe de resposta à emergência (equipe médica e da enfermagem)

- Participar de treinamentos de preparação para o caso de emergências e desastres;
- Participar de exercícios e simulações de preparação para o caso de emergências e desastres;
- Atender à solicitação de emergência quando acionada;
- Receber as vítimas externas e refazer a triagem;
- Prestar os primeiros socorros às vítimas, em caso de incêndio ou outra situação de emergência nas instalações do Complexo Unimed Chapecó, conforme Plano de Resposta a Catástrofes e Atendimento a Múltiplas Vítimas (APÊNDICE II);
- Receber os pacientes advindos da evacuação, que necessitem de cuidados imediatos, adotando as ações necessárias à sua estabilização;
- Fazer a avaliação primária e secundária das vítimas (equipe médica e de enfermagem).

4.4.1 Médico plantonista P1 – Pronto atendimento

- Assumir responsabilidades pertinentes dentro da equipe de resposta à emergência;
- Decidir, na ausência dos Coordenadores médicos do Pronto atendimento, quanto à ordem de abandono ou não da edificação, juntamente com Coordenador de enfermagem do Pronto atendimento ou Enfermeiro supervisor, Coordenador ou Chefe da Brigada e Coordenador de Manutenção e Engenharia clínica ou Técnico de manutenção.

4.5 Equipes de apoio

4.5.1 Telefonia

- Receber informação sobre a ocorrência de emergência ou desastre (interno ou externo), do Pronto atendimento e/ou Coordenador ou Chefe da Brigada de incêndio;
- Informar setores críticos, independente do nível de criticidade da ocorrência: Centro cirúrgico, UTI's, Laboratório (agência transfusional), Unimagem (serviços de imagem).
- Informar o Comitê de Gerenciamento de Crise sobre ocorrência nível 1 de resposta;
- Acionar o Grupo de Operação e Comitê de Gerenciamento de Crise para ocorrência de nível 2 ou 3 de resposta - CÓDIGO E (lista de participantes disponível na Telefonia);
- Ligar para médicos especialistas da escala de sobreaviso (traumatologista/ortopedia, cirurgião geral, neurocirurgião, cirurgião torácico, cirurgião buco maxilar, urologista), independente do nível de resposta e repassar mensagem: "CÓDIGO E! Fique atento, você poderá ser acionado";
- Para emergência interna seguir o fluxo de Procedimentos de resposta para emergências internas;

- Para emergência envolvendo incêndio, seguir procedimentos de aviso (Anexo 10).

4.5.2 Manutenção e Engenharia clínica

- Executar o corte de energia local ou geral mediante solicitação do Coordenador ou Chefe da Brigada e/ou do Corpo de Bombeiros;
- Executar a paralisação de máquinas e equipamentos complexos, quando solicitado pelo Coordenador ou Chefe da brigada e/ou Corpo de Bombeiros;
- Remanejar equipamentos mediante solicitação;
- Instalar filtros de linha para auxiliar na extensão da rede elétrica;
- Avaliar e classificar o risco da ocorrência, juntamente com o SESMT e/ou Coordenador / Chefe da Brigada;
- Proporcionar o apoio necessário para controlar a situação emergencial.

4.5.3 Pronto atendimento - Auxiliar de atendimento guichê 01

- Responsável por operar a central de alarme e atender o ramal de emergência 2000;
- Conhecer os procedimentos operacionais da central de alarme;
- Seguir, impreterivelmente, o fluxo de Procedimentos de resposta para emergências internas.

4.5.4 Brigada de incêndio

- Conhecer o Plano de Emergência e Abandono (PEMA) contra incêndio do Complexo Unimed Chapecó;
- Conhecer este Manual;
- Avaliar os riscos existentes através de inspeções;
- Inspecionar os equipamentos de combate a incêndio e de primeiros socorros;
- Inspecionar as rotas de fuga;
- Orientar a população fixa e flutuante;
- Participar dos exercícios simulados;
- Cumprir as determinações do Coordenador ou Chefe da Brigada ou substituto em serviço, desempenhando as funções estabelecidas;
- Dirigir-se ao local da ocorrência munido dos equipamentos necessários;
- Operar extintores e compor as linhas de hidrantes armando-as, porém, certificando-se da total desenergização das instalações antes de lançar água;
- Combater, controlar ou confinar o foco do incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros;
- Comunicar sobre a ordem de abandono da edificação, priorizando simultaneamente o pavimento da ocorrência do incêndio e os pavimentos superiores, quando aplicável;
- Repassar instruções as pessoas de como proceder para evacuar o local de forma segura;
- Apoiar o cabeça de fila na retirada dos ocupantes, iniciando pelas salas mais distantes e encaminhá-las para a rota de fuga mais próxima, orientando-as sobre como proceder;
- Vistoriar as instalações para a confirmação da saída de todos;

- Providenciar abertura de portas e janelas para a ventilação local se for apropriado, atentando-se à participação do comburente (oxigênio) na cadeia do fogo;
- Providenciar o arrombamento de portas quando necessário;
- Favorecer e auxiliar as ações do Corpo de Bombeiros.

4.5.4.1 Brigada de incêndio - Coordenador

- Participar da atualização do Plano de Emergência e Abandono (PEMA);
- Acompanhar e reforçar as ações definidas no Plano de Emergências e Abandono;
- Decidir, juntamente com coordenadores médicos do Pronto atendimento ou Médico plantonista P1, Coordenador de enfermagem do Pronto atendimento ou Enfermeiro supervisor, Coordenador de Manutenção e Engenharia clínica ou Técnico de manutenção, quanto à ordem de abandono ou não da edificação;
- Convocar a Brigada de Incêndio durante desastres internos;
- Conduzir a atuação dos brigadistas delegando atribuições conforme o caso;
- Coordenar as atividades dos Chefes da Brigada;
- Contatar a Polícia Militar para apoio presencial, se necessário pedir destinação de pelo menos uma equipe para segurança no Pronto Atendimento e fechamento de vias públicas;
- Promover treinamentos para a Brigada de Incêndio e demais envolvidos sobre o conteúdo do Plano de Emergências e Abandono;
- Promover reuniões periódicas com a Brigada de Incêndio, visando o planejamento das ações de prevenção e de resposta a situações de emergência;
- Solicitar treinamento especializado para formação e manutenção da Brigada de Incêndio;
- Participar, em conjunto, com os brigadistas das instruções e treinamentos periódicos;
- Promover exercícios simulados de abandono de área nas edificações.

***Na ausência do Coordenador, o Chefe da Brigada assume suas responsabilidades.**

4.5.4.2 Brigada de incêndio - Chefes da brigada

- Atuar em conjunto com o coordenador da Brigada ou na ausência deste;
- Participar da elaboração do Plano de Emergência e Abandono;
- Comunicar a ordem e coordenar a evacuação das áreas, direcionando os brigadistas de forma a priorizar o pavimento sinistrado e os pavimentos superiores a este, quando aplicável;
- Determinar as funções para os membros da brigada de incêndio presentes;
- Transmitir o ocorrido à equipe do Corpo de Bombeiros;
- Indicar aos bombeiros o local do Registro de Recalque;
- Em conjunto com o Corpo de Bombeiros, determinar o corte da energia e do fornecimento dos gases;
- Elaborar relatórios e encaminhá-los ao coordenador;
- Treinar e delegar suas atribuições ao substituto, em sua ausência;

- Participar juntamente com os brigadistas das instruções, treinamentos e simulados;
- Decidir, na ausência do Coordenador da Brigada, quanto à ordem de abandono ou não da edificação, juntamente com Coordenadores médicos do Pronto atendimento ou Médico plantonista P1, Coordenador de enfermagem do Pronto atendimento ou Enfermeiro supervisor e Coordenador de Manutenção e Engenharia clínica ou Técnico de manutenção.

(1) Importante: Deverá haver um Chefe da Brigada por turno de trabalho, assim como um suplente previamente estabelecido e treinado, para o desenvolvimento das atribuições previstas e liderança da operação em todo o Complexo Unimed Chapecó.

(2) Importante: Todos os setores deverão, preferencialmente, possuir brigadistas devidamente treinados em todos os turnos de funcionamento, e em número mínimo exigido pelo Corpo de Bombeiros, visando garantir o desenvolvimento das ações previstas, juntamente com os demais brigadistas presentes no momento da ocorrência de um incêndio ou outra situação de emergência.

4.5.5 Coordenador Financeiro

- Realizar interface com o Diretor Corporativo;
- Realizar interface com toda área administrativa e de apoio, garantindo recursos para a operação, aplicando se necessário, o plano de contingência financeira do Hospital Unimed Chapecó;
- Identificar os gastos junto ao setor de Faturamento e buscar reembolso em caso de catástrofe externa.

4.5.6 Coordenador Unimagem (administrativo e médico)

- Suspender imediatamente os exames eletivos;
- Os médicos serão responsáveis pela organização e priorização dos atendimentos no setor;
- Priorizar o atendimento para as vítimas (manter);
- Organizar o setor e informar imediatamente a disponibilidade ao Diretor Técnico;
- Disponibilizar profissionais para suporte à demanda.

4.5.7 Coordenador Laboratório

- Organizar o setor e informar imediatamente a disponibilidade ao Diretor Técnico;
- Disponibilizar recursos para a realização dos exames;
- Efetuar ações para redução do tempo da entrega de resultados;
- Destinar 3 coletadores exclusivos para a sala de emergência, sendo 1 exclusivo do banco de sangue;
- Manter estoque de sangue “O-“ e equipe de prontidão;
- Atender aos pedidos de hemoderivados, de acordo com a gravidade das vítimas;
- Providenciar estoque de sangue e acionar a agência transfusional do Hospital Regional de Chapecó - Hemocentro Regional de Chapecó - para suporte e garantia de atendimento, se necessário;
- Notificar situação ao HEMOSC Chapecó.

4.5.8 Coordenador Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças

- Disponibilizar serviços de psicólogas para auxiliar no atendimento a colaboradores que apresentarem comportamento alterado durante o recebimento de vítimas;
- Elaborar, implantar e manter o programa de intervenção em caso de crise para apoiar colaboradores envolvidos em emergências ou desastres.

4.5.9 Coordenadores médicos – setores críticos

- Acionar e coordenador ações médicas de suas equipes;
- Realizar interface com as equipes médica e de enfermagem nas ações de atendimento a emergências e desastres.

4.5.10 Atendimento hospitalar

- Auxiliar a equipe de enfermagem no transporte interno de pacientes, de forma segura, entre os setores do Hospital Unimed Chapecó;
- Atender de forma imediata às solicitações da Equipe de Resposta a Emergência.

4.5.11 Central de materiais e esterilização - CME

- Permanecer de prontidão e priorizar os materiais que serão utilizados no atendimento as vítimas.

4.5.12 Centro cirúrgico

- Manter salas prontas para receber as vítimas;
- Manter leitos de recuperação pós-cirúrgicos prontos para receber pacientes da UTI, se necessário.

4.5.13 Corpo técnico multiprofissional – COTEP

4.5.13.1 Fisioterapia hospitalar

- Atender as vítimas, seguindo protocolos da assistência fisioterápica na insuficiência respiratória, instalação de oxigeno terapia, suporte ventilatório;
- Auxiliar no transporte e posicionamento das vítimas internadas, segundo protocolos institucionais;
- Realizar acompanhamento fisioterapêutico as vítimas internadas, conforme indicação.

4.5.13.2 Psicologia hospitalar e Serviço social

- Prestar apoio aos familiares, incluindo situação de comunicação de óbito pelo médico aos familiares da vítima (psicólogas hospitalares e clínicas, se necessário), e o Serviço Social para questões relacionadas a funeral, translado etc;
- Realizar atendimento emergencial a colaboradores do hospital que apresentarem alterações comportamentais na etapa de recepção das vítimas.

- Dar seguimento às etapas do fluxo de atendimento do Serviço de Psicologia hospitalar e Serviço social hospitalar: chegada das vítimas, primeiro atendimento (triagem) e hospitalização das vítimas;
- Apoiar a destinação dos segmentos da família e vítimas em alojamentos, contatos e resgates de familiares para suporte, acionando as redes de apoio para atendimento dos municípios.

4.5.14 Gestão de pessoas

- Prestar total apoio e incentivo aos colaboradores a trabalhar em emergências ou desastres;
- Permanecer de prontidão para dar suporte aos colaboradores;
- Disponibilizar serviços de psicólogas organizacionais, se solicitado, para auxiliar no atendimento a colaboradores que apresentarem comportamento alterado durante o recebimento de vítimas.

4.5.15 Farmácia

- Permanecer de prontidão para dar suporte demais setores;
- Disponibilizar profissionais em número suficiente para permanecer no Pronto atendimento para imediato suprimento sem necessidade de deslocamento da equipe assistencial;
- Garantir o abastecimento de medicamentos suficientes no setor envolvido no atendimento;
- Entrar em contato com fornecedores a fim de garantir o fornecimento de materiais e medicamentos por 96 horas.

4.5.16 Gestão de suprimentos

- Garantir o abastecimento de materiais suficientes no setor envolvido no atendimento;
- Disponibilizar se necessário, as reservas de oxigênio;
- Disponibilizar recursos para entregas e abastecimentos.

4.5.17 Lavanderia/Higienização

- Realizar interface com os setores de Pronto atendimento e Atendimento hospitalar (gestão de acesso/ gerenciamento de leitos), priorizando a higiene de leitos sinalizados como urgentes;
- Garantir a limpeza e/ou desinfecção da área de atendimento, estando sempre próximos ao local;
- Recolher os resíduos sólidos e biológicos e manter os sanitários limpos e abastecidos com insumos de higiene pessoal;
- Recolher as rouparias da área de atendimento;
- Garantir a lavagem e o fornecimento de rouparias para suprir a necessidade;
- Entrar em contato com fornecedores a fim de garantir o fornecimento de materiais por 96 horas.

4.5.18 Marketing

- Garantir a execução e atualização da Política institucional de Comunicação em Casos de Emergências e Desastres (PLI.COM.0003);
- Buscar informações com os coordenadores médicos responsáveis e equipe multidisciplinar para elaboração de boletim à imprensa e aprovação do Diretor de Marketing;
- Utilizar canais internos de comunicação para informar aos colaboradores do Complexo Unimed Chapecó que o hospital está funcionando em modo de atendimento às vítimas de catástrofe (após aprovação).

4.5.19 Saúde ocupacional

4.5.19.1 Serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT

- Avaliar e classificar o risco da ocorrência, juntamente com a Brigada de Incêndio e Manutenção e Engenharia clínica;
- Proporcionar o apoio necessário para controlar a situação emergencial;
- Apoiar o Comitê de Gerenciamento de Crise, no que for necessário;
- Prestar auxílio aos colaboradores envolvidos na resposta à catástrofe, durante e após a ocorrência;
- Prestar atendimento a colaboradores envolvidos em acidente de trabalho com material biológico (médico do trabalho e técnico de enfermagem e/ou enfermeiro);
- Substituir, o mais rápido possível, extintores utilizados em situações de incêndio;
- Disponibilizar serviços de psicóloga clínica, para auxiliar no atendimento a colaboradores que apresentarem comportamento alterado durante o recebimento de vítimas.

4.5.19.2 Médico do trabalho

- Prestar atendimento médico a colaboradores que sofrerem acidentes de trabalho de menor complexidade durante emergências e desastres (acidentes com material biológico, traumas com menor potencial de risco ofensivo, alterações emocionais agudas, etc.);
- Seguir condutas de acordo com protocolos da Saúde Ocupacional;
- Realizar consulta ocupacional com todos os colaboradores envolvidos na resposta à situação de emergência ou desastre e encaminhar se necessário, para consulta de acolhimento com a psicóloga da Saúde ocupacional.

4.5.19.3 Psicóloga clínica - Saúde ocupacional

- Realizar acolhimento aos colaboradores que se envolveram no atendimento ao desastre ou emergência.

4.5.20 Serviço de transporte

- Permanecer de prontidão para suporte imediato no transporte das vítimas;

- Realizar o transporte das vítimas, quando solicitado.

4.5.21 Serviço de nutrição e dietética

- Realizar interface com a enfermagem;
- Entrar em contato com fornecedores a fim de garantir o fornecimento de alimentação por 96 horas;
- Fornecer café e chá para os familiares e acompanhantes das vítimas;
- Fornecer refeição para os colaboradores que precisarem estender a jornada de trabalho.

4.5.22 Segurança patrimonial terceirizada

A ativação do Manual de Gestão e Preparação para Emergências e Desastres pressupõe um imediato reforço da segurança do Hospital Unimed Chapecó, seja através do respectivo pedido à empresa terceira que presta estes serviços, como também às entidades policiais competentes.

A questão do reforço de segurança é imprescindível para manter a capacidade de atuação e a inexistência deste reforço põe em risco a capacidade do hospital em realizar o atendimento a múltiplas vítimas.

São atribuições da empresa de segurança patrimonial terceirizada:

- Controlar rigorosamente entradas externas ao hospital (estacionamento dos médicos, estacionamento dos colaboradores, entrada do Laboratório e do Administrativo, entrada do Pronto atendimento, entrada do Atendimento hospitalar, entrada da Unimagem);
- Realizar interface com o Marketing, psicologia hospitalar e o serviço de assistência social;
- Manter áreas de atendimento livres de terceiros (público);
- Reforçar a “vigilância” nos arredores do Pronto atendimento através de agentes motorizados;
- Bloquear a entrada do Pronto atendimento e conduzir o atendimento externo, direcionando para a recepção pediátrica;
- Isolar perímetro de acesso às ambulâncias;
- Bloquear elevador social para transporte entre Pronto atendimento, Centro cirúrgico, UTI’s e Unimagem;
- Encaminhar familiares à procura de parentes e amigos, à recepção adulta do Pronto atendimento;
- Retirar das áreas internas do Pronto atendimento, visitantes e acompanhantes e encaminhar à recepção adulta do Pronto atendimento;
- Controlar o acesso dos órgãos de imprensa, que ficará na área a ser preparada no auditório 1 ou, na impossibilidade deste, em frente à entrada do setor de Atendimento hospitalar;
- Permanecer junto à assessoria de imprensa do hospital para garantir a integridade física das pessoas envolvidas;
- Participar de exercícios e simulações de preparação para o caso de emergências e desastres.

4.5.23 Serviço de controle de infecções relacionadas à assistência à saúde - SCIRAS

- Permanecer de prontidão para dar suporte em situações de risco biológico.

4.5.24 Unimed Personal

- Prestar atendimento à pacientes/vítimas com classificação azul e/ou verde, advindos do Pronto atendimento ou que permanecerem neste, conforme FLU.INS.0028.
- Disponibilizar médico, enfermeiro e técnico de enfermagem para atender pacientes/vítimas azul e/ou verde. Caso necessário, será disponibilizado maior número de profissionais;
- Prestar atendimento psicológico a colaboradores encaminhados pelo médico do trabalho, pós-situação de emergência ou desastre, conforme fluxo FLU. INS.0025/00

4.6 Equipes de retaguarda

4.6.1 Equipe de remoção de pacientes

Apoio (profissionais de diversos setores)

- Deslocar-se e assumir posição no setor e leito designado e dar suporte a equipe assistencial para remover pacientes.

Assistência

- **Médico**: Realizar a triagem e designar qual paciente será removido, por ordem de complexidade; solicitar ao enfermeiro ou técnico de enfermagem parecer quanto ao quadro clínico de cada paciente naquele momento.
- **Enfermeiro**: Realizar a triagem para remoção de pacientes nos setores onde não tem médico fixo; nos setores onde há médicos deverá auxiliar na triagem; coordenar e posicionar os técnicos de enfermagem para preparar pacientes para abandono; realizar diariamente, durante a passagem do plantão, uma breve avaliação e pré-triagem dos pacientes para priorizar a remoção em caso de abandono e orientar os acompanhantes sobre as funções dos brigadistas e tipos de alarmes.
- **Técnico de enfermagem**: Preparar o paciente para remoção e orientar a equipe de apoio para transporte; atentar-se diariamente, no início de plantão, quanto aos equipamentos que poderá deixar ou os que deverá acompanhar o paciente num possível abandono e quais medicamentos estão sendo administrados para uma possível sequência fora do leito hospitalar.

4.6.1.1 Equipe médica e enfermagem em geral

- Participar de treinamento anual quanto à execução do Plano de Remoção de Pacientes (APÊNDICE IV), considerando as particularidades inerentes a cada setor;
- Garantir acolhimento dos pacientes graves advindos dos setores situados no pavimento sinistrado e dos pavimentos superiores a esse, que não possam ser retirados da edificação.

4.6.1.2 Médicos plantonistas: UTI geral, UTI neonatal e Unidades de internação

- Avaliar possibilidade de alta dos pacientes e se possível efetivá-las;
- Manter leitos prontos para receber as vítimas;
- Suspender novas admissões, exceto aquelas autorizadas pelos Coordenadores médicos do Pronto atendimento;
- Colaborar no atendimento inicial dos pacientes críticos no Pronto atendimento, conforme solicitação da coordenação médica deste setor.

4.6.2 Equipe de evacuação

Cabeça de fila

- Orientar a conduta de evacuação para população antes do abandono;
- Conduzir população até o ponto de encontro mais próximo ou mais seguro.

Fim de fila

- Fazer a varredura no setor, sinalizar portas e comunicar ao líder do andar/setor que o local já está evacuado.

Chefe de setor

- Manter quadro de organização setorial atualizado;
- Repassar orientações aos novos colaboradores sobre o funcionamento do quadro de organização e procedimentos frente a emergências internas e reforçar mensalmente com os demais colaboradores.

4.7 Apoiadores em geral

4.7.1 Comissão interna de prevenção de acidentes - CIPA

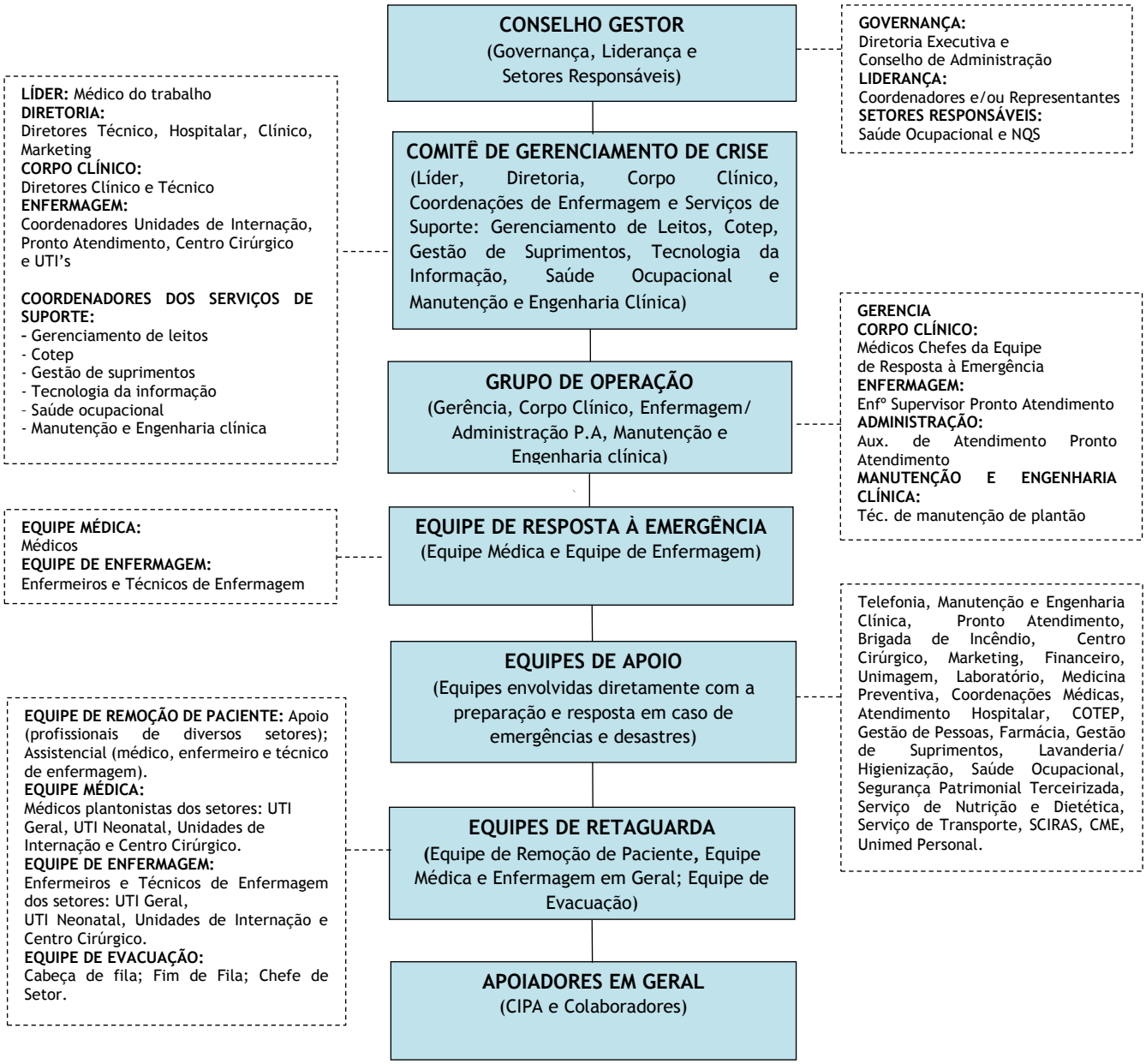
- Conhecer e auxiliar a divulgação deste Manual;
- Participar de exercícios e simulações de preparação para os casos de emergências e desastres;
- Atuar na identificação de riscos e na prevenção de emergências e desastres.

4.7.2 Colaboradores

- Contribuir para que os meios de combate a incêndio e as passagens estejam desobstruídas;
- Conhecer quem são os brigadistas do seu setor e dos setores próximos;
- Conhecer os responsáveis pela evacuação do seu setor e dos demais setores por onde circula;
- Comunicar toda e qualquer situação de risco identificada através do ramal de emergência 2000;
- Ao primeiro sinal de fogo, atuar conforme orientado em treinamento, adotando os procedimentos de segurança no abandono de edificação-população (Anexo 11);
- Em caso de evacuação, seguir imediatamente as orientações recebidas em treinamento, retornando à edificação somente após a liberação oficial;
- Manter-se atualizado quanto ao conteúdo dos APÊNDICES I, II, III e IV deste Manual.

Importante: No sistema MV e na Intranet estão disponíveis as informações sobre a composição da Brigada de Incêndio e a localização dos brigadistas, assim como seus ramais de contato e horários de trabalho, este manual e todos os fluxos correspondentes à preparação e resposta a emergências e desastres.

4.8 Organograma de responsabilidades na gestão e preparação para emergências e desastres



5 SISTEMA DE GESTÃO DE EMERGÊNCIAS E DESASTRES

Com o objetivo de estar preparado para lidar e responder a situações emergenciais ou desastres, o Complexo Unimed Chapecó possui um sistema de gestão o qual coordena os serviços e as atividades antes, durante e depois da crise.

O Sistema de Gestão de Emergências e Desastres é composto pelo Comitê de Gerenciamento de Crise e pelo Grupo de Operação e se baseia nos planos, programas e fluxos citados neste manual, os quais foram desenvolvidos e estruturados para atender, com êxito, cenários de crise que possam se instalar nos âmbitos interno, local ou regional.

5.1 Acionamento do comitê de gerenciamento de crise

Ocorrerá quando houver situação de crise sanitária, recebimento de múltiplas vítimas (nível de resposta 2 ou 3) ou ocorrência interna de emergência (grau de risco médio ou alto).

5.1.1 Situação de crise sanitária

Identificada como tal quando houver uma ocorrência de surto, epidemia ou pandemia.

- **Surto**

Aumento acima do esperado na ocorrência de casos de evento ou doença em uma área ou entre um grupo específico de pessoas, em determinado período.

- **Epidemia**

Aumento no número de casos de uma doença em diversas regiões, estados ou cidades, porém sem atingir níveis globais.

- **Pandemia**

Disseminação mundial de uma nova doença que se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.

Situações de pandemia e epidemia, diversamente aos eventos locais agudos como surtos, ou ainda acidentes (item 5.1.2) e ocorrência interna (item 5.1.3), possuem alertas através dos serviços de vigilância epidemiológica governamentais. O comitê de gerenciamento de crise é acionado sempre que houver possibilidade real de eventos desta magnitude em nossa comunidade, identificados através das notas de alerta das vigilâncias epidemiológicas (municipal, estadual ou federal). Tais alertas possibilitam a realização de adequações conforme fluxo anexo em antecipação ao recebimento dos pacientes.

(1) Importante: Organização Mundial da Saúde (OMS) define quando uma doença se torna esse tipo de ameaça global é a Uma pandemia pode começar como um surto ou epidemia; ou seja, surtos, pandemias e epidemias têm a mesma origem - o que muda é a escala da disseminação da doença.

(2) Importante: Para situações de crise sanitária, seguir Fluxo FLU.INS.0021 CONDUTA DE PREPARAÇÃO E RESPOSTA A CRISE SANITÁRIA.

5.1.2 Admissão de múltiplas vítimas pelo Pronto atendimento

Identificação de situação clínica em que as vítimas estão sendo admitidas no Pronto atendimento, qualificando e quantificando-as por: número de acidentados, tipo de ferimentos, gravidade dos ferimentos, patologias e traumas.

Estes dados deverão ser obtidos pelos profissionais de plantão do hospital no momento dos primeiros atendimentos. O médico de plantão, com sua equipe, deverá definir imediatamente o nível de resposta, as ações que serão desencadeadas e informar ao Médico chefe da Equipe de resposta à emergência ou médico plantonista P1 (quando este não for o próprio chefe da equipe de resposta). Independentemente do nível de resposta, o Comitê de Gerenciamento de Crise deverá ser comunicado. Para nível de resposta 2 ou 3, o Comitê deverá ser acionado, conforme o fluxo "Preparação para atendimento a vítimas de acordo com o nível de resposta" (item 7.1.12).

Em caso de acionamento, o Médico chefe da Equipe de resposta (caso este esteja no local de trabalho) ou médico plantonista P1 informa a Telefonia através da menção do "CÓDIGO E", que aciona simultaneamente setores críticos (Centro cirúrgico, UTI's, Laboratório-agência transfusional, Unimagem-serviços de imagem), Grupo de Operação e Comitê de Gerenciamento de Crise. O Médico chefe da Equipe de resposta acionará o Plano de Resposta a Catástrofes e Atendimento a Múltiplas Vítimas e o conduzirá até a implantação do posto de comando.

5.1.3 Ocorrência interna

A identificação de uma ocorrência interna se dará pelo acionamento do alarme de incêndio ou através de ligação para o ramal exclusivo para emergências internas (ramal 2000). A avaliação do grau de risco da ocorrência será feita pelo SESMT, Coordenador ou Chefe da Brigada de Incêndio e pelo Coordenador de Manutenção e Engenharia clínica ou Técnico de manutenção. O grau de risco poderá ser classificado como baixo, médio ou alto, com base na avaliação do local, tipo de ocorrência e dos elementos presentes no cenário. Independentemente do grau de risco, os setores críticos e o Comitê de Gerenciamento de Crise deverão ser comunicados. Para grau de risco médio e alto, setores críticos, Comitê e Grupo de Operação deverão ser acionados, conforme o fluxo "Preparação para atendimento a vítimas de acordo com o nível de resposta" (item 7.1.12).

Em caso de acionamento, o Coordenador ou Chefe da Brigada informa a Telefonia, e esta, através de ligação, passa a mensagem "ALERTA, INCÊNDIO", acionando simultaneamente o Grupo de Operação e Comitê de Gerenciamento de Crise.

5.1.3.1 Ordem de abandono da edificação

Se o grau de risco da ocorrência for médio ou alto o Comitê de Abandono, composto pelos Coordenadores médicos do Pronto atendimento ou Médico plantonista P1, Coordenador de enfermagem do Pronto atendimento

ou Enfermeiro supervisor, Coordenador ou Chefe da Brigada de incêndio e Coordenador de Manutenção e Engenharia clínica ou Técnico de manutenção, se reunirá em frente a central de alarme na recepção adulta do P.A. para definir as ações que serão desencadeadas e em seguida a Telefonia deverá ser informada, a qual acionará imediatamente o Comitê de Gerenciamento de Crise e Grupo de Operação, conforme fluxo "Procedimentos de resposta para emergências internas" (item 6.2).

Caso seja necessário o abandono, será solicitado ao Auxiliar de atendimento do P.A (guichê 01) para realizar o disparo do alarme geral de incêndio. Para ocorrências de risco médio ou alto, o posto de comando deverá ser montado.

Tratando-se de ocorrência com vítimas, seguir o fluxo "Preparação para atendimento a vítimas de acordo com o nível de resposta" (item 7.1.12).

Importante: Independentemente do nível de criticidade e/ou grau de risco, o Corpo de Bombeiros e a Telefonia deverão ser acionados pelo Auxiliar de atendimento do Pronto atendimento (guichê 01) que receber a informação da ocorrência; a Telefonia informará os setores críticos e o Comitê de Gerenciamento de Crise. Para nível de criticidade 2 ou 3 e/ou risco médio e alto, o Comitê de Gerenciamento de Crise deverá ser acionado seguindo o fluxo (item 6.2) "Procedimentos de resposta para emergências internas". Os setores críticos serão acionados pelo Médico chefe de Equipe de resposta a emergência ou por profissionais afins.

5.2 Resposta a emergências e desastres

5.2.1 Notificação de emergência ou desastre

O Hospital Unimed Chapecó possui o número 3361-1810 (ramal 2001), exclusivo para emergências externas, para receber alertas e transmissões em nível local e regional. O sistema realiza interface com Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, PAM, Defesa Civil, Aeroporto Serafim E. Bertaso, Guarda Municipal e Hospital Regional do Oeste, com o objetivo de obter informações sobre as emergências e desastres em tempo hábil para se organizar e se preparar para responder a crise.

Os colaboradores do complexo recebem pela Telefonia, informações essenciais quanto à ativação dos procedimentos em caso de incêndio e de forma rápida, através de mensagem, via comunicar interno (*spark* ou *pandion*), "ALERTA, INCÊNDIO". Em casos de emergências externas e recebimento de múltiplas vítimas, os colaboradores envolvidos na resposta são acionados através da menção "CÓDIGO E".

Para que este sistema de notificação seja eficiente, os colaboradores recebem treinamento periódico e informações sobre os códigos padronizados e quais são suas responsabilidades e deveres. O sistema também utiliza códigos padronizados para definir diferentes estágios de ativação dos procedimentos, os quais definem como será o gerenciamento da crise com base na classificação do nível de resposta, ou seja, 1, 2 ou 3, e/ou na avaliação do grau de risco, ou seja, baixo, médio ou alto, a fim de minimizar mal-entendidos e evitar que pacientes e visitantes entrem em pânico.

5.2.2 Níveis de resposta (criticidade)

Os níveis de resposta da emergência ou desastre estão definidos com base no número de vítimas envolvidas ou esperadas e na capacidade de atendimento do hospital, seja com recursos próprios (colaboradores de plantão no Pronto atendimento), recursos internos (colaboradores de plantão em outros setores do hospital) ou recursos externos (colaboradores do hospital fora do horário de plantão).

CRITICIDADE	NÍVEL	COR
BAIXA CRITICIDADE	1	
SEMI CRÍTICO	2	
CRÍTICO	3	

5.2.2.1 Resposta de nível 1 – Baixa criticidade

Resposta com meios disponíveis no Pronto atendimento, porém com necessidade de acionar equipes de outros setores assistenciais. O atendimento ao fluxo habitual do Pronto atendimento não se altera, mas será adaptado à classificação de risco de catástrofes.

Ações de nível 1

1- Recursos humanos serão adicionados aos do Pronto atendimento para o atendimento às vítimas;

2- Liberação do turno bloqueado;

3- Ações desenvolvidas:

a. Recrutamento de outros setores disponíveis no hospital (contingência interna).

5.2.2.2 Resposta de nível 2 – Semicrítico

Resposta com recursos do hospital, ativados em situações de emergência, havendo necessidade de reorganização de funções dentro do turno de trabalho. O atendimento ao fluxo habitual do Pronto atendimento deverá ser alterado, de acordo com o tipo de emergência ou desastre.

Ações de nível 2

1- Recursos humanos serão adicionados aos do Pronto atendimento para o atendimento às vítimas;

2- Não liberação do turno bloqueado;

3- Ações desenvolvidas:

a. recrutamento de outros setores disponíveis no hospital (contingência interna);

b. esvaziar sala de emergência;

c. interromper classificação de risco da triagem;

d. acionar coordenadores médicos de especialidades;

e. bloquear cirurgias que não se iniciaram e cancelar internações para cirurgias eletivas;

f. recrutar leitos na sala de recuperação do centro cirúrgico;

g. providenciar leitos nas unidades de internação;

h. recrutar leitos nas UTI's viabilizando altas;

i. limitar exames laboratoriais.

5.2.2.3 Resposta de nível 3 - Crítico

Resposta com recursos mobilizáveis em situações de emergência, havendo necessidade de redimensionamento de funções dentro do turno habitual de trabalho e convocação de recursos externos visando à prioridade do evento. O atendimento ao habitual do Pronto atendimento deverá ser alterado, conforme fluxo de "Atendimento a múltiplas vítimas no pronto atendimento - nível de resposta 2 e 3 (item 7.1.16) e adaptado à classificação de risco de catástrofes. Não há liberação de turno.

Ações de nível 3

1- Recursos humanos do Pronto atendimento não são suficientes para o atendimento às vítimas.

2- Recrutamento de colaboradores em outros setores (contingência interna), conforme nível 2, e/ou em domicílio (contingência externa).

NÍVEL	*QUANTIDADE E PERFIL DAS VÍTIMAS	CONDUTA
NÍVEL 1 Baixa criticidade	Até 2 vítimas semicríticas e 2 críticas.	▪ Atendimento utilizando recursos de rotina do Pronto Atendimento e contingência interna das equipes assistenciais; ▪ Segurança terceirizada controla áreas de acesso à recepção e mantém um vigilante no local; ▪ Atuação do Grupo de Operação e Comitê de Gerenciamento de Crise, se necessário.
NÍVEL 2 Semicrítico	Até 4 vítimas semicríticas e 3 críticas.	▪ Atendimento com acionamento parcial das equipes internas (UTI / Anestesia / Cirurgia / Hospitalista); ▪ Segurança terceirizada isola áreas de acesso à recepção e mantém equipe no local para controle de acesso; ▪ Atuação imediata do Grupo de Operação e Comitê de Gerenciamento de Crise.
NÍVEL 3 Crítico	Número de vítimas ultrapassa o nível 2 até o limite de 10 semicríticas e 05 críticos.	▪ Atuação imediata do Grupo de Operação para restruturação do Pronto Atendimento para atendimento a emergência; ▪ Segurança terceirizada isola áreas de acesso à recepção e mantém equipe no local para controle de acesso; ▪ Atuação imediata do Grupo de Operação e do Comitê de Gerenciamento de Crise.

***Importante:** Para situações de crise sanitária, as ações e condutas implantadas dependerão do tipo de evento (surto, epidemia, pandemia), característica do agente, criticidade, via de transmissão, poder de contágio, considerando a capacidade máxima de 70 atendimentos simultâneos (máximo de 10 vítimas amarelas e 05 vermelhas) no Pronto atendimento.

5.2.3 Mapeamento dos riscos

A base do Plano de Atendimento a Situações Emergenciais Internas consiste na elaboração de uma análise de riscos, a qual é uma forma de se antever cenários e definir as medidas a serem implementadas, quer em termos de mitigação (convivência com o risco), prevenção (evitar sua ocorrência), ou intervenção (ação emergencial de controle).

O risco é um conceito probabilístico, ou seja, uma função do produto da probabilidade de ocorrência de um evento pela magnitude de seu impacto:

R= f (P x M), onde:

R- Risco **f- Função** **P- Probabilidade de Ocorrência** **M- Magnitude**

Ou ainda:

Risco = Frequência X Consequência

Para um conjunto de eventos distintos, temos que o risco é igual ao somatório de cada frequência e consequência (ou severidade) isolada (i), logo:

Risco = ∑Fi Ci logo,

A frequência pode ser expressa em: eventos/ano, acidentes/mês.

A consequência pode ser expressa em: fatalidades/evento, morte/acidente, R$/evento, dias perdidos/acidente.

O risco pode ser expresso em: fatalidades/ano, dias parados/mês, R$/ano, mortes/ano.

5.2.3.1 Análise de riscos

É a etapa inicial das medidas de planejamento e deve se basear em:

- identificação dos riscos locais;
- frequência / probabilidade: registro histórico de suas ocorrências (por escrito ou segundo histórico popular) e estimativa da probabilidade de sua ocorrência;
- consequência: magnitude esperada do evento;
- descrição dos riscos: compreensão da natureza e da identificação dos riscos com base em detalhadas informações;
- característica do desastre: descrevendo os elementos que compõe o desastre;
- forma de ocorrência: como é esperado o desastre vir a se manifestar;
- tempo de impacto: durante quanto tempo se espera que os efeitos do desastre durem;
- extensão do impacto: área de probabilidade aonde se manifestará provavelmente o desastre;
- maneabilidade do desastre: as formas pelas quais o desastre poderá ser administrado;
- descrição dos efeitos: descrição dos efeitos esperados do desastre;

- priorização dos riscos: especificando os maiores riscos em ordem de prioridade para fins de planejamento.

Fig. 1 – Etapas da Avaliação do Risco

5.2.3.2 Caracterização dos riscos

- Baixo Risco: intensidade e consequência baixa.
- Médio Risco: intensidade e consequência média.
- Alto Risco: intensidade e consequência alta.

5.3 Posto de comando da crise

O sistema de gestão de emergências e desastres estabelece como local central para gerenciar a resposta a uma situação de emergência a Sala da Diretoria que passa a se chamar de "Posto de Comando". Na impossibilidade do local, o posto deverá ser montado em outro espaço apropriado e seguro, mesmo que improvisado.

O posto de comando será montado sempre que o nível de criticidade for 2 ou 3, ou grau de risco médio ou alto e este estabelecerá contato com as demais áreas envolvidas na resposta à emergência através de rádio de comunicação.

5.3.1 Estrutura de comando no posto

Comandante da Crise
Líder do Comitê de Gerenciamento de Crise

↓

Equipe de Comando
Presidente, Diretor Hospitalar, Diretor Técnico, Diretor Cínico, Diretor de Marketing, Diretor Corporativo.

↓

Chefes de Operação
Gerentes e Coordenadores/Representantes (Enfermagem, Pronto atendimento, Financeiro, Gestão de Suprimentos, Farmácia, Manutenção e Engenharia clínica.

5.3.2 Preparação do local para atendimento às vítimas - Pronto atendimento

Organização das vítimas

ZONA	ESTADO DAS VÍTIMAS	PRIORIDADE	COR
1	Vítimas em risco de morte	1	Vermelho
2	Vítimas urgentes	2	Amarelo
3	Vítimas pouco urgentes (deambulam)	3	Verde
4	Óbitos		Preto

Organização da triagem

- Utilização do fluxo de avaliação primária da triagem da Classificação de Manchester, na entrada do Pronto atendimento (descrito na sequência deste Manual);
- Utilização do fluxo de avaliação secundária da Classificação de Manchester, a cada 15 minutos, na zona de vítimas pouco urgentes (verde). Em caso de mudança de cor, a vítima deve ser realocada.

Organização de estoques – Fármacos, consumíveis e equipamentos

Materiais e medicamentos:

- pulseiras identificadoras;
- antídotos.

Importante: Em caso de crise sanitária, (surto, epidemia, pandemia) o estoque de materiais e medicamentos dependerá do agente causador e dos cuidados indicados para este.

Equipamentos e logística:

- Macas de transferência;
- Macas fixas;
- Camas;
- Cilindros de oxigênio;
- Suportes de soro;
- Monitores sinais vitais (monitores multiparâmetros);
- Monitores oximetros;
- Bombas de infusão;
- Ventiladores mecânicos de transporte;
- Ventiladores mecânicos;
- Roupas de cama e roupas para vítimas;
- Roupas para profissionais;
- Água potável para vítimas e profissionais;
- Reforço alimentar para vítimas e profissionais.

Identificação dos profissionais – Cartão de responsabilidades

- Cada profissional terá o seu cartão junto ao seu crachá de identificação.
- Para cada profissional devem estar listadas as tarefas a serem desenvolvidas, em caso de ativação do Plano. Esta listagem deve estar hierarquizada, ou seja, por ordem decrescente de importância e prioridade, para possibilitar que cada um as desempenhe sequencialmente.
- Devem existir tantos cartões, quantas as várias categorias profissionais:

1. Cartões do Comitê de Gerenciamento de Crise;

2. Cartões do Grupo de Operação;

3. Cartões da Equipe de Resposta à Emergência;

4. Cartões da Equipe de Apoio;

5. Cartões da Equipe de Retaguarda

5.3.3 Organização da área física

5.3.3.1 Atendimento às vítimas

Vítimas pouco urgentes (verdes) e urgentes (amarelas): serão atendidas na sala de triagem adulto/corredor do Pronto atendimento. As vítimas que ainda necessitarem ficar em observação serão encaminhadas à sala de emergência.

Vítimas em risco de morte (vermelhas): serão atendidas na sala de emergência. As vítimas, após o primeiro atendimento, serão encaminhadas ao setor de UTI / Centro cirúrgico.

5.3.3.2 Atendimento aos familiares

Os familiares deverão aguardar na recepção adulta do setor de Pronto atendimento onde serão acolhidos pelas psicólogas e assistentes sociais para receber informações e apoio.

Estes profissionais avaliarão a possibilidade de visitação do familiar ao paciente durante o seu atendimento, e em casos de impossibilidade de contato direto (por isolamento ou mesmo por aumento significativo da demanda) viabilizam vídeo chamadas com o telefone celular da instituição Avaliam também, de acordo com a necessidade (decisão em conjunto com a equipe médica), o acesso a acompanhantes durante o período de atendimento/internação.

5.4 Plano de comunicação para emergências e desastres

O Plano de Comunicação está descrito na Política Institucional PLI.COM.0003 contemplando procedimentos de emergência para o compartilhamento de informações para o público interno e externo. Identifica também as informações e mensagens essenciais que precisam ser enviadas e recebidas diante de emergências e desastres que possam envolver a instituição e o público a qual se relaciona, bem como as pessoas e a forma que as informações devem ser transmitidas.

O Plano de Comunicação inclui informações de contato 24 horas para o público interno e externo:

- Internamente, os principais contatos incluem o presidente da Unimed Chapecó e demais gestores; coordenadores dos setores de apoio.
- Externamente, os principais contatos incluem as Secretarias Municipais de Saúde Pública, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Hemocentro, Hospital Regional do Oeste e Hospital Materno Infantil e demais hospitais da região caso seja necessário, Instituto Médico Legal, Defesa Civil, imprensa, funerárias, e autoridades de saúde em nível local, regional e nacional.

O Plano também prevê quem são os integrantes e seus papéis e responsabilidades, quando acionado. Os métodos de comunicação que serão utilizados para receber informações do local do incidente, sobre as vítimas que serão levadas para atendimento no hospital e sobre a situação no local, incluem: ramal de emergência, rádios de comunicação e *WhatsApp*.

Importante: O Plano de Comunicação será acionado em qualquer situação de emergência ou desastre, independente do nível de criticidade.

5.5 Restabelecimento estrutural

5.5.1 Medidas de recuperação

O Complexo Unimed Chapecó utiliza uma abordagem estruturada de recuperação de sistemas e serviços após a ocorrência de emergências ou desastres. Na ocorrência destes, uma lista contemplando itens estruturais e equipamentos (paredes, telhado, piso, monitores de sinais vitais, ventiladores de transporte, suporte de soro...) que poderão ter sofrido algum tipo de dano, será avaliada e na constatação de avaria, estes serão consertados ou substituídos.

5.5.1.1 Sistemas de *backup*

O Complexo Unimed Chapecó dispõe de sistemas de backup para serviços e sistemas essências, possibilitando que estes sejam recuperados, bem como políticas e procedimentos para o restabelecimento das operações normais e a reposição de insumos após uma emergência ou desastre.

Serviços essenciais

Elevadores

O Hospital da Unimed (estrutura vertical) possui dois elevadores na área de serviço e dois elevadores no hall social, com funcionamento individualizado e contrato com fornecedor para a realização de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica local para casos de emergência.

Vapor para esterilização

Em caso de falta de água para as autoclaves da CME, será acionado o sistema de abastecimento de água da concessionária distribuidora.

Sistemas de comunicação

Em caso de falha no sistema de telefonia, o setor de Tecnologia e Informação fará a avaliação do problema, e na impossibilidade de solucionar, entrará em contato com a empresa responsável pela manutenção. O sistema de telefonia é dotado de tecnologia de virtualização, o qual está localizado em servidores que ficam em datacenters.

Sistemas de informação

Os sistemas de informação do Complexo Unimed Chapecó trabalham em ambiente de alta disponibilidade, com dois *datacenters* redundantes, instalados um em cada prédio (estrutura vertical e horizontal). Para o sistema de prontuário eletrônico – PEP, extremamente crítico, é disponibilizado um computador em cada posto de trabalho onde constam informações clínicas dos pacientes que estão internados, para servir em situação de indisponibilidade dos sistemas.

Para a realização dos registros, o complexo possui uma estrutura de armazenamento com *datacenters* redundantes e sua política de backup estabelece cópia dos dados de forma diária com retenção e redundância. Para obtenção do número de colaboradores, pacientes e acompanhantes que estão diariamente nas instalações do hospital, o setor de Tecnologia da Informação está desenvolvendo, um programa de contagem que contribuirá de forma positiva em situações de emergência ou desastre, onde esses dados são de suma importância.

Para a restauração de bases de dados em eventuais necessidades, há uma política de backup e restauração, a qual fica sob o domínio e responsabilidade do setor de Tecnologia e Informação.

5.5.1.2 Serviços públicos essenciais

Abastecimento de oxigênio líquido

Para o restabelecimento do produto, o setor de Manutenção informará a empresa fornecedora Airliquid®, para providenciar o abastecimento o mais rápido possível e informar nº do tanque de oxigênio 367 e o código do cliente 111963.

Abastecimento de ar comprimido

Na falta de ar comprimido por problema no compressor será utilizado o banco de cilindro de backup com dois jogos de três cilindros, localizados na sala do compressor.

Abastecimento de água

Em caso de falha no funcionamento dos poços, o setor de Manutenção deverá entrar em contato com a assistência técnica - Leão Poços e ligar a entrada de água fornecida pela concessionária distribuidora.

Fornecimento de energia elétrica

Na falta de energia elétrica, o setor de Manutenção entrará em contato com a empresa concessionária solicitando informações quanto à queda de energia e o tempo de retorno e acionará o grupo de geradores.

Abastecimento de combustível

Na falta de combustível para os geradores o setor de Manutenção entrará em contato com o fornecedor, solicitando com brevidade o reabastecimento.

Sistema a vácuo

O setor de Manutenção possui em estoque peças de reposição para eventuais falhas e conta com manutenção preventiva mensal da assistência técnica. Políticas e procedimentos para o restabelecimento das operações normais e reposição de insumos após uma emergência ou desastre.

Insumos hospitalares

Em situações de crise sanitária sistêmica (epidemia e pandemia) há possibilidade de desabastecimento de insumos hospitalares e equipamentos de proteção individual para os trabalhadores. Nestes casos, o setor de Gestão de Suprimentos deve ser acionado antecipadamente para programação do fornecimento adequado para manutenção do atendimento e nível de estoque, prevendo eventuais dificuldades de obtenção dos materiais.

5.5.1.3 Restabelecimento das operações normais e reposição de insumos após emergência ou desastre

Estrutura física

Na ocorrência de emergência ou desastre que venha comprometer a estrutura física, o Hospital Unimed Chapecó conta com o seguro patrimonial para o prédio e seu conteúdo, atualmente com a seguradora Seguros Unimed, apólice número 019702019010118000314, através da Unicred SC/PR Corretora e Administradora de Seguros LTDA (Anexo 9 - Listagem de Fornecedores Por Área de Insumos e Serviços).

Esta apólice apresenta as seguintes modalidades e coberturas contratadas: incêndio, inclusive decorrente de tumultos, queda de raio, explosão, implosão, fumaça, queda de aeronave, vendaval, furacão, ciclone, tornados, granizo, impacto de veículos, danos elétricos, equipamentos estacionários, equipamentos móveis, e equipamentos eletrônicos.

Importante: Em situações inesperadas como sinistros, ou que ultrapassem a capacidade financeira prevista, como uma crise sanitária sistêmica (epidemia ou pandemia), que exijam demandas de recursos financeiros adicionais, será acionado o plano de contingência, a fim de não comprometer a funcionalidade das atividades do Complexo Unimed Chapecó.

Limpeza

Após uma emergência ou desastre, faz-se necessário reestabelecer as condições essenciais de higiene para que o trabalho de assistência às vítimas seja continuado. Para tanto, é preciso além de retirar a sujidade visível, realizar desinfecção de móveis e ambientes - com técnica e produto específico, padronizados pela instituição.

Desta forma, a escala de trabalho dos colaboradores do setor de higienização será momentaneamente readequada conforme necessidade, priorizando setores emergenciais. Na falta de mão de obra de higienização, serão convocados os colaboradores fora de horário de trabalho, conforme demanda de tarefas e provisionamento de equipe, visando suprir rotinas indispensáveis.

Caso o número de colaboradores disponíveis ainda não supra a demanda de atividades, será acionada empresa de terceirização de mão de obra de higiene padrão, para a realização de atividades que não exijam conhecimento técnico em higiene hospitalar, como exemplo: limpeza e lavagem ambientes externos como paredes, calçadas, rampa, limpeza do terreno, limpeza de banheiros não utilizados por pacientes, etc.

Reaproveitamento e descarte de resíduos

O Hospital Unimed Chapecó possui contrato com empresas coletoras de resíduos especializadas. Os resíduos perigosos são coletados uma vez por dia de segunda a sexta-feira nas dependências do hospital, e havendo necessidade de aumentar essa frequência será acionado o gerente desta para proceder conforme demanda.

Os resíduos não perigosos, recicláveis, são coletados por Associação de Catadores de Chapecó, havendo demanda acima do normal, esta será acionada pela Sustentabilidade, para aumentar frequência, a qual também pode ser suprida por uma das outras 14 associações de Chapecó, bem como pela coleta municipal. Os resíduos não perigosos não recicláveis são coletados pelo município, e em caso de maior demanda o setor responsável será acionado. Ressaltamos que ambas empresas estão localizadas (ou possuem transbordo) em Chapecó, facilitando o aumento de frequência de coleta.

Recarga de extintores

Estão disponíveis aproximadamente 250 extintores (PQS, CO2, Água Pressurizada, Fe 36), localizados em diversos pontos do complexo. Em caso de emergência, os extintores utilizados serão recolhidos pela empresa prestadora para recarga, a qual disponibilizará no menor tempo possível, 20 extintores reservas de PQS (pó químico). O prazo para entrega dos extintores recarregados será de 48 horas.

5.6 Serviços de apoio aos colaboradores

Serão oferecidos serviços de apoio imediato para o bem-estar dos colaboradores em crise após a situação de emergência ou desastre, os quais tiveram envolvimento no evento, seja como vítimas ou como prestadores de atendimento.

5.6.1 Resumo de Informações

Será realizada reunião para repasse de informações para os colaboradores, vítimas e seus familiares, e a comunidade, com o objetivo de amenizar sintomas agudos, reconhecer a necessidade de acompanhamento e, se possível, promover um sentido de aprendizado e superação da crise. Se houver necessidade, o resumo pode ser repassado através de um fórum aberto às instituições parceiras e à comunidade.

5.6.2 Apoio psicológico

A identificação desta necessidade se dará através de avaliação ocupacional pós emergência ou desastre, feita pela psicóloga da Saúde ocupacional e pela Médica do trabalho, ou pelos setores de contingência (Gestão de pessoas, Unimed multiprofissional, Unimed Personal e Rede credenciada) caso o número for superior a 15 atendimentos por semana.

Após 3 encontros com a psicóloga da Saúde ocupacional ou profissional da contingência, havendo necessidade e/ou aceitação do colaborador receber apoio psicológico, este será encaminhado para o Serviço de acompanhamento periódico na Unimed Personal (apoio e orientação psicológica continuada) ou participação no Programa de intervenção em caso de crise (psicoterapia individual e grupo terapêutico) no serviço de psicologia - Unimed multiprofissional.

5.6.2.1 Acompanhamento periódico

Passado o momento da emergência ou desastre, algumas pessoas demoram a compreender os fatos e/ou tem dificuldade em pedir ajuda. Para tanto, serão oferecidos aos colaboradores, apoio e orientação psicológica

individualizada de forma contínua para lidarem melhor com o estresse, o sofrimento e a perda. O acompanhamento será feito por no máximo 12 meses, onde o colaborador é chamado periodicamente para avaliação psicológica na Unimed Personal.

5.6.2.2 Programa de intervenção em caso de crise

O objetivo do programa é oferecer ajuda aos colaboradores a se recuperarem após uma emergência ou desastre, com ênfase em mantê-los seguros e incentivá-los a voltar rapidamente à normalidade de suas atividades. O programa permite que o colaborador fale sobre o evento sem que ele se sinta julgado ou criticado, podendo optar pelo serviço de psicoterapia individual e/ou grupo terapêutico. O programa contempla os serviços de psicoterapia individual, cuja frequência será de acordo com a avaliação, e grupo terapêutico, que acontecerá semanalmente. Ambos terão duração de 3 meses, a contar da data de adesão do colaborador.

Psicoterapia individual

O serviço de psicologia – Unimed multiprofissional colocará à disposição dos colaboradores quatro psicólogas exclusivas para a demanda, sendo que as demais profissionais ficam de sobreaviso. A profissional trabalha em conjunto com o colaborador e havendo a necessidade faz intervenções familiares e com outros profissionais (ex.: médico psiquiatra).

Grupo terapêutico

Grupo voltado para o cuidado emocional do colaborador para auxiliá-lo a se recuperar após uma situação de emergência ou desastre, onde os encontros serão conduzidos por psicólogas capacitadas. Será um espaço para acolhida e avaliação dos sintomas apresentados.

Importante: Os serviços de apoio aos colaboradores serão oferecidos gratuitamente pela instituição, por um período avaliado pela psicóloga, não ultrapassando a duração estabelecida de cada programa. Casos específicos que não tiverem alta durante este período serão encaminhados ao médico do trabalho na Saúde ocupacional para serem tratados individualmente.

5.6.3 Funcionamento dos serviços de apoio

1° Após avaliação do médico do trabalho, o colaborador é encaminhado para a psicóloga da Saúde ocupacional para acolhimento;

2° Percebida a necessidade, a psicóloga repassa ao colaborador informações pertinentes quanto aos serviços de apoio disponíveis e avalia qual se encaixa melhor (Acompanhamento periódico na Unimed Personal ou Programa de Intervenção - psicoterapia individual e/ou grupo terapêutico no serviço de psicologia - Unimed multiprofissional); o colaborador pode optar por fazer parte do grupo terapêutico simultaneamente à psicoterapia individual;

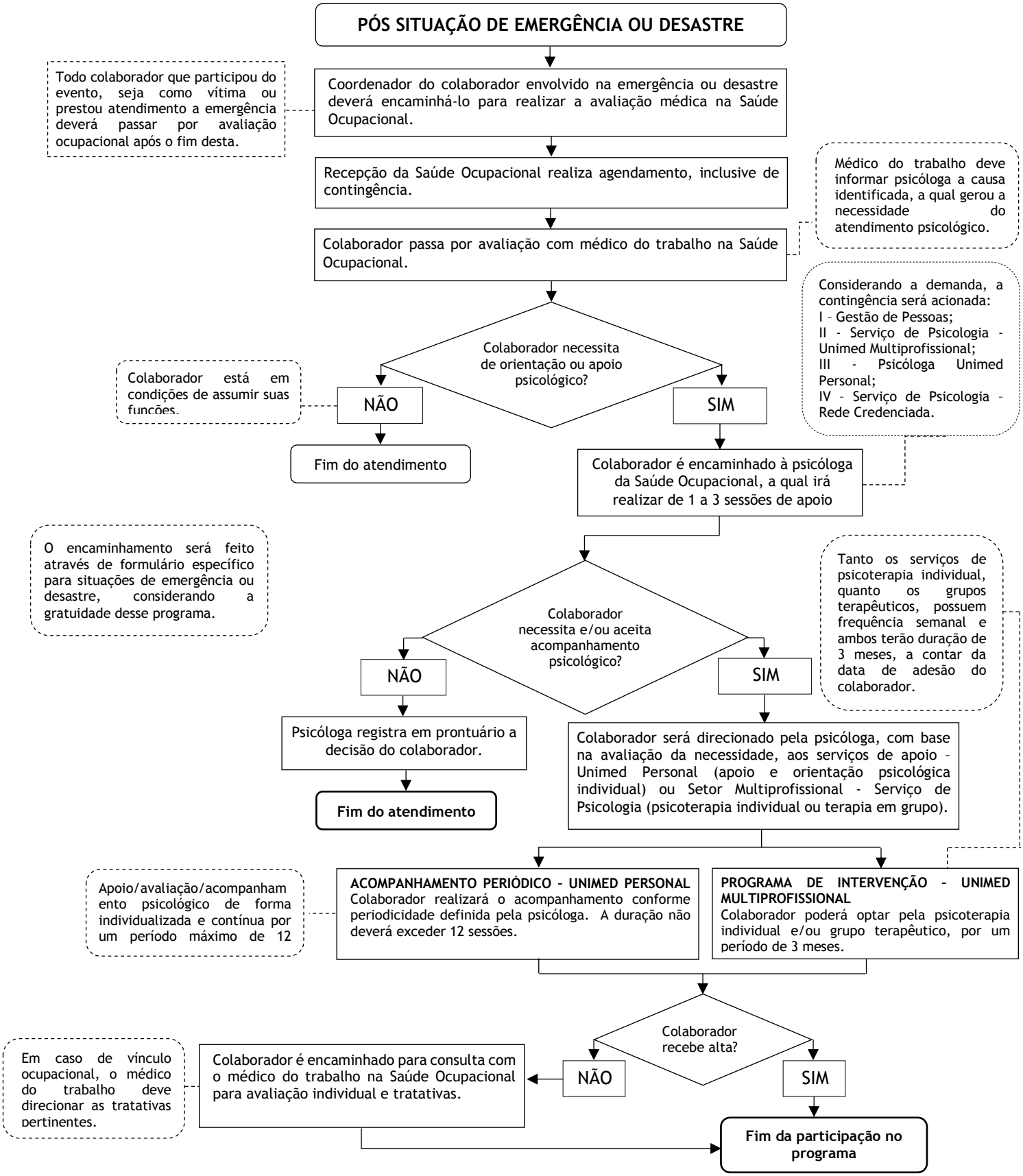
3º Percebida a necessidade de acompanhamento pela psicóloga da Unimed Personal, o colaborador será chamado periodicamente, a fim de receber orientação psicológica continuada. Mesmo sendo percebida a necessidade de encaminhamento do colaborador ao Programa de Intervenção, o mesmo pode optar por fazer somente o acompanhamento;

4° Percebida a necessidade de psicoterapia individual, o colaborador é encaminhado ao setor de psicologia, onde permanece sob os cuidados profissionais de uma das psicólogas que dará continuidade ao processo psicoterápico;

5° Percebida a necessidade de participação no grupo terapêutico, o colaborador é encaminhado ao serviço de psicologia para fazer parte do programa. O grupo é aberto aos colaboradores e estará em constante acolhimento de novos integrantes, sendo que a participação será por um período de 3 meses.

Importante: Critérios de alta: remissão dos sintomas provocados a partir da situação estressora. Serão avaliados pelos profissionais psicoterapeutas.

5.6.3.1 Serviços de apoio psicológico para colaboradores pós-situação de emergência - FLU.INS.0025



6 APÊNDICE I

6.1 Plano de atendimento a situações emergenciais internas

6.1.1 Apresentação

Este Plano foi elaborado para direcionamento de ações rápidas e eficientes em situações de emergências internas com o propósito de formar uma equipe preparada para agir dentro do Complexo Unimed Chapecó, para atender colaboradores, pacientes e seus acompanhantes, terceiros e clientes.

6.1.2 Objetivo

Fornecer um conjunto de diretrizes e informações visando à adoção de procedimentos lógicos, técnicos e administrativos, estruturados de forma a propiciar resposta rápida e eficiente em situações emergenciais.

Objetivos específicos

- Possibilitar que os possíveis danos se restrinjam a uma determinada área, previamente dimensionada, evitando que os impactos extrapolem os limites de segurança pré-estabelecidos.
- Contemplar todas as ações necessárias para evitar que situações, internas ou externas, às instalações envolvidas no acidente, contribuam para o seu agravamento.
- Ser um instrumento prático, que propicie respostas rápidas e eficazes em situação de emergência.
- Evitar que um acidente de pequeno porte se transforme em um acidente de grandes proporções.
- Restringir ao máximo os impactos numa determinada área (avaliação dos responsáveis) ou até na edificação.
- Todos os colaboradores da instituição devem ter conhecimento do Plano de Atendimento a Situações Emergenciais Internas.
- Ser permanentemente atualizado e periodicamente revisado, de acordo com a experiência adquirida ao longo do tempo, tanto em atendimentos reais, como nos treinamentos realizados.

6.1.3 Implantação e manutenção do plano

Para que as ações previstas neste Plano resultem efetivamente nos resultados esperados, quando da ocorrência de situações emergenciais, este deve ser divulgado internamente, além de ser integrado com entidades que atuarão conjuntamente na resposta a emergências, se for necessário, tais como Corpo de Bombeiros, SAMU, PAM e Defesa Civil.

A implantação do Plano, além da devida divulgação, está associada ao suprimento dos recursos, humanos e materiais, necessários e compatíveis com o porte das possíveis ocorrências a serem atendidas.

A manutenção do Plano é feita através da atualização e da revisão periódica, de acordo com a experiência adquirida ao longo do tempo, tanto em atendimentos reais, como nos simulados realizados. A manutenção contemplará a atualização de informações, da reavaliação periódica dos procedimentos e da reposição e renovação dos recursos.

Importante: Todos os coordenadores deverão ter uma cópia do Plano de Atendimento a Situações Emergenciais Internas e repassar para suas equipes.

6.1.4 Prevenção a situações emergenciais

A prevenção, juntamente com as Normas Regulamentadoras (NRs), cujo cumprimento é exigido no projeto das edificações, são ferramentas utilizadas pelo Complexo Unimed Chapecó para prevenir a ocorrência de desastres. Através delas, cada colaborador pode contribuir para a sua própria segurança, bem como dos ocupantes do ambiente ao qual faz parte. A prevenção às emergências procura detectar as situações de risco e evitá-las, além de definir de antemão os procedimentos a serem adotados caso o sinistro ocorra.

A Lei nº 6.514/1977 aprovada pela Portaria 3.214 de junho de 1978 em sua NR 23 – Proteção contra Incêndios, como também a NBR 14.276, determinam que as empresas adotem medidas de prevenção e estabelecem o seguinte: *"Toda empresa deverá possuir proteção contra incêndio, saídas de emergências suficientes para a rápida retirada do pessoal de serviço em caso de incêndio, equipamento suficiente para combater o fogo em seu início e pessoas treinadas no uso correto desses equipamentos"*. Para tal, o complexo possui instaladas placas de sinalizações, placas de rotas de fuga, plantas de emergência, mapas de risco, extintores, hidrantes, equipe de Brigada de incêndio, treinada e capacitada para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros e equipe de Remoção de pacientes, composta por colaboradores de áreas de apoio, enfermagem e equipe médica.

6.1.5 Grupo de ação

- SESMT
- Equipe de Manutenção e Engenharia clínica
- Coordenação Brigada de Incêndio
- Brigada de Incêndio
- Comitê de Gerenciamento de Crise
- Grupo de Operação
- Equipe de Resposta à Emergência
- Equipe de Remoção de Pacientes
- Equipe de Evacuação

6.1.6 Grupo de apoio

- Comitê de Abandono
- Telefonia
- Marketing
- Segurança Patrimonial Terceirizada
- Conselho Gestor

6.1.7 Medidas de prevenção de incêndio e emergências

Dentre as medidas de prevenção adotadas pelo Complexo Unimed Chapecó, está:

- Proibição do ato de fumar em todas as dependências do complexo, conforme Lei Estadual nº 3.576/2008 e Norma Regulamentadora 32 - item 32.2.4.5, alínea b.
- Proibição do uso de adaptadores de tomada, tipo T ou Benjamin, nas instalações elétricas do complexo, assim como a presença de cilindros de GLP no interior das edificações.
- Limitação de armazenamento de líquidos inflamáveis nos setores de 5 litros de cada produto, e sempre que possível devem ser adotadas embalagens de até 500 ml.
- Desconexão das tomadas de energia de todos os equipamentos elétricos fora de uso, exceto aqueles de suporte à vida que necessitem manter as baterias em constante carregamento ou que necessitem de modo "*stand by*" energizado.
- Execução de instalações e manutenções elétricas realizadas somente pelo setor de Manutenção e em caso de terceiros, por profissionais autorizados pela instituição.
- Sinalização de áreas e locais de trabalho, quanto à presença de produtos inflamáveis, tóxicos e demais riscos.
- Realização de treinamentos de segurança contendo as instruções sobre combate a princípio de incêndio e evacuação de áreas e conceitos de prevenção de incêndios.
- Participação ativa da Brigada de Incêndio na prevenção de sinistros através de treinamentos, visitas de reconhecimento da edificação, exercícios simulados.
- Realização de inspeções periódicas com o objetivo de identificar situações de risco e apontamentos de medidas corretivas e de controle.
- Na etapa de planejamento de obras, construções e reformas o setor de Saúde ocupacional deve ser consultado para avaliação dos riscos e apresentação das recomendações pertinentes, conforme estabelece o fluxo de conduta para obras no complexo.
- Toda obra ou reforma, antes do seu início, deve ser informada ao setor de Saúde Ocupacional para avaliação do risco e classificação, conforme matriz de risco.

De forma a garantir a prevenção de incêndios e de emergências no Complexo Unimed Chapecó, institui-se que também é proibido:

- O armazenamento de materiais próximos a lâmpadas ou outras fontes de calor.
- O armazenamento de produtos inflamáveis em locais não destinados para esse fim.
- A utilização de inflamáveis próximos a fontes de calor.
- O uso de elementos elétricos na decoração de natal dos setores.
- O uso de equipamentos elétricos danificados, com funcionamento anormal, com suas características originais alteradas ou com cabos elétricos danificados ou expostos.

6.1.8 Medidas de sinalização e sistemas de alarme de incêndio

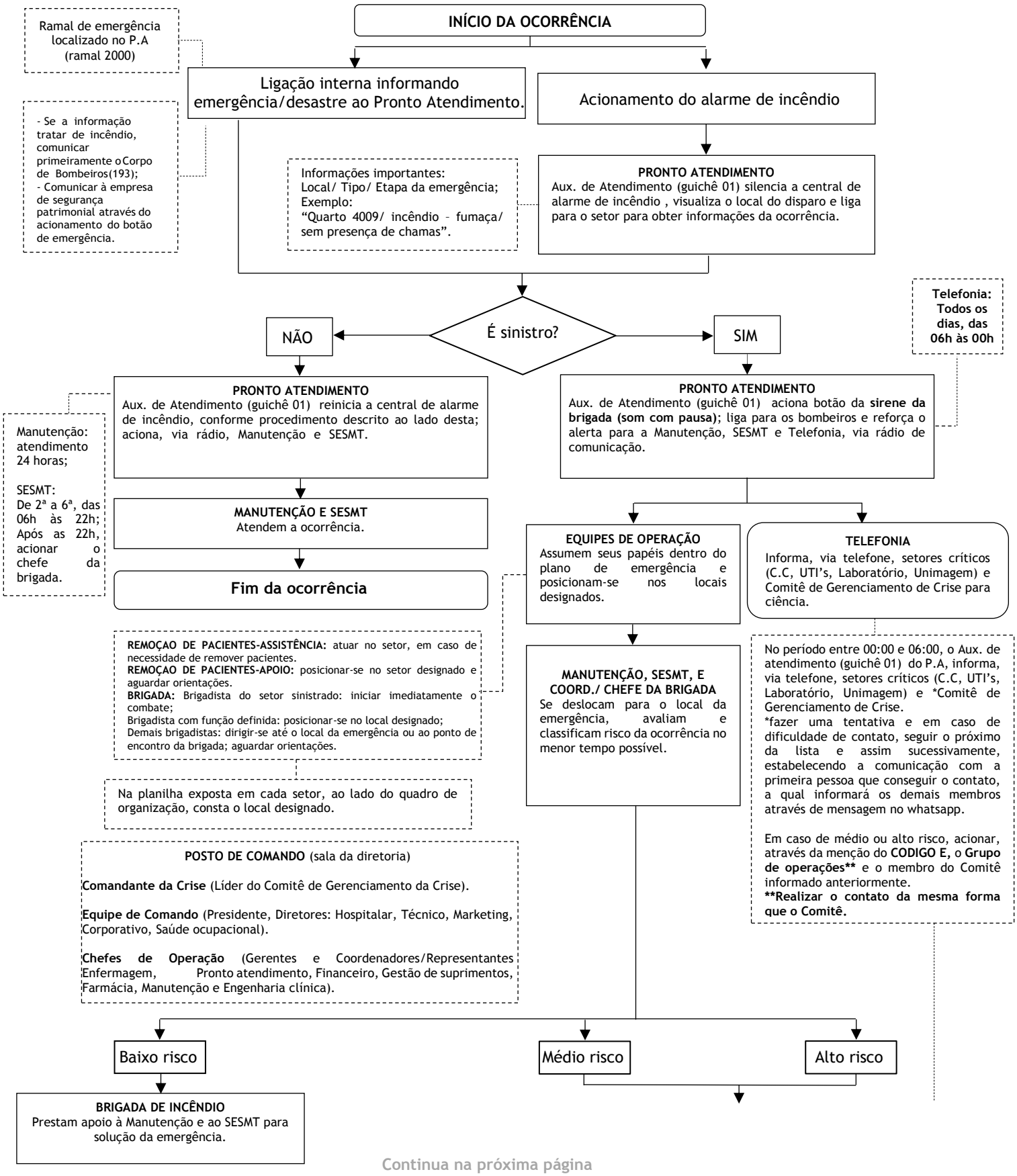
Além da sinalização dos meios de combate a incêndio e de alerta sobre riscos de incêndio, todas as edificações possuem sinalização fotoluminescente das rotas de fuga e saídas de emergência, bem como plantas baixas contendo o desenho da localização das rotas de fuga, dos recursos disponíveis e dos pontos de encontro.

6.1.9 Medidas de detecção de incêndio

Para minimizar os danos decorrentes de um incêndio, limitando seu crescimento e propagação, estão instalados detectores de fumaça e de calor em cada prédio do hospital (estrutura vertical e horizontal) e cinco centrais de alarme. Uma está localizada na Central de Serviços (independente); duas localizadas no antigo setor B e outras duas no Pronto Atendimento, interligando as duas edificações (antiga e nova) possibilitando a identificação mais rápida de um possível foco de incêndio.

6.1.10 Medidas de supressão de incêndio

Os recursos e mecanismos de supressão de incêndios disponíveis no Complexo Unimed Chapecó consistem em extintores de incêndio portáteis, sistema pressurizado de hidrantes, reservatório de água. A quantidade de recursos, bem como sua localização, está descrita no Plano de Emergência e Abandono. Procedimentos de resposta para emergências internas - FLU.INS.0027



Continua na próxima página

COORD. OU CHEFE DA BRIGADA
Aciona, via rádio, o Comitê de Abandono para definir as ações que serão desencadeadas; solicita à Telefonia que acione, via telefone, através da menção do **CÓDIGO E**, o Grupo de Operação e Comitê de Gerenciamento de Crise, para se deslocar até o Hospital (cada membro assumirá seu papel dentro do plano de emergência).

COMITÊ DE ABANDONO
Coordenadores médicos do Pronto atendimento ou Médico plantonista P1, Coordenador de enfermagem do Pronto atendimento ou Enfermeiro supervisor, Coordenador ou Chefe da Brigada de incêndio e Coordenador de Manutenção e Engenharia clínica ou Técnico de manutenção.

Abandono total?

NÃO

COORD. OU CHEFE DA BRIGADA
Informa via rádio, a ordem de abandono parcial.

EQUIPES DE OPERAÇÃO
Iniciam os procedimentos de abandono do setor sinistrado e áreas próximas.

Setor possui pacientes?

NÃO

SIM

MÉDICO E / OU ENFERMEIRO
Organiza a remoção de pacientes de acordo com escala de prioridade; solicita ao setor de Atendimento Hospitalar leitos para remanejar pacientes.

ENFERMAGEM
Prepara o paciente para remoção e orienta equipe de apoio para transporte.

EQUIPE DE APOIO
Auxilia a enfermagem na remoção de pacientes até os leitos remanejados.

SIM

COORD. OU CHEFE DA BRIGADA
Avisa Aux. de Atendimento (guichê 01) do Pronto Atendimento para disparar **alarme geral (som contínuo)**; iniciam-se imediatamente os procedimentos de abandono da edificação.

EQUIPES DE OPERAÇÃO
Iniciam os procedimentos de abandono da edificação.

MÉDICO E / OU ENFERMEIRO
Organiza a remoção de pacientes de acordo com escala de prioridade.

ENFERMAGEM
Prepara o paciente para remoção e orienta equipe de apoio para transporte.

EQUIPE DE APOIO
Auxilia a enfermagem na remoção de pacientes até o ponto de encontro.

CABEÇA DE FILA
Conduz população até o ponto de encontro.

FIM DE FILA E/OU CHEFE DE SETOR
Faz varredura no setor, sinaliza portas e comunica evacuação ao líder do andar/setor.

POPULAÇÃO
Aguarda ordem de liberação ou não para retorno ao setor/ edificação a ser dada pelo Corpo de Bombeiros.

Fim da emergência

COORDENADOR OU CHEFE DA BRIGADA 2
Desmobiliza os procedimentos da brigada e avisa colaborador do PA para reiniciar a central.

Fim da emergência

GRUPO DE OPERAÇÃO
Gerentes, Técnico de manutenção de plantão, profissionais do Pronto atendimento: Médico Chefe de Equipe, Enfermeiro supervisor e Auxiliar Administrativo.

COMITÊ DE GEREN. DE CRISE
Médico do trabalho, Diretores Técnico, Hospitalar, Clínico, Marketing, Coordenadores Unidades de Internação, Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico e UTI's, Coordenador Gerenciamento de leitos, Cotep, Gestão de suprimentos, Tecnologia da informação, Saúde ocupacional, Manutenção e Engenharia clínica.

PONTOS DE ENCONTRO:

PONTO 1: área externa, em frente ao Pronto Atendimento, na Rua Barão do Rio Branco;
PONTO 2: área externa, em frente a Central de Serviços, na Rua Marechal Floriano Peixoto;
PONTO 3: área externa, em frente ao Atendimento Hospitalar, na Rua Porto Alegre.

Em casos de emergência/desastre interno, e não havendo condições de atendimento no P.A o Colégio Exponencial cederá espaço para atendimento a vítimas e pacientes.
Ligar para:
- Colégio Exponencial: (49)3323-1032, 2ª a 6ª, 07h às 22h;
Nos demais dias e horários:
- Élio Antonio Maldaner: (49)331186684 / 999338080
- Monitoramento Digitek 24h: (49)33242152 / 991146600
- Arsílio Piva: (49)33224609 / 998032777

6.2 Plano de emergência e abandono

É um conjunto de medidas de autoproteção, organização e procedimentos que envolvem desde a prevenção, planejamento de ações e atuações em caso de emergência. O objetivo é reduzir as probabilidades de ocorrência de acidentes e limitar suas consequências a fim de evitar a perda de vidas humanas ou bens materiais, além de prevenir traumas resultantes de uma situação de emergência.

O Plano de Emergência e Abandono – PEMA, do complexo Unimed Chapecó descreve o padrão de orientação e procedimentos a serem adotados pelos colaboradores, pacientes e seus acompanhantes, terceiros e clientes quando da ocorrência de uma emergência. O plano visa o estabelecimento de rotinas e procedimentos que são testados periodicamente através de exercícios simulados. O PEMA foi elaborado com base nos critérios normativos estabelecidos pela Instrução Normativa IN 031/DAT/CBMSC, com periodicidade de atualização anual.

6.2.1 Medidas de evacuação de áreas

As edificações do Complexo Unimed Chapecó são dotadas de saídas de emergência compostas primordialmente por escada e rampas. As rotas de fuga são sinalizadas e indicam o percurso mais curto a ser percorrido no abandono das instalações.

Em caso de evacuação das instalações, todos os pacientes em condições clínicas e de deslocamento deverão ser liberados imediatamente, juntamente com seus acompanhantes e visitantes, através da rota de fuga mais próxima, devendo ser orientados sobre a sinalização a ser seguida para abandono da edificação.

Para a remoção de pacientes deverá ser seguido o Plano de Remoção de Pacientes (APÊNDICE IV).

Após a evacuação parcial ou total de alguma das áreas, em caso de emergência, as pessoas deverão se deslocar para um dos três pontos de encontro do complexo, priorizando o caminho mais curto e/ou mais seguro:

PONTO 1: área externa, em frente ao Pronto Atendimento, na Rua Barão do Rio Branco.

PONTO 2: área externa, em frente a Central de Serviços, na Rua Marechal Floriano Peixoto.

PONTO 3: área externa, em frente ao Atendimento Hospitalar, na Rua Porto Alegre.

6.2.2 Exercícios simulados de evacuação de áreas

Deverão ser realizados exercícios simulados de evacuação das áreas visando à identificação de falhas e o treinamento dos profissionais. Logo após a realização dos simulados devem ser realizadas reuniões para avaliação dos problemas identificados, visando à implementação de ações corretivas e o aprimoramento deste Plano. Deverá haver relatórios dessas reuniões indicando a data e horário dos exercícios, os tempos gastos no abandono, no retorno e no atendimento aos primeiros socorros, se houve a participação do corpo de bombeiros e outras ajudas externas e o tempo de sua chegada, as falhas de execução do plano e dos equipamentos utilizados, devendo ser divulgado o resultado dos exercícios aos setores participantes.

(1) Importante: Por se tratar de estabelecimento de saúde com grande contingente de público externo, os exercícios de evacuação de áreas serão divulgados, sendo de conhecimento de todos a data, o horário e a conduta a ser adotada no abandono das instalações, para que não haja pânico. Os exercícios simulados internos em

pequena escala serão realizados trimestralmente e simulações anuais de abandono do prédio serão realizadas para cada turno, com registro de participação de todos os participantes.

(2) Importante: Os exercícios simulados (trimestrais e anuais) envolverão todos os níveis hierárquicos da instituição: Governança, Comitê de Gerenciamento de Crise, Grupo de Operação Equipe de Resposta a Emergência, Equipes de Apoio, Equipes de Retaguarda e Apoiadores. Os exercícios simulados servirão como treinamento de preparação de resposta em caso de uma emergência ou desastre, sendo possível desta forma avaliar o desempenho dos envolvidos, bem como identificar e corrigir falhas.

APÊNDICE II

6.3 Plano de resposta a catástrofes e atendimento a múltiplas vítimas

Entende-se catástrofe como a situação em que as necessidades de atendimento excedem os recursos materiais e humanos imediatamente disponíveis, havendo necessidade de medidas extraordinárias e coordenadas para se manter a qualidade básica ou mínima de atendimento.

Em ~~s~~ emergências ou desastres com múltiplas vítimas, apesar de haver um desequilíbrio entre os recursos disponíveis e as necessidades das vítimas, estas podem ser atendidas com eficiência, desde que se adote uma conduta operacional protocolada. Sabe-se que a capacidade de resposta de um hospital no atendimento às múltiplas vítimas é fator determinante na sobrevida de pacientes potencialmente recuperáveis, desde que tal resposta seja hierarquizada, sistematizada, protocolada e testada.

É o que se objetiva com a criação do Plano de Resposta a Catástrofes e Atendimento a Múltiplas Vítimas do Hospital Unimed Chapecó. A referência de entrada para as múltiplas vítimas é setor de Pronto atendimento.

6.3.1 Objetivo

Este plano estabelece ações hierarquizadas e sistematizadas com as equipes envolvidas para estarem aptas e prontas para responder quando ocorrer uma catástrofe com múltiplas vítimas.

6.3.2 Objetivos específicos

- Definir os critérios de triagem das vítimas de acordo com a classificação de risco de Manchester em consonância com o protocolo de atendimento do Pronto atendimento;
- Definir parcerias com órgãos responsáveis como: Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, PAM (Plano de Auxílio Mútuo), Defesa Civil, Aeroporto Serafim E. Bertaso, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Colégio Exponencial e Hospital Regional de Chapecó, de acordo com o tipo de catástrofe;
- Estabelecer leitos de retaguarda de acordo com a capacidade do hospital.

6.3.3 Definições

- **Emergência:** Evento que ocorre dentro da instituição, com risco de vida que requer uma ação imediata, mas geralmente é contida.

- **Desastre:** Evento que ocorre dentro ou fora da instituição e que resulta em um número de vítimas que excede a capacidade de atendimento do serviço (desequilíbrio entre os recursos e necessidades).
- **Catástrofe:** Implica em uma ocorrência maior que, além de um grande número de vítimas, envolve o meio ambiente com dificuldades de comunicação, transporte, abastecimento, infraestrutura e logística.
- **Acidentes com múltiplas vítimas:** São aqueles que apresentam desequilíbrio entre os recursos disponíveis e as necessidades, e que, apesar disso, podem ser atendidos com eficiência.
- **Gestão de riscos:** Identificação, análise e eliminação ou mitigação, a um nível aceitável, dos perigos, e os conseguintes riscos, que ameaçam a viabilidade de uma organização.
- **Crise:** momento de dificuldade ou de problemas que podem comprometer todo o andamento de um processo, um sistema ou uma organização.
- **Possíveis situações de desastre interno:** incêndio, vazamento de gases tóxicos, perda de gases medicinais, falta prolongada de água e eletricidade, entre outras.
- **Possíveis situações de desastre externo:** incêndio, acidentes aéreos, acidentes automotivos de grande impacto, acidentes químicos, crises sanitárias, entre outras.

6.3.4 Desenvolvimento

Este plano foi criado para atender às situações em que se identifique a necessidade de esforços extras do Hospital Unimed Chapecó, de forma ordenada e planejada, garantindo assim, a continuidade da segurança e qualidade no atendimento ao usuário, de forma que seja mantida a eficácia na Gestão de Riscos e Segurança do Paciente. Os principais eventos que podem causar uma situação de emergência são:

INTERNO	EXTERNO
Incêndios	Crise sanitária (surto, epidemia, pandemia)
Vazamento de GLP	Acidentes de trânsito em massa
Vazamento de oxigênio líquido	Incêndios
Falta de energia elétrica por 24 horas	Acidentes químicos (ex. vazamento de amônia)
Falta de água	Acidentes aéreos
Falta de insumos (ex. medicamentos, materiais, alimentos, rouparia)	Desabamento de estrutura
	Enchentes e desmoronamentos
	Violência urbana (ex. briga de torcida)

Em situações de desastres ou catástrofes, levando-se em consideração a estrutura física, a disponibilidade de recursos e a taxa de ocupação, o Hospital Unimed Chapecó possui capacidade de atendimento de até 30 vítimas. De acordo com o Método Start (Anexo 1), de triagem, poderão ser admitidas 05 vítimas vermelhas, 10 vítimas amarelas e 15 vítimas verdes, conforme capacidade de resposta do hospital. Em caso de crise sanitária, a capacidade de atendimento varia de acordo com o tipo de evento (surto, epidemia, pandemia), característica do agente, criticidade, via de transmissão, poder de contágio, considerando a capacidade máxima de 70 atendimentos simultâneos (máximo de 10 vítimas amarelas e 05 vermelhas) no Pronto atendimento.

6.3.5 Ativação do plano

O Médico chefe da equipe de resposta à emergência ou Médico plantonista P1 do Pronto atendimento, juntamente com o Diretor Hospitalar e/ou Diretor Técnico, acionará o plano e informará a ativação deste ao Comitê de gerenciamento de crise.

O Plano de resposta a catástrofes e atendimento a múltiplas vítimas pode ser acionado a partir de uma ligação telefônica de algum órgão (SAMU, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil), em caso de desastre externo, ou por colaborador da instituição, em caso de desastre interno, através de ligação ou acionamento do alarme de incêndio, ou ainda, após deliberação do Comitê de Gerenciamento de Crise Sanitária, em casos desta natureza.

Importante: Este plano será ativado quando o nível de criticidade for **2 ou 3**, de acordo com o número de vítimas.

6.3.6 Fases de atuação do plano

A. Preparação do hospital Unimed Chapecó

I. Escalas de profissionais

- Médicos do Hospital Unimed Chapecó (base de dados).
- Enfermeiros e Técnicos de enfermagem do Hospital Unimed Chapecó (base de dados).
- Psicólogas hospitalares e Assistentes sociais.
- Auxiliares de atendimento.
- Técnico de manutenção.
- Setores de apoio.

II. Espaços

- Local atendimento de vítimas: Pronto atendimento.
- Hospital de Base (se necessário): 1º subsolo (estacionamento) da estrutura vertical, para emergências ou desastres externos; Colégio Exponencial, para emergências e desastres internos.

B. Atuação propriamente dita

I. Centro da ação: Pronto atendimento

II. Prontidão do setor de Atendimento hospitalar: altas ao maior número de pacientes possível, incluindo transferências de vítimas para outros hospitais.

C. Recuperação por parte do Hospital Unimed Chapecó

I. Retorno à atividade normal

II. Reunião de balanço geral

III. Transferência de vítimas admitidas durante o evento

6.3.7 Acionamento e incentivo a colaboradores

O Complexo Unimed Chapecó incentiva seus colaboradores a se apresentar ao trabalho durante uma emergência ou desastre, recebendo total apoio enquanto estiverem prestando atendimento.

De acordo com a quantidade de pacientes hospitalizados e o número de vítimas, os colaboradores que estiverem em plantão somente poderão deixá-lo à medida que os demais profissionais chegarem para assumir o plantão. É de responsabilidade do supervisor/coordenador da área, quando necessário, contatar com os profissionais que não estejam de plantão para atender, o mais breve possível, o acionamento do CÓDIGO E (Emergência ou Desastre), sendo que serão chamados, conforme escala de profissionais elencados disponível no Pronto atendimento.

Os colaboradores chamados deverão registrar o ponto eletrônico, mesmo que não estejam em seu horário de trabalho, sendo que as horas extras geradas nesta ocasião permanecerão em banco de horas para compensação. Caso as mesmas não sejam compensadas, ao final do banco de horas estas serão pagas em folha de pagamento.

Os ramais da cooperativa ficarão à disposição dos colaboradores para avisarem seus familiares que não poderão deixar o plantão até um redimensionamento da escala de trabalho ou até os demais profissionais chegarem para assumir o plantão.

Será oferecido a todos os colaboradores alimentação de acordo com a orientação nutricional, quando na cooperativa, no seu restaurante próprio e quando em ambiente externo de acordo com a estrutura montada. Será solicitada a equipe de psicologia do hospital e do multiprofissional apoio psicológico aos profissionais envolvidos durante o atendimento às vítimas.

Importante: em caso de crise sanitária, a exemplo da pandemia por Covid-19, as horas extras foram pagas na competência de realização destas, não sendo direcionadas para banco de horas. Essa prática foi validada pelo sindicato da categoria e Ministério do Trabalho considerando os aspectos da crise sanitária.

6.3.8 Recursos humanos para o plano

- Médicos, Enfermeiros e Técnicos de enfermagem base de atuação: profissionais de plantão do Pronto atendimento;
- Médicos, Enfermeiros e Técnicos de enfermagem extras: clínicos e cirurgiões e profissionais da enfermagem, oriundos do próprio hospital, mediante inscrição prévia em base de dados, conforme listagem (Anexo 7), para eventual chamada em caso de emergência (imprescindível realização de cadastro de profissionais na base de dados do Hospital Unimed Chapecó);
- A 1ª fase de chamada de profissionais deverá ser do próprio hospital, solicitando que dos vários setores se desloquem para o Pronto atendimento, metade dos recursos que habitualmente estão nas unidades de internação;
- Na 2ª fase poderá ser acessada a base de dados para chamada de mais profissionais se necessário;

- A base de dados poderá ser acessada pelo Diretor Técnico, Coordenador Equipe de resposta à emergência, Diretor Hospitalar ou Gerente Hospitalar, ou quem estes delegarem, via telefone ou mensagens pré-formatadas e/ou construídas durante o evento de acordo com as suas características;
- Esta organização para chamada de profissionais deve prever que seja emitida uma lista dos profissionais contatados, após o envio das mensagens, para possibilitar a confirmação via telefone pelo setor de Telefonia, no sentido de validar o número de profissionais que receberam a mensagem e que efetivamente estão disponíveis e se deslocarão para o Hospital Unimed Chapecó.

Importante: em caso de crise sanitária, a exemplo da pandemia por Covid-19, ampliou-se o quadro funcional através de contratações emergenciais. O processo de recrutamento e seleção foi readequado, desde as divulgações até a sua execução total. Neste período foram ajustadas as etapas a fim de agilizar o processo, porém garantindo a análise dos candidatos sem causar impacto na assistência e nos serviços prestados.

6.3.8.1 Contingente interno (de plantão) ou externo (fora de plantão)

- Plantonistas do Hospital Unimed Chapecó, independente do dia de plantão: Cirurgia Geral, Ortopedia, Clínica Médica, Pediatria, Anestesia, Radiologia, Enfermagem, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Atendimento, de acordo com o nível de resposta ativado;
- Equipes de Retaguarda: Cirurgia Geral e do Trauma, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Neurocirurgia e Ortopedia;
- Equipes de Suporte: Psicólogos (quando necessário).

6.3.9 Identificação das vítimas

- Os registos passarão a ser realizados manualmente por uma questão de facilidade e prontidão;
- Os Auxiliares de atendimento (em número suficiente) apoiarão o médico da triagem, e registarão as vítimas por números sequenciais. Para este efeito, quatro cores (vermelho, amarelo, verde e preto), um prontuário em branco e adesivos numerados;
- Cada envelope será numerado de acordo com o nº dos adesivos que contém e utilizado um para cada vítima.

6.3.10 Contingenciamento de áreas

Para emergências e desastres nível 2 ou 3, antes da abertura de hospital de base, devem ser segregadas áreas utilizadas para outros fins e passarão a ser direcionadas para atendimento às vítimas/pacientes decorrentes do evento. Em situação de crise sanitária, a exemplo da pandemia por Covid-19, a Endoscopia, Centro cirúrgico, Hospital dia e Recuperação pós-anestésica, tiveram exames e procedimentos eletivos suspensos e foram utilizadas para atendimento a pacientes internados.

6.3.11 Abertura do hospital de base

- Será realizada a montagem do Hospital de Base a partir do recebimento do número vítimas que exceda a capacidade da atual estrutura física;
- O Comitê de Gerenciamento de Crise e o Médico Chefe Equipe de Resposta a Emergência devem decidir o local e identificar os elementos que, em caso de ativação, irão constituir o Hospital de Base;
- Deverão compor a equipe de comando do Hospital de Base o Diretor Técnico, Coordenador Equipe de Resposta à Emergência, Médico Chefe Equipe de Resposta a Emergência, Coordenadora do Pronto Atendimento e outros profissionais que possam ser considerados relevantes para a tomada de decisão em situação de catástrofe;
- Caso a emergência for interna e não havendo condições do atendimento às vítimas ser realizado no Pronto Atendimento, o Hospital de Base será instalado nas dependências do Colégio Exponencial, situado nas proximidades de Hospital Unimed Chapecó.

Importante: Este plano não necessita da abertura do Hospital de Base para ser ativado.

6.3.12 Desativação do plano

O responsável pela desativação é o Médico Chefe Equipe de Resposta à Emergência, que comunicará ao Comitê de Gerenciamento de Crise e a Telefonia. O plano será desativado quando todas as vítimas tiverem o atendimento finalizado, seja por óbito, internação, transferência ou alta. O Comitê de Gerenciamento de Crise comunicará à suas equipes e ao Conselho Gestor quanto à finalização dos atendimentos à catástrofe.

6.3.13 Preparação para atendimento a vítimas de acordo com o nível de resposta

Nível de resposta para crise sanitária: 70 atendimentos simultâneos (máximo de 10 vítimas amarelas e 05 vermelhas).

Nível 2 de resposta: até 3 vítimas vermelhas e 4 vítimas amarelas;

Nível 3 de resposta: número de vítimas ultrapassa o nível 2 até o limite de 5 vítimas vermelhas e 10 vítimas amarelas.

Efetuar registro em formulário (Anexo 2).

Médico chefe reúne a equipe na recepção do P.A para delegar ações, após definir nível de resposta.

EMERGÊNCIA / DESASTRE COM VÍTIMAS

PRONTO ATENDIMENTO
Recebe informação da ocorrência de emergência / desastre (interno ou externo) com vítimas.

Médico Chefe Equipe de Resposta: bloqueia troca de turno da equipe médica e dos colaboradores do Pronto atendimento.

Líder do Comitê, Diretor Hospitalar/Diretor Técnico e Médico Chefe Equipe de Resposta à Emergência: comunicam-se e analisam se há necessidade de acionar o fluxo de resposta à catástrofe e atendimento à múltiplas vítimas.

No período entre 00:00 e 06:00, o Aux. de atendimento (guichê 01) do P.A, informa, via telefone, setores críticos (C.C, UTI's, Laboratório, Unimagem) e *Comitê de Gerenciamento de Crise.
*fazer uma tentativa e em caso de dificuldade de contato, seguir o próximo da lista e assim sucessivamente, estabelecendo a comunicação com a primeira pessoa que conseguir o contato, a qual informará os demais membros através de mensagem no whatsapp.

Em caso de médio ou alto risco, acionar, através da menção do **CODIGO E**, o **Grupo de operações**** e o membro do Comitê informado anteriormente.
****Realizar o contato da mesma forma que o Comitê.**

Médico Chefe da Equipe de Resposta à Emergência possui autonomia para acionar o fluxo.

Há necessidade de acionar o fluxo?

SIM

MÉD. CHEFE EQUIPE DE RESPOSTA
Informa a decisão à Coord. do P.A e/ou Equipe de Resposta.

PRONTO ATENDIMENTO
Comunica a Telefonia quanto ao acionamento do fluxo, através da menção do **CÓDIGO E e informa o nível de resposta**; Comunica à **empresa de segurança patrimonial terceirizada** através do acionamento do botão de emergência.

Níveis 2 e 3: Grupo de Operação e Comitê são acionados.

TELEFONIA
Aciona, via telefone, Grupo de Operação e Comitê de Gerenciamento de Crise.

GRUPO DE OPERAÇÃO
Formado pelo Gerente Hospitalar e Corporativo, Técnico de Manutenção e pelos profissionais do Pronto Atendimento: Médico Chefe de Equipe, Enfermeiro(a) e Auxiliar Administrativo.

Se reúne no P.A e dá início ao fluxo.

COMITÊ DE GEREN. DE CRISE
Formado pelos Diretores Hospitalar, Técnico, Clinico, Marketing e Corporativo; Coordenações de Atendimento, Enfermagem, Pronto Atendimento, Gerenciamento de Leitos e Manutenção; Medicina Ocupacional.

Se deslocam para o Hospital e cada um assume seu papel, conforme descrição no Manual.

NÃO

PRONTO ATENDIMENTO
Realiza o atendimento pelo fluxo normal da emergência; comunica a Telefonia e informa o nível de resposta; **aciona a empresa de segurança patrimonial terceirizada** através do acionamento do botão de emergência.

Nível 1 de resposta: até 2 vítimas vermelhas e 2 vítimas amarelas. Efetuar registro em formulário (Anexo 2).

TELEFONIA
Informa, via telefone, setores críticos (C.C, UTI's, Laboratório, Unimagem) e Comitê de Gerenciamento de Crise para ciência.

Nível 1: Comitê é informado para ciência.

POSTO DE COMANDO (sala da diretoria)

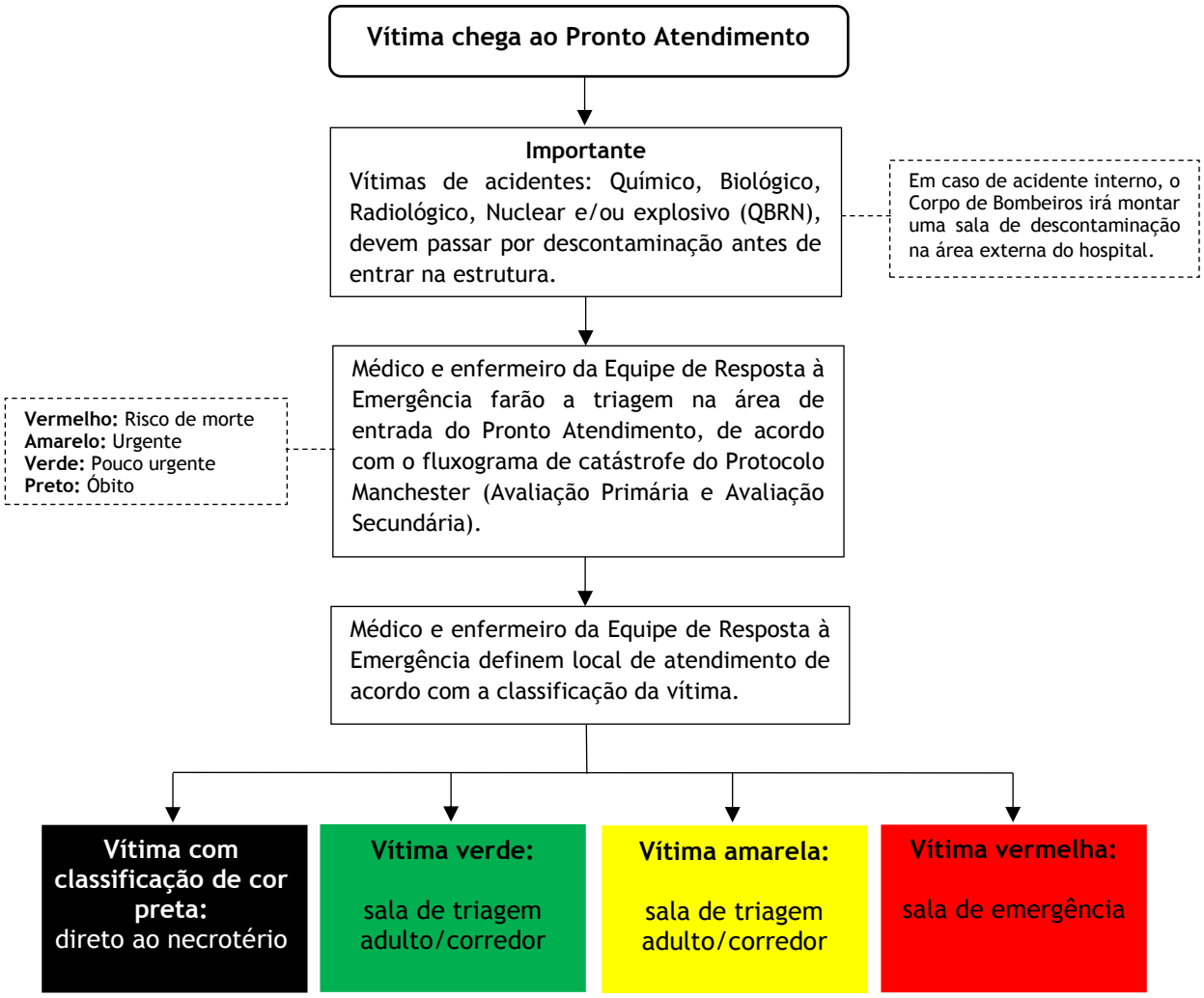
Comandante da Crise (Líder do Comitê de Gerenciamento da Crise)

Equipe de Comando (Presidente, Diretores: Hospitalar, Técnico, Clínico, Marketing, Corporativo,

Chefes de Operação (Gerentes e Coordenadores/Representantes da Enfermagem, Pronto atendimento, Financeiro, Gestão de Suprimentos, Farmácia, Manutenção e Engenharia clínica)

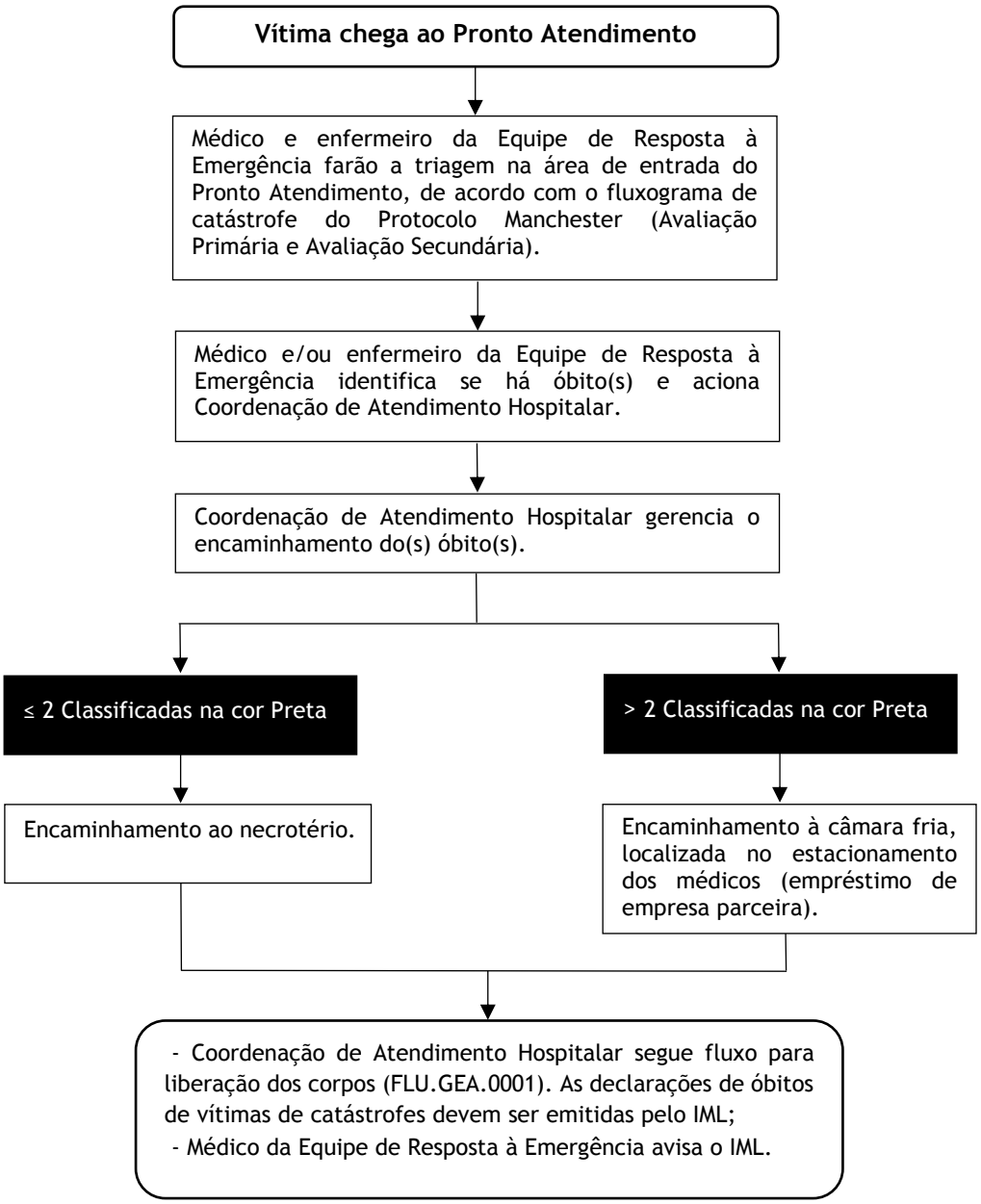
Em casos de emergência/desastre interno, e não havendo condições de atendimento no P.A o Colégio Exponencial cederá espaço para atendimento a vítimas e pacientes. Ligar para o colégio: (49)3323-1032, de 2ª a 6ª, das 07h às 22h; Nos demais dias e horários:
- Élio Maldaner: (49)331186684/999338080;
- Digitek 24h: (49)33242152/991146600
- Arsílio Piva: (49)33224609/998032777

6.3.14 Avaliação das vítimas - protocolo Manchester



Observações:
- Familiares das vítimas serão conduzidos para a recepção do Atendimento hospitalar;
- Órgãos de imprensa aguardarão no auditório 1 ou na impossibilidade deste, na recepção adulta do Pronto atendimento;
- Voluntários deverão se reunir na recepção do Laboratório;
- Sala de Recuperação do Centro Cirúrgico pode ser transformada em Unidade de Terapia Intensiva;
- Pacientes Azuis e Verdes do Pronto atendimento serão atendidos por profissionais do Unimed Personal (médico, enfermeira e técnica de enfermagem).

6.3.15 Encaminhamento de óbitos



Observações:
- Familiares das vítimas serão conduzidos ao auditório 2 para informações e acompanhamento;
- Órgãos de imprensa aguardarão no auditório 1 ou na impossibilidade deste, na recepção adulta do Pronto atendimento.

6.3.16 Atendimento a múltiplas vítimas no Pronto atendimento - nível de resposta 2 e 3

Nível 1 - O fluxo de atendimento no P.A fica inalterado.

4.8 Organograma Hierárquico

↓

6. Fluxo de Preparação para Atendimento a Emergências

↓

Acionar Equipe de Resposta e alteração de fluxo de atendimento

Atendimento as Vítimas de Emergências ou Desastres

ESTRUTURA FÍSICA

- **Recepção adulta:** será a recepção para familiares das vítimas;
- **Sala de procedimento:** será a recepção identificação das vitimas
- **Sala de sutura/curativo:** assistência psicológica familiares vitimas
- **Sala de triagem adulto/corredor:** triagem vítimas amarelas e verdes
- **Sala de emergência:** atendimento a vítimas vermelhas com encaminhamentos UTI/CC, amarelas primeira avaliação após observação

Cruza o fluxo

- **Sala de observação:** estabilizará as vítimas e encaminhará para o Centro Cirúrgico/UI;
- **Elevador de social:** dará acesso as vítimas ao hospital/imagem.

ESTRUTURA HUMANA

- **Recepção:** 2 colaboradores P.A (1 acolhimento do familiar, 1 na identificação das vitimas)
- **Triagem:** 1 Enfº. PA
- **Sala de emergência:** 1 Enfº. SOS + 1 colaborador do PA;
  1 Enfº PA + 1 colaborador PA;
  1 Enfº Unid. Inter. para transporte;
- **Observação:** 1 Enfº da Unidade de Internação
- **Tec. de enfermagem:** 2 colaboradores PA + 2 colaboradores das unidades, de preferência que já trabalharam no PA
- **Médicos:** 2 plantonistas do PA
  1 hospitalista /diarista (transporte)
  1 plantonista de casa para observação

OBS: nesta estrutura terá 2 colaboradores do PA na recepção, 4 Enfermeiros PA /UI e 4 Médicos PA/UI /casa.

ESTRUTURA FISICA

- **Recepção adulto:** mantem estrutura
- **Triagem adulta:** mantem estrutura
- **Sala de emergência:** mantém estrutura
- **Farmácia:** mantem estrutura
- Sala de observação: mantem estrutura
- Sala de procedimento: recepção para identificação das vítimas.
- Sala de sutura: apoio psicológico, retirar mesa de procedimento e pegar longarinas na recepção pediátrica e cadeiras branca da observação adulto pegar cadeiras da observacão.

Atendimento aos Pacientes Unimed

ESTRUTURA FÍSICA

- **Recepção pediátrica:** recepção mista
- **Sala de triagem infantil:** triagem mista

Cruza fluxo

- **Consultório clínico 1:** sala de emergência mista
- **Consultório clinico 2:** sala de emergência mista
- **Consultório pediátrico 5**: sala de sutura
- **Sala de medicação:** receberá todos os pacientes, se necessário alocar macas nesta sala e as cadeiras na inalação

Cruza fluxo

- **Farmácia:** utilizar a satélite
- **Elevador de serviço:** fará o acesso para os clientes ao hospital e imagem.

ESTRUTURA HUMANA

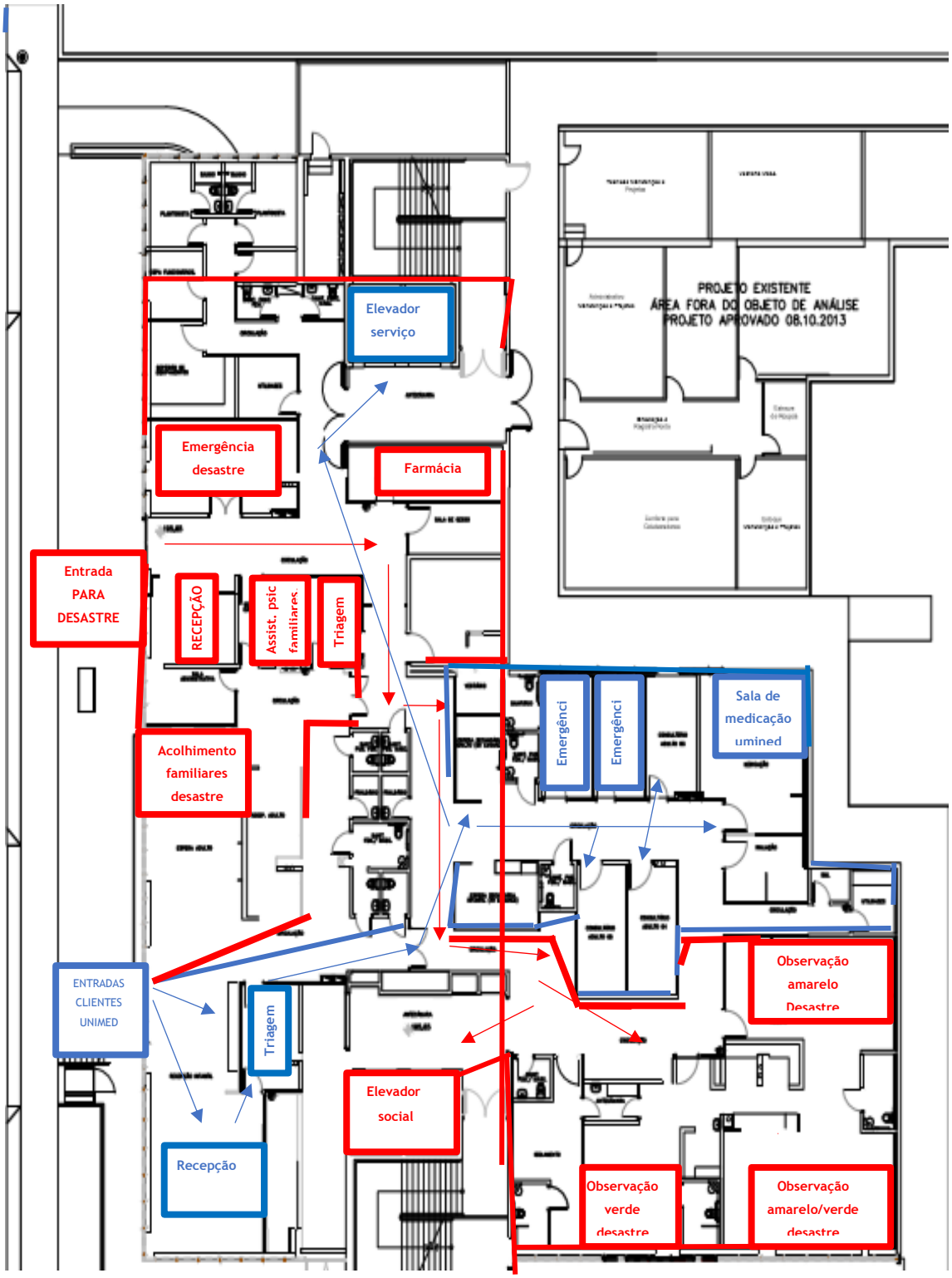
- **Recepção:** 1 colaborador PA + 1 colaborador Atendimento Hospitalar
- **Triagem:** 1 Enfª. Assistencial PA
- **Sala de emergência/observação:** 1 Enfº. UI + 1 Téc. enf. do PA;
- **Tec. de enfermagem:** 2 colaboradores PA + 2 colaboradores das unidades
- **Médicos:** 1 clinico e 2 pediátrico

OBS: nesta estrutura terá 2 colaboradores na recepção PA/GA, 5 Téc. enfermagem, 2 Enfermeiros e 3 Médicos

ESTRUTURA FÍSICA

- **Recepção infantil:** mantem estrutura
- **Triagem:** mantem estrutura
- **Consultório 1 e 2:** vira sala de emergência pegar monitores da sala de sutura e procedimento, carro de emergência 2, 2 macas de transporte, torpedo de O2 cilindro grande da sala de equipamentos.
- **Consultório 5:** será sala de sutura, cautério, mesa auxiliar, matérias, kits procedimentos...
- **Macas:** emprestar da imagem (recuperações).

6.3.17 Reestruturação para atendimento a múltiplas vítimas

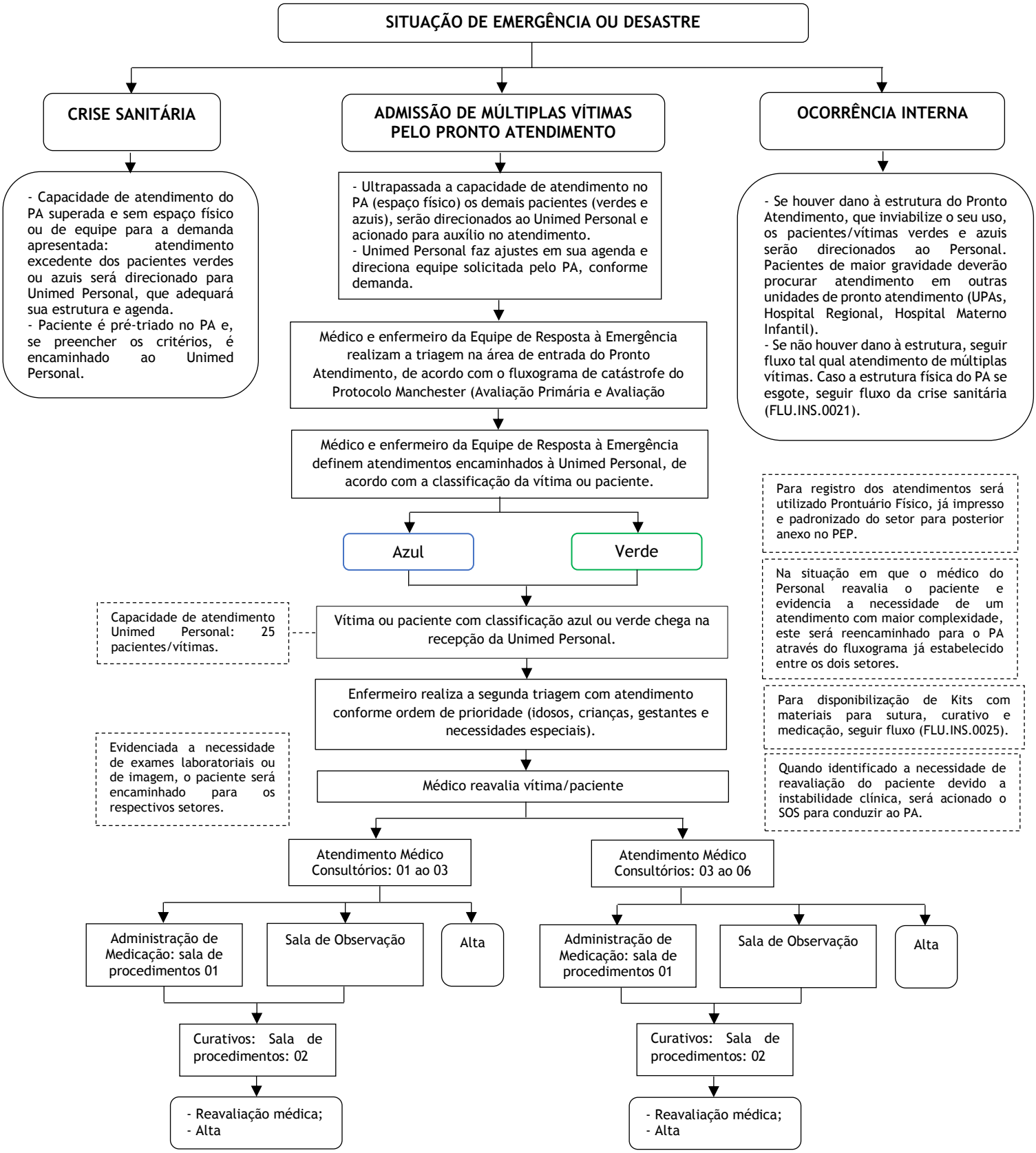


- fluxo de desastre ou emergência
- fluxo do paciente Unimed

(1) Importante: A equipe do SESMT (médico do trabalho e técnico de enfermagem e/ou enfermeiro) ficará de prontidão no Pronto atendimento para atender acidentes de trabalho que poderão ocorrer durante o atendimento à emergência ou desastre ou na Saúde ocupacional, dependendo da disponibilidade de espaço e da proporção do ocorrido.

(2) Importante: Acidentes de trabalho com potencial de risco de morte deverão ser atendidos pelo Pronto atendimento e posteriormente, encaminhar colaborador para avaliação médica na Saúde ocupacional, de acordo com protocolos instituídos.

6.3.18 Encaminhamento de pacientes com classificação azul e/ou verde do Pronto atendimento para a Unimed Personal



6.3.19 Resposta a desastres internos

1º Por em prática a evacuação da edificação;

2º Contato com o setor Atendimento hospitalar - Gestão de acesso do Hospital Unimed Chapecó para transferência interna de pacientes;

3º Contato com outros hospitais para transferência de vítimas;

4º Estabelecer no estacionamento do Pronto atendimento área para Hospital de Base ou na impossibilidade deste, no ginásio do Colégio Exponencial;

5º Estabelecer serviços que poderão ser interrompidos;

6º Estabelecer níveis de resposta.

7 RESPOSTA A DESASTRES EXTERNOS

1º A triagem será executada de acordo com o Sistema Manchester de Classificação de Risco para atendimentos às múltiplas vítimas (avaliação primária e secundária);

2º Alocar no Pronto atendimento nas áreas verde, amarela e vermelha (de acordo com a gravidade do caso definida via Manchester);

3º Determinar o número máximo de atendimentos;

4º Estabelecer setores do Hospital Unimed Chapecó que poderão receber outras vitimas;

5º Determinar área no estacionamento do Pronto atendimento para abertura do Hospital de Base, se necessário.

Importante: Caso o transporte de vítimas para outros hospitais seja realizado por helicóptero, estas serão transportadas até o estádio Índio Condá, onde o SAER dará sequência ao translado.

7.1.1 Relatório pós a desativação do plano de resposta a catástrofes e atendimento a múltiplas vítimas

Os dados serão reunidos e avaliados pelo Comitê de Gerenciamento de Crise e Saúde Ocupacional, para identificar falhas ou oportunidades para melhoria na execução deste plano. Se uma oportunidade para melhorar o atendimento e/ou serviço é identificada, um plano de ação corretiva será implementado. O Comitê de Gerenciamento de Crise, juntamente com a Saúde ocupacional, deverá avaliar os dados para a eficácia após o plano de ações corretivas e de acompanhamento. Relatórios relativos à avaliação da ação corretiva serão documentados em ata.

7.1.2 Avaliação do plano de resposta a catástrofes e atendimento a múltiplas vítimas

O plano deve ser avaliado continuamente para garantir que atinja as metas da instituição, em busca de segurança e da melhoria contínua.

No mínimo, o Plano deve ser revisto anualmente. A avaliação vai identificar os itens que precisam ser instituídos, revistos ou eliminados.

8 APÊNDICE III

8.1 Plano de contingência para situações emergenciais internas

O Plano consiste em um planejamento de alternativas para contornar da forma mais rápida possível situações de emergência que possam ocorrer no Complexo Unimed Chapecó.

Este Plano visa prover a organização de procedimentos e responsabilidades, com objetivos de nortear as ações durante o evento.

8.1.1 Principais tipos de emergências internas

Foram relacionados os principais eventos que poderão causar uma situação de emergência para os colaboradores, pacientes, acompanhantes, terceiros e clientes do Complexo Unimed Chapecó.

Para cada situação que possa ocorrer os Coordenadores médicos do Pronto atendimento ou médico plantonista P1, Coordenador de enfermagem do Pronto atendimento ou Enfermeiro supervisor, Coordenador ou Chefe da Brigada de incêndio e Coordenador de Manutenção e Engenharia clínica ou Técnico de manutenção, decidem se haverá o abandono total da edificação.

Os principais eventos são:

1- Incêndios;

2 - Vazamento de GLP;

3 - Vazamento de oxigênio líquido;

4 - Falta de insumos (medicamentos, materiais, alimentos, rouparias);

5 - Falta de água;

6 – Falta de energia elétrica.

8.1.2 Identificação e avaliação da emergência

Na constatação de fumaça, cheiro de fumaça ou cheiro de gás, qualquer pessoa poderá acionar a botoeira de alarme de incêndio ou ligar no ramal de emergência (ramal 2000).

Na identificação de princípio de incêndio, qualquer brigadista treinado deverá utilizar imediatamente o extintor adequado ao tipo de incêndio.

O setor de Manutenção e Engenharia clínica e/ou SESMT deverá confirmar a emergência e avaliar a necessidade de acionar o Plano.

8.1.3 Acionamento dos grupos

Para os casos de incêndio, vazamento de GLP e vazamento de oxigênio líquido o acionamento será realizado através do ramal 2000 exclusivo ou de rádios comunicadores. As ligações para este ramal serão direcionadas para o setor de Pronto atendimento. Os rádios estão distribuídos na Diretoria, Telefonia, Pronto atendimento, Saúde ocupacional, Manutenção e Engenharia clínica. Após tomar conhecimento da informação, o setor de Manutenção e Engenharia clínica e o SESMT se deslocarão para o local da emergência.

Para os casos de falta de água e falta de energia, será acionado a Manutenção e Engenharia clínica o qual tomará as devidas providências. O local de controle da emergência para centralizar a coordenação da

resposta da organização, será o setor de Manutenção e Engenharia clínica que acionará as demais áreas envolvidas.

Para os casos de falta de insumos (medicamentos, materiais, alimentos,...), os setores responsáveis deverão entrar em contato com os respectivos fornecedores e solicitar a reposição emergencial dos itens faltantes.

Importante: A listagem de fornecedores está disponível neste Manual (Anexo 9).

8.1.4 Incêndio – Brigada de incêndio

A partir da constatação da emergência, será acionada a Brigada de Incêndio através do disparo da sirene da Brigada. Os brigadistas assumirão suas posições dentro do plano de emergência e iniciarão o combate.

8.1.4.1 Conduta para princípio de incêndio

1. Acionar o Corpo de Bombeiros.
2. Acionar a Telefonia e avisar o ocorrido, informando que há um princípio de incêndio.
3. Avaliar rapidamente o método de extinção a ser adotado (isolamento, abafamento, resfriamento) e a necessidade de desligamento de equipamentos elétricos.
4. Utilizar os extintores adequados ABC, PQS ou CO2) conforme o tipo de classe de incêndio (A, B ou C) até a extinção das chamas.
5. Avaliar a necessidade de reforço da equipe e solicitar mais brigadistas.

8.1.4.2 Para incêndio generalizado:

1. Acionar o Corpo de Bombeiros;
2. Acionar o Telefonia e avisar o ocorrido, informando um incêndio totalmente desenvolvido;
3. Acionar todos os brigadistas presentes;
4. Dar ordem de evacuação do pavimento sinistrado e dos pavimentos superiores a este e avaliar a necessidade de evacuação dos demais pavimentos, considerando a ordem de prioridade;
5. Adotar mecanismos de bloqueio da propagação da fumaça, fechando todas as portas sem trancá-las;
6. Em condições favoráveis, compor as linhas de hidrantes;
7. Avaliar corte da energia e do fornecimento dos gases, juntamente com os bombeiros;
8. Em condições favoráveis e utilizando os equipamentos de proteção individual, sob o comando dos bombeiros, iniciar o combate ao incêndio por hidrantes e o resfriamento das áreas vizinhas;
9. Favorecer e auxiliar as ações do Corpo de Bombeiros.

8.1.5 Vazamento de GLP – setor de manutenção

Em caso de vazamento, a pessoa habilitada para executar as ações deve ter conhecimento e ser treinada antecipadamente.

8.1.5.1 Vazamento sem fogo

- Rompimento de PIG-TAIL

1º passo: A pessoa habilitada, se possível, deverá fechar a válvula de consumo do tanque interligado ao PIG-TAIL na Central de Gás;

2º passo: Avaliar a necessidade de acionar o Corpo de Bombeiros;

3º passo: Isolar a área da Central de Gás utilizando cones, fitas, cordas ou qualquer outro material com esta função;

4º passo: Não acionar interruptores ou ligar qualquer equipamento elétrico ou que produzam faíscas. Manter aparelhos celulares desligados;

5º passo: Impedir o acesso de veículos na área;

6º passo: Evitar aproximação de curiosos;

7º passo: Se possível, mantendo-se à distância, molhar com água a Central de Gás, usando mangueiras comuns ou através de nebulização com equipamentos específicos;

8º passo: Simultaneamente às operações descritas, a assistência técnica deverá ser chamada de imediato.

- Vazamentos nas Conexões da Instalação

1º passo: A pessoa designada, se possível, deverá fechar a válvula de consumo na Central de Gás;

2º passo: Avaliar a necessidade de acionar o Corpo de Bombeiros;

3º passo: Isolar a área da central utilizando cones, fitas, cordas ou qualquer outro material com esta função;

4º passo: Não acionar interruptores ou ligar qualquer equipamento elétrico ou que produza faíscas;

5º passo: Envolver o local do vazamento com pano embebido em água;

6º passo: Impedir o acesso de veículos;

7º passo: Evitar a aproximação de curiosos;

8º passo: Se possível, mantendo-se à distância, molhar com água a Central de Gás, usando mangueiras comuns ou através de nebulização com equipamentos específicos;

9º passo: Simultaneamente às operações descritas, a assistência técnica deverá ser chamada de imediato.

8.1.6 Vazamento de oxigênio líquido – setor de Manutenção e Engenharia clínica

Em caso de vazamento, a pessoa habilitada para executar as ações deve ter conhecimento e ser treinada antecipadamente, conforme o procedimento a seguir:

- O local deverá ser imediatamente aberto para ventilação;
- Para contenção e eliminação do agente no meio, devem-se utilizar roupas de algodão, por ser um material de menor capacidade de queima.

8.1.6.1 Vazamento na rede de oxigênio

- Localizar o ponto e a válvula que abastece este circuito e fechar até que seja feita a manutenção deste ponto da rede.
- Solicitar junto a enfermagem a transferência dos pacientes para outro setor onde o vazamento não tenha afetado.

8.1.6.2 Falta de oxigênio no tanque

- O alarme irá soar e por diferencial de pressão inferior a 3,5 bar.
- A bateria reserva irá abastecer a rede de oxigênio (tempo máximo de cada bateria reserva 4 horas).
- Um comunicador via satélite repassa todas as informações do tanque para a central de monitoramentos da empresa fornecedora Airliquid.

Importante: Na sala junto ao tanque de oxigênio existem 2 baterias reserva.

8.1.7 Falta de medicamentos – Farmácia

1. Verificar disponibilidade do medicamento em farmácia externa e solicitar compra.
2. Se indisponibilidade em farmácia externa, solicitar ao setor de compras uma compra emergencial do medicamento em distribuidora, com entrega o mais breve possível (24h).
3. Solicitar empréstimo a uma unidade hospitalar para que não haja desabastecimento até completa restituição do estoque (lista de fornecedores no Anexo 9).

8.1.7.1 Falta água destilada - estéril

A água destilada é um insumo essencial para a Farmácia e demais áreas do hospital (nutrição, enfermagem, etc.). Na Farmácia estão disponíveis apresentações de 10ml, 20ml, 100ml e 1000ml e em decorrência do baixo custo e alto consumo, o item é mantido em grande estoque. Na falta de uma das apresentações, disponibiliza-se para uso a de volume próximo e/ou é avaliada a possibilidade de uso de solução fisiológica, a qual é facilmente encontrada nas distribuidoras de medicamentos, algumas delas com entrega em 24h.

8.1.8 Falta de materiais – Laboratório

Para falta de materiais/produtos resultante de situação de emergência ou desastre, seguir plano de contingência PLC.LAB.0001.

- **Emergenciais**

1. Solicitar ao setor de compras uma compra emergencial do produto, com entrega o mais breve possível;
2.Verificar com fornecedor responsável pelo produto disponibilidade de entrega ou empréstimo de outro local;

3. Encaminhar amostras urgentes para o Laboratório Brasil;
4. Encaminhar amostras de rotina para DB Diagnósticos, Instituto Hermes Pardini.

- **Faltas de mercado**

1. Analisar possibilidade de aumento do estoque para os produtos faltantes durante o período anunciado;
2. Verificar com fornecedor responsável pelo produto possibilidade de empréstimo de outro local;
3. Solicitar ao setor de compras cotação de outras opções de mercado para substituição do produto;
4. Comunicar aos colaboradores e setores envolvidos quanto as faltas.

- **Aumento de demanda**

1. Solicitar ao setor de compras uma compra emergencial do produto, com entrega o mais breve possível;
2. Realizar novo acompanhamento na demanda, revendo pedidos e entregas até normalização.

- **Produtos com problema**

1. Encaminhar e-mail e realizar contato telefônico com setor de compras explicando sobre o problema e repassando as informações do produto (código, lote, validade). Para os finais de semana deixar registrado em caderno de plantão/e-mail e informar para o analista operacional ou bioquímico/Biomédico responsável do próximo turno;
2. Verificar com fornecedor responsável pelo produto disponibilidade de entrega ou empréstimo de outro local em casos de urgência;
3. Realizar acompanhamento para troca do produto.

- Falta de água (> 24 horas): verificar para comprar galões de água deionizada para os equipamentos.
- Falta de energia elétrica (> 24 horas): acionar setor de manutenção para verificar o ocorrido.
- Problemas com equipamentos**:** acionar técnico responsável pelo equipamento para vir o mais breve possível.

Importante: Na ocorrência de problemas com equipamentos, seguir plano de contingência PLC.LAB.0002

8.1.9 Falta de materiais –Gestão de suprimentos

- Equipamento de proteção individual (EPI): os EPI's básicos de uso da enfermagem (respirador, luvas de procedimento estéreis e não estéreis, luvas de vinil, óculos de proteção) são fornecidos por empresas locais, facilitando a entrega em caso de emergência. Nessas situações, realizar a retirada no local, via moto boy ou carro da Unimed, estimando o tempo de 1 hora para reabastecer o estoque do hospital.
- Gases medicinais: fornecedor local atende em 2 horas, de acordo com sua disponibilidade. Em situação de emergência, realizar a retirada no local, via carro da Unimed, reduzindo o tempo em 1 hora para normalizar o fornecimento.

8.1.10 Falta de rouparia – Lavanderia

1. Verificar disponibilidade do enxoval limpo conforme demanda de atendimentos.
2. Comunicar e acompanhar os setores assistenciais para utilização consciente do enxoval, evitando desperdícios de roupas limpas, bem como, mau uso do mesmo.
3. Se indisponibilidade de equipamentos para processamento do enxoval, entrar em contato lavanderias hospitalares externas para encaminhamento das roupas sujas para lavagem/secagem.
4. Se quantidade insuficiente de enxoval para atender a demanda, solicitar empréstimo a uma unidade hospitalar para que não haja desabastecimento até completa restituição da rouparia.

(1) Importante: Para unidades de internação há enxoval disponível para atender a demanda com 04 jogos por leito.

(2) Importante: A rouparia não pode ser encaminhada para lavagem em lavanderias comerciais convencionais, devido a contaminação existente.

8.1.11 Falta de alimentação – Serviço de nutrição e dietética

- Distribuição de ticket refeições para os colaboradores realizarem suas refeições em restaurantes comerciais próximos ao hospital e aprovados dentro dos requisitos estabelecidos (higiene, cardápios, custos..).
- Para os turnos da noite, serão distribuídas refeições transportadas e servidos no auditório ou nas copas dos setores, quando da inviabilidade do restaurante.
- Para as refeições menores, como lanches, serão produzidos por fornecedor externo e servidos no auditório nas copas dos setores, quando da inviabilidade do restaurante.
- Para pacientes e acompanhantes as refeições principais (almoço e jantar) serão distribuídas por empresa terceirizada especializada em refeições transportadas e previamente qualificada para esta demanda; a partir de um cardápio pré-estabelecido e orientações de preparo específicas para atender às necessidades da dietoterapia. As refeições menores (desjejum, lanches e ceia) serão preparados nas copas, optando por preparações prontas e que não exijam preparo em forno/fogão.

8.1.12 Falta de água – Manutenção e Engenharia clínica

- Verificar o funcionamento dos poços.
- Em caso de falha nos dois poços em funcionamento, ativar o terceiro poço (reserva em caso de problemas). Na falta de energia elétrica, há o grupo gerador que supre a necessidade.
- Caso haja falha na vazão de água dos poços, ligar a entrada de água fornecida pela concessionária.
- Na falta de água fornecida pela concessionária, entrar em contato com a empresa concessionária CASAN e solicitar informações quanto ao restabelecimento do fornecimento de água.

8.1.12.1 Vazamento de água

1. Para qualquer tipo de vazamento de água ligar para o setor de Manutenção.

2. O setor de Manutenção deverá se dirigir para o local e avaliar o problema.
3. O setor de Manutenção realizará o conserto do vazamento.
4. O setor de Manutenção realizará relatório sobre o vazamento e envia para o SESMT com a tomada de providências juntamente com as medidas de melhorias.
5. Caso o vazamento atinja áreas onde exista trânsito de clientes e colaboradores o setor de Manutenção deverá informar ao SESMT para que este realize o isolamento das áreas para prevenir acidentes.

8.1.13 Falta de energia elétrica 24h – Manutenção e Engenharia clínica

- Acionar o setor de Manutenção e Engenharia clínica.
- Iniciar plano de contingência: dois geradores, com capacidade de 550 KVa cada, assumem as cargas, dentro de 10 a 15 segundos.
- Se houver falha mecânica de algum gerador, o setor de Manutenção deverá entrar em contato com a assistência técnica da Profissional Engenharia e informar o defeito e receberá instruções da assistência remota.
- Em caso de falha elétrica dos quadros de transferência e chave reversora dos grupos geradores, a Manutenção realizará os procedimentos para o conserto dos quadros.

(1) Importante: Para as áreas críticas - Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, UTI - há Nobreak para atender com autonomia de 40 minutos.

(2) Importante: Os geradores estão instalados na Central de Serviços e as chaves de acesso encontram-se na Manutenção e Engenharia clínica e na Telefonia.

APÊNDICE IV

8.2 Plano para remoção de pacientes

8.2.1 Objetivo

Estabelecer diretrizes para a preparação e remoção dos pacientes das instalações, em caso de incêndios e em emergências não relacionadas a incêndios, descrevendo ações e procedimentos a serem implementados e mantidos pelos setores responsáveis, de forma a garantir maior agilidade e segurança na evacuação parcial ou total das edificações.

8.2.2 Responsabilidades

Comitê de abandono

- Decidem, em conjunto, pela evacuação total e comunicam a ordem para abandono da edificação.

Brigadistas

- Atuam no combate ou controle do sinistro, oferecendo condições para a evacuação do local;
- Prestam apoio às equipes de remoção de pacientes.

Médicos

- Realizar análise clínica dos pacientes e a triagem e designar qual paciente será removido por ordem de complexidade e promover as intervenções necessárias a sua remoção;
- Solicitar ao enfermeiro ou técnico de enfermagem parecer quanto ao quadro clínico de cada paciente naquele momento.

Enfermeiros

- Realizar a triagem para remoção de pacientes nos setores onde não tem médico fixo e nos setores onde há médicos deverá auxiliar na triagem;
- Coordenar e posicionar os técnicos de enfermagem para preparar pacientes para abandono.

Médicos/Enfermeiros

- Em caso de evacuação das instalações, realizar análise clínica dos pacientes em cuidados permanentes e promover as intervenções necessárias liberando imediatamente todos os pacientes em condições clínicas de deslocamento, juntamente com seus acompanhantes;
- Adotar ordem de evacuação inversamente proporcional à gravidade do caso, preferencialmente através do uso de cadeiras de rodas e, quando indispensável, macas.
- Acompanhar os pacientes dependentes, sob seus cuidados, durante sua remoção e não retornar à edificação até que autorizado.

Técnicos de enfermagem

- Preparar o paciente para remoção;
- Orientar e auxiliar a equipe de apoio para transporte do paciente durante sua remoção.

Coordenadores e Enfermeiros supervisores de unidades

- Promover treinamento dos profissionais do setor quanto à execução do Plano de Remoção de Pacientes, considerando as particularidades inerentes a cada setor.
- Garantir acolhimento dos pacientes graves advindos dos setores situados no pavimento sinistrado e dos pavimentos superiores a esse, que não possam ser retirados da edificação.
- Dimensionar e promover a solicitação dos recursos necessários ao suporte à vida e à locomoção de todos os pacientes (macas e cadeiras de rodas) em caso de evacuação das instalações.

Equipe de apoio para remoção de pacientes

- Deslocar-se e assumir posição no setor e leito designado e dar suporte a equipe assistencial para remover pacientes.

Cabeça de fila

- Orientar e conduzir os ocupantes até o ponto de encontro mais próximo ou mais seguro.

Fim de fila

- Fazer a varredura no setor, sinalizar portas e comunicar ao líder do andar/setor que o local já está evacuado.

Chefe de setor

- Apoiar a evacuação do setor, auxiliando o cabeça de fila e o fim de fila nas ações.

Manutenção e Engenharia Clínica

- Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de suporte à vida.
- Prover e manter em plena condição de uso os geradores e elevadores e infraestrutura predial de prevenção, detecção e combate a incêndio.

8.2.3 Evacuação das instalações

Diante da necessidade de evacuação parcial ou total das instalações, o Coordenador ou Chefe da Brigada comunicará o Pronto atendimento, para que o Médico Chefe Equipe de Resposta a Emergência ou o Médico Plantonista P1 assuma a liderança da operação de atendimento aos pacientes resgatados nos setores.

Importante: Antes do transporte dos pacientes, devem ser eliminados os riscos de acidentes relacionados à projeção e contato com material biológico.

8.2.4 Remoção de pacientes

Em situações que seja necessário a remoção de pacientes, os médicos plantonistas deverão assumir a liderança da operação, sempre observando as condutas adequadas.

8.2.4.1 Conduta para remoção de pacientes

a) Pacientes internados, em observação ou aguardando internação no Pronto Atendimento e em setores de diagnóstico:

- Enfermeiro(s) da(s) Unidade(s) de Internação após tomar conhecimento do incêndio ou emergência, comunica ao restante da equipe a ocorrência e a possível necessidade de abandono da área.

- Manter em seu poder a planilha de classificação de risco dos pacientes nas unidades de internação. A planilha deverá ser atualizada pela enfermagem sempre que houver alta ou internação na(s) respectiva(s) unidades.
- Aguardar a ordem de evacuação.
- A equipe de enfermagem, mediante autorização médica irá liberar os pacientes do soro e/ou outros equipamentos, considerando a ordem de evacuação inversamente proporcional à gravidade do caso, conforme segue:

1° Os que deambulam;

2° Os que serão resgatados sentados;

3º Os que serão resgatados deitados.

- A equipe de enfermagem irá encaminhar os pacientes para a porta de saída do setor, respeitando a ordem acima para que possam ser conduzidos pelas equipes de apoio às rotas de fuga, conforme o caso, e meios de transporte disponibilizados pela equipe assistencial (cadeira de rodas, cama ou maca).

b) Pacientes internados na UTI Adulta e UTI Neonatal:

- Avaliar os pacientes de acordo com o grau de dependência de drogas e equipamentos contínuos.
- Determinar os que poderão ser desconectados de equipamentos, drogas e outros acessos, autorizando sua liberação e condução pelas equipes de apoio, e os que aguardarão no setor o resgate pelos bombeiros.
- Se a condição permitir, os pacientes em ventilação mecânica deverão ser desconectados do ventilador e transportados com a utilização da unidade ventilatória ou com ventiladores de transporte, caso estejam disponíveis.
- Em caso do foco de incêndio ser no setor, a equipe assistencial irá deslocar os pacientes para a área próxima mais segura, conforme orientação dos brigadistas ou bombeiros, obedecendo à ordem de evacuação de forma inversamente proporcional à gravidade do caso.

c) Pacientes no Centro cirúrgico, Recuperação, Hospital dia, Hemodinâmica e Centro obstétrico:

- Os pacientes na sala de recuperação se houver necessidade, deverão ser transportados por profissionais médicos ou de enfermagem para área de segurança mais próxima, conforme orientação dos brigadistas ou bombeiros.
- Os pacientes na sala cirúrgica e hemodinâmica deverão ter seu procedimento interrompido de acordo com a gravidade da situação de emergência e a critério da equipe médica responsável, e colocados em condições de resgate pelos bombeiros.

8.2.4.2 Localização das macas para transporte

As macas rígidas para emergência possibilitam o resgate, através das escadas, de pessoas com mobilidade reduzida e que necessitem ser transportadas deitadas. As macas ficam disponíveis na estrutura horizontal nos corredores de acesso e próximo aos postos de enfermagem e na estrutura vertical no hall dos elevadores e escadas de emergência

8.2.5 Forma de locomoção

A partir da organização e seleção dos pacientes pelas lideranças da operação, as equipes de remoção conduzem o resgate, direcionando os pacientes conforme tabela de identificação.

8.2.5.1 Identificação de pacientes por forma de locomoção

TIPO DE LIMITAÇÃO	Não Deambula	Não Deambula	Não Deambula	Não Deambula
FORMA DE LOCOMOÇÃO	Deitado com aparelhos	Deitado	Sentado	Andando
PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA	Médico	Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	Qualquer pessoa
PROFISSIONAL QUE REMOVE	Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem, Equipe de Remoção	Equipes de Remoção e/ou Bombeiro	Equipes de Remoção	Equipes de Remoção
O QUE FAZER	Até o atendimento dos bombeiros, deve-se agilizar a transferência dos pacientes para outras unidades localizadas abaixo do pavimento sinistrado.	Equipes de Remoção os pacientes em cama/maca até o ponto de encontro utilizando a rota de fuga mais rápida.	Equipes de Remoção conduzem os pacientes em cadeira de rodas até o ponto de encontro utilizando a rota de fuga mais rápida.	Equipe de Remoção direcionam os pacientes para a rota de fuga mais rápida.

8.2.5.2 Condutas conforme classificação das necessidades

- **Pacientes com capacidade de locomoção reduzida**: com muletas ou bengalas podem usar as rampas ou escadas de modo independente: segura o corrimão com uma das mãos e com a outra mantém o seu instrumento de apoio.
- **Cadeira de rodas**: transportados pelas equipes de remoção através das rampas ou escadas.
- **Cardiorrespiratória / obesos**: pela dispneia, andando de forma lenta e com períodos de descanso. Em situações de necessidade de rapidez, deverão ser carregados pelas equipes de remoção em conjunto com os acompanhantes.
- **Visual**: equipes de remoção identificam-se em voz alta e com explicações claras e objetivas; indivíduo segura o ombro ou braço do outro com as mesmas condições darão a mão aquele primeiro. Mencionar escadas e rampas.

- **Auditiva**: estabelecer contato visual (apontar para cartazes, sinais luminosos, etc.) com o indivíduo e se possível manter-se em local iluminado de frente para a pessoa para facilitar a leitura labial.
- **Gestantes e idosos**: adotar as orientações daqueles com dificuldade de locomoção.
- **Crianças**: as de colo devem ser transportadas pelos acompanhantes devidamente orientados pela equipe, os que caminham, de mãos dadas com os adultos.

8.2.6 No ponto de encontro

Médico chefe da Equipe de resposta a emergência ou Médico Plantonista P1:

a) Estimar o número de pacientes que necessitarão de atendimento de urgência.

b) Avaliar, junto à Equipe, os pacientes quanto à gravidade.

c) Avaliar a necessidade de transferência de pacientes para outra instituição hospitalar acordada.

d) Providenciar esta transferência em transporte próprio ou contratado, previamente acordado.

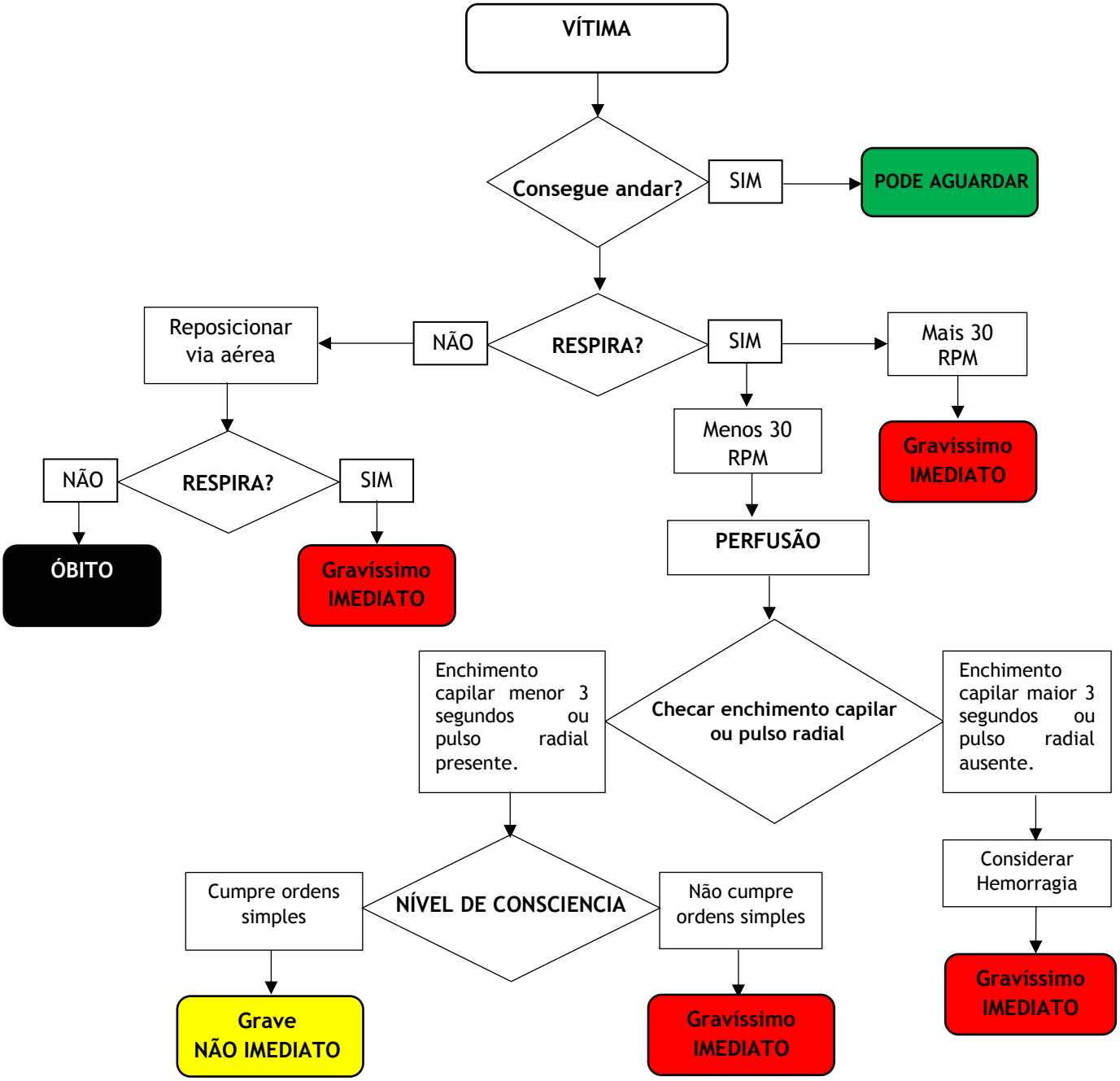
e) Aguardar ordem de liberação ou não do prédio a ser dada pelo Corpo de Bombeiros.

(1) Importante: Em caso de sinistro localizado e contido, os pacientes deverão ser remanejados para outras unidades de internação e/ou salas de recuperação de outros setores, de acordo com a orientação fornecida pelo setor de Atendimento Hospitalar que realiza a gestão dos leitos.

(2) Importante: Anualmente deverá ser realizado treinamento de remoção de pacientes por toda a equipe médica, de enfermagem e áreas de apoio.

9 ANEXOS

9.1 Anexo 1 – Método Start



9.2 Anexo 2 - Formulário do plano de resposta a catástrofes e atendimento a múltiplas vítimas

Formulário do Plano de Resposta a Catástrofes e Atendimento a Múltiplas Vítimas		Formulário Nº.
Data do registro: / /	Hora do registro:	Responsável pelo registro:
Local de ocorrência do evento:		
Descrição do Evento:		
Nível de Resposta:		
Resposta Nível I	Resposta Nível II	Resposta Nível III
Informação das Vítimas:		
1) Número total de vítimas do evento:		
2) Número total de vítimas recebidas no Hospital Unimed Chapecó:		
3) Número total de vítimas transferidas para outros hospitais:		
Ações durante e após o evento:		
Líder do Comitê de Gerenciamento de Crise:		
Médico Chefe Equipe de Resposta à Emergência:	Hora de registro do final do evento:	

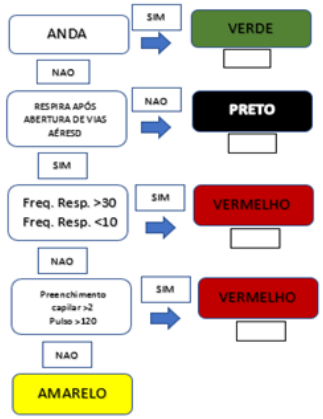
9.3 Anexo 3 – Instrumento de registro individual em casos de catástrofe - protocolo de Manchester

Unimed Chapecó

INSTRUMENTO DE REGISTRO - CATÁSTROFE
Classificação dos Casos

CASO Nº: DATA:

AVALIAÇÃO PRIMÁRIA



Escala TRTS		
FREQ. REP	10 a 29	4
	>29	3
	0 a 9	2
	1 a 5	1
	0	0
PRESSÃO ARTERIAL SISTEMICA	>90	4
	76 a 89	3
	50 a 75	2
	1 a 49	1
	0	0
ESCALA DE GLASGOW	10 a15	4
	9 a 12	3
	6 a 8	2
	4 a 5	1
	3	0

Escala de coma de Glasgow		
Abertura ocular	Espontânea	4
	Voz	3
	Dor	2
	S/ resposta	1
Resposta verbal	Orientado	5
	Confuso	4
	Inapropriado	3
	Imperceptível	2
	S/ resposta	1
Resposta motora	Ordem	6
	Localiza	5
	Fuga	4
	Flexão	3
	Extensão	2
	S/resposta	1

PRIORIDADE TRTS	
TRTS	COR
1 A 10	VERMELHO
11	AMARELO

Observação:

AVALIAÇÃO SECUNDARIA

HORA																		
	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS
Freq. Resp																		
P.A. Sist.																		
Glasgow																		
PRIORIDADE																		
ASS.																		
HORA																		
	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS
Freq. Resp																		
P.A. Sist.																		
Glasgow																		
PRIORIDADE																		
ASS.																		
HORA																		
	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS	AV	TRTS
Freq. Resp																		
P.A. Sist.																		
Glasgow																		
PRIORIDADE																		
ASS.																		
OBSERVAÇÃO	Na 1ª hora avaliar o paciente de 15/15', 2ª hora de 30/30'																	

9.4 Anexo 4 – Instrumento de registro médico e de enfermagem em catástrofes - protocolo Manchester

Unimed Chapecó	INSTRUMENTO DE REGISTRO - CATASTROFE Registros médicos	
Caso Nº:		Data: / /
Hora	Evolução médica	Prescrição Médica

Unimed Chapecó	INSTRUMENTO DE REGISTRO - CATASTROFE Registro de enfermagem	
Caso Nº:		Data: / /
Hora	Registro de enfermagem	

9.5 Anexo 5 – Comunicado à imprensa

HOSPITAL UNIMED CHAPECÓ	Nº de entradas até ao momento:
Comunicado nº:	Nº de vítimas Prioridade 1 – vermelhos:
Data ____/____/_____	Nº de vítimas Prioridade 2 – amarelos:
Hora: ___h ___m	Nº de vítimas Prioridade 3 – verdes:
Nome do comunicador _____	Nº de vítimas admitidas na internação:
Cargo do Comunicador _____	Nº de vítimas operadas:
Próximo comunicado Hora: ___h ___m	Nº de vítimas entradas na terapia intensiva:
	Nº de óbitos entrados:
	Local de informação às famílias:

9.6 Anexo 6 – Boletim de atendimento para emergência/desastre

FOTO	FICHA IDENTIFICAÇÃO DE VÍTIMA		Nº	xx
	Classificação **Vermelho** ☐ Laranja ☐ Amarelo ☐ Verde ☐ Azul ☐	**DATA E HORA CHEGADA**		
Nome	**Características:** alto, moreno, gordo, magro, tatuagem, brinco, pircing, qualquer característica física que possa vir a auxiliar na identificação da vítima.		☐ **Conciente** ☐ **Não Consciente**	
☐ Resgate ☐ Samu ☐ Bombeiro ☐ Meios próprios ☐ Outros _____ (Especificar)				
Tefone contato - parentesco	**Local onde permanece no hospital** ☐ Sala Emergência ☐ PA ☐ Centro Cirurgico ☐ UTI ☐ Outros: _____ _____		**Parente** ☐ Localizado Hora Hora ☐ Não localizado	
Vestimenta				
Observações				
Nome legível				

9.7 Anexo 9 - Listagem de fornecedores por área de insumos e serviços

LISTAGEM DE FORNECEDORES

1. SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

Fornecedor: Super Alfa
Tipo de Insumo: Gêneros não Perecíveis
email: auxiliar2.mercado022@cooperalfa.coop.br
Telefone: 49 3321-7090
Contato: Keli

Fornecedor: Mercado Líder
Tipo de Insumo: Carnes
email: mercadolider10@gmail.com
Telefone: 49 98805-0867
Contato: Adilson

Fornecedor: Bokitus
Tipo de Insumo: Pães
email: baccinbaccin1994@gmail.com
Telefone: 49 99824-3334
Contato: Fabio

Fornecedor: Aurora Alimentos
Tipo de Insumo: Carnes e Laticínios
email: gleiciomar-zinke@auroracoop.com.br
Telefone: 49 99979-0821
Contato: Fabio

Fornecedor: Frutas Real
Tipo de Insumo: Hortifrutigranjeiros
email: vendas05@frutasreal.com.br
Telefone: 49 98855-4704
Contato: Ana

Fornecedor: Sancapel
Tipo de Insumo: Produtos de limpeza
email: televendas3@sancapel.com.br
Telefone: 49 3462-8210
Contato: Nicoli

Fornecedor: Mil Embalagens
Tipo de Insumo: Descartáveis
email: comprasmilembalagens@gmail.com
Telefone: 49 3322-3009 / 49 98835-1275
Contato: Vilmar

Fornecedor: OMA
Tipo de Insumo: Refeições para pacientes e acompanhantes
email:omelhoralimento@gmail.com
Telefone: 49 98409-7199
Contato: Tatiana

2. HIGIENIZAÇÃO/LAVANDERIA

Fornecedor: Sancapel Soluções para Higiene Profissional
Tipo de Insumo: Produtos químicos / saneantes de higienização e lavanderia; Itens de higiene pessoal (papel toalha, papel higiênico, álcool spray, sabonete spray)
email:joao@sancapel.com.br;
Telefone: 49 3647-1268 / 49 99146- 2755 / 49 99960-3003
Contato: João Carlos Ramos,

Fornecedor: Orbenk
Tipo de Serviço: Mão de obra
email: comercial.chapeco@orbenk.com.br
gerencia.chapeco@com.br
Telefone: 49 3331-5030
Contato: Diogo

Fornecedor: Organizações Limger
Tipo de Serviço: Mão de obra
email: chapeco@organizacoeslimger.com.br
Telefone: 49 3328-9117
Contato: Katia ou Daniel

Fornecedor: Prática Serviços Gerais LUPA
Tipo de Serviço: Mão de obra
email: lupaserviços@inviolável.com
Telefone: 49) 3328 0016
Contato: Bruna

LISTAGEM DE FORNECEDORES

3. LABORATÓRIO

Fornecedor: Abbott
Tipo de insumo: Kits de reagentes, controles, calibradores, consumíveis e peças para equipamentos
email: carlos.tochio@abbott.com; atendimento1@abbott.com; pedidosadd@abbott.com
Telefone: 11 5536-7006 / 48 98833-1580 / 0800 11 9099
Contato: Carlos Tochio, Marli Gomes

Fornecedor: Laborsys
Tipo de insumo: Consumíveis e materiais para equipamentos (Sysmex, stago, roche)
email: laborsyscwb@laborsys.com.br; vendascwb@laborsys.com.br
Telefone: 41 3302-9070
Contato: Leandra Oliveira, Eliete Lopes

Fornecedor: Cepheid
Tipo de insumo: Kits de reagentes e materiais
email: cristane.guimaraes@cepheid.com
Telefone: 11 3524-8383
Contato: Cristiane L. Guimarães

Fornecedor: Sullab
Tipo de insumo: Placas, testes, materiais
email: pedido@sullab.com.br
Telefone: 51 3302-3433
Contato: Paola Costa, Daiana Miranda

Fornecedor: Bio-rad
Tipo de insumo: Reagentes
email:michelle_fracetti@bio-rad.com; andre_fontes@bio-rad.com; camila_souza@bio-rad.com
Telefone: 31 3689-6633 / 11 3065-7550 / 11 99342-5548 / 11 3957-8168 / 11 3065-7550 / 0800 200 8900
Contato: Michelle Fracetti, André Fontes, Camila Souza

Fornecedor: Werfen
Tipo de insumo: Insumos de gasometria e coagulação
email:patricia.fernandes@werfen.com; pedidosbr@werfen.com; sidnei.pedroso@werfen.com
Telefone: 11 94515-3515 / 11 4622-7878 / 0800 200 1038
Contato: Patricia Fernandes, Adriana Attie

Fornecedor: LCI Diagnósticos
Tipo de insumo: Tubos, placas, corantes, consumíveis, materiais em geral
email: vendasbr@lcidiagnosticos.com.br
Telefone: 41 3666-0234
Contato: Tayná Iensen

Fornecedor: Instituto Hermes Pardini
Tipo de insumo: Apoio
Site: mypardini.com.br
Telefone: 49 3312-1693

Fornecedor: Hospital Regional do Oeste
Tipo de insumo: Apoio
Telefone: 49 3322-3986

LISTAGEM DE FORNECEDORES

4. SAÚDE OCUPACIONAL

Fornecedor: Pingo Equipamentos de Segurança
Tipo de Insumo: Extintores de incêndio
email: vendas8@pingoequipamentos.com.br
Telefone: 49 3319-7900
Contato: Fabrício

Fornecedor: Pro-Tech
Tipo de Insumo: Respirador semi facial PFF2
email: vendas3@protech.ind.br
Telefone: 51 2470-0179
Contato: Didiara

Fornecedor: Live Comercio de materiais hospitalares
Tipo de Insumo: Luvas vinil power free LIVE
email: vendas01@livehs.com.br
Telefone: 47 3348-7866
Contato: Wagner

Fornecedor: Cosegur
Tipo de Insumo: Óculos proteção incolor antiembaçante
email: cosegur@cosegur.com.br
Telefone: 49 3323-0357
Contato: Dorvalino

5. SUPRIMENTOS

Fornecedor: Airliquid
Tipo de Insumo: Oxigênio líquido
email:cassiano.braghini@airliquide.com
Telefone: 49 3329-2029
Contato: Cassiano

Fornecedor: Vida Ativa Academia e Equipamentos
Tipo de Insumo: Colchonetes
email: loja@vidaativapremium.com.br
Telefone: 49 3323-0086 / 49 99964-3103
Contato: Georgia

6. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fornecedor: Inova Informática
Tipo de Insumo: Equipamento de informática
email: marin@inovainformatica.com.br
Telefone: 49 3319-3900
Contato: Mauricio Marin

Fornecedor: Indyxa Teiko
Tipo de Insumo: Equipamento de informática
email: suporte@indyxa.com.br
Telefone: 47 3035-3777
Contato: Suporte

Fornecedor: Patrimonial Segurança
Tipo de Insumo: Segurança patrimonial terceirizada
email: diomar.patrimonial@gmail.com
neori.lopes@patrimonialseguranca.com.br
Telefone: 49 3321-2222/ 49 99137-0129
Contato: Diomar / Neori

Fornecedor: Sati
Tipo de Insumo: Assistência técnica da central telefônica
email: alex@sati.com.br
Telefone: 49 3361-3600 / 49 8401-3600
Contato: Alex de Andrade

LISTAGEM DE FORNECEDORES

7. MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLÍNICA

Fornecedor: CASAN
Tipo de Insumo: Água potável
Telefone: 49 3321-2700 / 0800 643 0195

Fornecedor: CELESC
Tipo de Insumo: Energia elétrica
Telefone: 49 3323-6026 / 0800 480 196

Fornecedor: Leão Poços
Tipo de Insumo: Assistência técnica dos poços artesianos
email: assistencia@leaopocos.com.br
Telefone: 49 3323-1444 / 49 99987- 1444
Contato: Michel

Fornecedor: Profissional Engenharia
Tipo de Insumo: Assistência técnica dos geradores
email: gilmar@pengenharia.com.br
Telefone: 49 3322-4200 / 49 99987-8123 / 49 99987-4200 / 49 99987-8973
Contato: Milton, Gilmar, Cesar

Fornecedor: Safra Diesel
Tipo de Insumo: Combustível para geradores
email: vendas@safradiesel.com.br
Telefone: 49 99958-9464 / 49 98815-4564
Contato: Adelmo

Fornecedor: Schuermann
Tipo de Insumo: Ar comprimido
email: cristiano@schuermann.com.br
Telefone: 47 3288-8038 Ramal 213
Contato: Cristiano

Fornecedor: Liquigás
Tipo de Insumo: Gás GLP
email: lscastelo@liquigas.com.br
Telefone: 49 99142-9337
Contato: Luciano

Fornecedor: Lumagas
Tipo de Insumo: Assistência técnica em caso de vazamento de gás GLP
email: lumagasfinanceiro@outlook.com
Telefone: 49 98898-1111 / 49 99190-2553
Contato: Julio / Luis

Fornecedor: Hospitália Cirúrgica
Tipo de Insumo: Assistência técnica da CME
email:juliano.correia@hospitaliacirurgica.com.br
Telefone: 48 3035-6342 / 48 99148-5036
Contato: Juliano

Fornecedor: Hyundai
Tipo de Insumo: Manutenção de elevadores
Telefone: 0800 750 00 80 (via chamado)

Fornecedor: Elevasul
Tipo de Insumo: Assistência técnica elevadores
Telefone: 49 3322-3723
Contato: Alberto

8. FINANCEIRO

Fornecedor: Seguradora Chubb Seguros Brasil S.A
Tipo de Serviço: Seguro patrimonial
email: daniela.oliveira2@chubb.com
Telefone: 0800 703 66 65 / 11 4504-6912
Contato: Daniela

Fornecedor: Vida & Saude Corretora de Seguros (Seguros Unimed)
Tipo de Serviço: Seguro patrimonial
email: elaine@vidaesaudeseguros.com.br
Telefone: 48 4141-0713 / 48 99192-7905
Contato: Elaine

LISTAGEM DE FORNECEDORES

9. FARMÁCIA

Fornecedor: Mafra Hospitalar
Tipo de Insumo: Materiais e medicamentos
email: luciano.ferreira@mafrahospitalar.com.br vinicius.simizu@mafrahospitalar.com.br
Telefone: 43 3315-9451
Contato: Vinicius ou Luciano

Fornecedor: GAM (Genésio Mendes)
Tipo de Insumo: Medicamentos
email: daniel.stefani@gam.com.br
Telefone: 0800 601 3001 / 41 3072-8181
Contato: Vera ou Ronald

Fornecedor: ANB Farma
Tipo de Insumo: Medicamentos
email: hospitalar.sc@anbfarma.com.br
Telefone: 0800 643 6666/ 49 99925-7282
Contato: Daniel ou Felipe

Fornecedor: Soma Hospitalar
Tipo de Insumo: Materiais e medicamentos
email:soma.sc@somahospitalar.com.br
Telefone: 48 3348-2629 / 48 99943-6685
Contato: Tatiane ou Matheus

Fornecedor: Cirúrgica Santa Cruz
Tipo de Insumo: Materiais e medicamentos
email: jaline.silva@cirurgicasantacruz.com.br
Telefone: 51 2107-9000 / 48 99188-0623
Contato: Jaline ou Amanda

Fornecedor: Cirúrgica Jaw
Tipo de Insumo: Materiais e medicamentos
email: raphaela.castro@jaw.com.br
Telefone: 48 3557-5200 / 51 99309-3014
Contato: Raphaela ou Alexandra

Fornecedor: Merco
Tipo de Insumo: Nutrição enteral, suplementos, fórmulas infantis
email: licitacao@merco.far.br
Telefone: 41 3139-3866
Contato: Hellen

Fornecedor: Nutrir
Tipo de Insumo: Nutrição enteral, suplementos, fórmulas infantis
email: atendimento@nutrir-sc.com.br
Telefone: 49 3304-4757 / 49 99104-7222
Contato: Renata

Fornecedor: Center Nutri
Tipo de Insumo: Nutrição enteral, suplementos, fórmulas infantis
email: sonia@nutrimedical.com.br
Telefone: 41 3052-2108 / 49 99978-0265
Contato: Sônia e Cibeli

Fornecedor: Hospital Regional do Oeste
Tipo de Insumo: Empréstimo de medicamentos
Telefone: 49 3321-6604

Fornecedor: Hospital Materno Infantil
Tipo de Insumo: Empréstimo de medicamentos
Telefone: 49 2049-1700

Fornecedor: Hospital Regional São Paulo
Tipo de Insumo: Empréstimo de medicamentos
Telefone: 49 3441-7700

Fornecedor: Farmácia Preço Popular
Tipo de Insumo: Medicamentos
Telefone: 49 3324-3523
Contato: Atendentes

Fornecedor: Farmácia Sesi
Tipo de Insumo: Medicamentos
Telefone: 49 3324-1244
Contato: Atendentes

Fornecedor: Farmácia São João
Tipo de Insumo: Medicamentos
Telefone: 49 3324-7676
Contato: Atendentes

Fornecedor: Farmácia São Rafael
Tipo de Insumo: Medicamentos
Telefone: 49 3323-0050/ 3329-1684 (24h)
Contato: Atendentes

Fornecedor: Farmácia Catarinense
Tipo de Insumo: Medicamentos
Telefone: 49 3323-4500 (24h)
Contato: Atendentes

9.8 Anexo 10 - Procedimentos de aviso em caso de incêndio – setor de Telefonia

PROCEDIMENTOS DE AVISO EM CASO DE INCÊNDIO – SETOR DE TELEFONIA	
Evento: Ocorrência de incêndio interna. **Situação:** Telefonia é alertada pela sirene da brigada recebe a informação, via rádio, do Pronto Atendimento.	
PRINCÍPIO DE INCÊNDIO **1**. Caso seja solicitado pelo coordenador / chefe da brigada ou coordenador / técnico de manutenção ligar para os ramais próximos ao local e passar a **MENSAGEM DE ALERTA:** "Está ocorrendo um princípio de incêndio no setor **XXXX**. Ficar alerta para possível abandono". **2.** Repetir a ligação e passar a mensagem, pelo menos, mais 3 vezes.	**INCÊNDIO GENERALIZADO** **1**. Caso seja solicitado pelo coordenador / chefe da brigada ou coordenador / técnico de manutenção ligar para todos os setores, iniciando sempre pelos mais próximos do incêndio e passar a **MENSAGEM PARA EVACUAÇÃO:** "Está ocorrendo um incêndio no setor XXXX. Avise a todos que devem evacuar o prédio e se dirigir para um dos pontos de encontro". **Pontos de encontro:** PONTO 1: área externa, em frente ao Pronto Atendimento, na Rua Barão do Rio Branco. PONTO 2: área externa, em frente a Central de Serviços, na Rua Marechal Floriano Peixoto. PONTO 3:área externa, em frente ao Atendimento Hospitalar, na Rua Porto Alegre. **4.** Repetir a ligação e passar a mensagem, pelo menos, mais 10 vezes.

9.9 Anexo 11 – Procedimentos de segurança no abandono de edificação – População

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NO ABANDONO DE EDIFICAÇÃO - POPULAÇÃO	
ABANDONO DE EDIFICAÇÃO	**SITUAÇÕES DE ALTO RISCO**
• Manter a calma; • Seguir as orientações da Brigada de Incêndio; • Caminhar até a saída segura mais próxima, de forma rápida sem correria e atropelos; • Não empurrar; • Avisar os colegas que estão no setor; • Retirar calçados de salto para facilitar uma locomoção mais rápida; • Fechar portas e janelas ao sair, quando possível, para diminuir o oxigênio no local e evitar a propagação; • Acalmar colegas nervosos e descontrolados; • Não fazer brincadeiras, manter o foco; • Não retornar ao local para pegar qualquer objeto; • Não se afastar dos orientadores; • Não utilizar o elevador; • Não parar entre os andares, a menos que seja orientado para isso. • Descer sempre pelo lado direito da escada.	• Não tirar a roupa, pois ela servirá como uma barreira para o calor e contra a desidratação. Se possível, molhe-se; • Ao abrir uma porta, fazer isso bem devagar e com atenção. Se ela estiver quente não abra, pois o oxigênio alimenta a chama; • Quando houver presença de fumaça, cobrir o nariz com um pano molhado, pois dependendo do tipo e da quantidade de fumaça inalada, poderá ser fatal; • Se ficar preso em algum ambiente, procure molhar o local o máximo que conseguir para evitar que as chamas o alcance, e a si próprio a fim de baixar a temperatura corpórea; • Se o local estiver coberto por fumaça, tente molhar o chão e sair rastejando; • Caso seja impossível sair em segurança procure uma janela e fique acenando e gritando por socorro até que seja localizado; • Manter as portas fechadas, mas não trancadas para não dificultar o resgate.

REFERÊNCIAS

- Atendimento a Desastres: Manual de Treinamento – Projeto Trauma – 2000 – Hospital Sírio Libanês.

- Plano de Atendimento a Múltiplas Vítimas Hospital João XXIII. Belo Horizonte, 2018.

- Preparação para Emergências: Manual de Atendimento à Múltiplas Vítimas, Hospital Regional Unimed. Fortaleza, 2016.

- Manual para Preparação de Emergências, Hospital Regional Unimed. Fortaleza, 2016.

- Plano de Ação Emergencial, Hospital Universitário Maria Aparecida Predossian - HUMAP. Campo Grande-MG, 2017.

- BRASIL. Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Cartilha de Orientações básicas – Noções de prevenção contra incêndio. São Paulo, 2011.

- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Segurança Contra Incêndio em Instalações Assistências de Saúde. Brasília, 2014.

- Lei Estadual nº 7.592, de 13 de junho de 1989 – "Proíbe o uso de fumo em lugares fechados", em todo o território do Estado Santa Catarina".

- Lei Estadual nº 16.157, de 7 de novembro de 2013 - "Código de segurança contra incêndio e pânico", no âmbito do Estado de Santa Catarina".

- NBR 10898/90 - Iluminação de emergência.

- NBR 9441/94 - Sistemas de detecção e alarme.

- NBR 9077/93 - Saídas de emergência.

- NBR 13434/95, NBR 13435/95 e NBR 13437/95 – Sinalização.

- NBR 11742 - Porta corta-fogo para saídas de emergência.

- https://butantan.gov.br/covid/butantan-tira-duvida/tira-duvida-noticias/entenda-o-que-e-uma-pandemia-e-as-diferencas-entre-surto-epidemia-e-endemia

TERMO DE APROVAÇÃO DO MANUAL DE GESTÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES

Este documento é emitido em via impressa e digital. A via impressa é assinada pelos responsáveis pela elaboração e aprovação do Manual, ficando arquivada no setor de Saúde Ocupacional do Complexo Unimed Chapecó.

Chapecó, SC, agosto de 2022.

_____
Coord. Saúde Ocupacional

_____
Téc. Seg. do Trabalho

_____
Líder do
Comitê de Gerenciamento de Crise